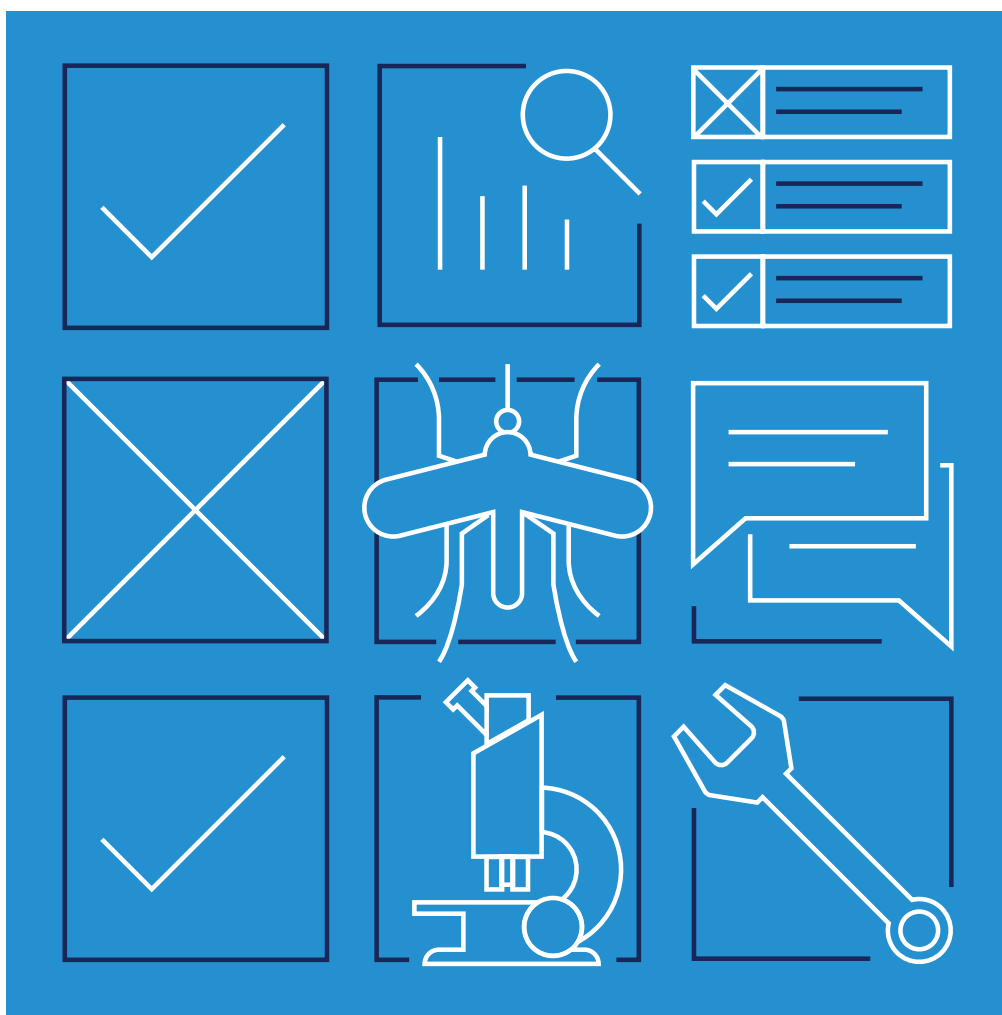

Boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme

Guide de mise en œuvre de référence,
deuxième édition



Organisation
mondiale de la Santé

Boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme

**Guide de mise en œuvre de référence,
deuxième édition**



**Organisation
mondiale de la Santé**

Boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme : guide de mise en œuvre de référence, deuxième édition [Malaria surveillance assessment toolkit: implementation reference guide, second edition]

ISBN 978-92-4-011595-8 (version électronique)

ISBN 978-92-4-011596-5 (version imprimée)

© **Organisation mondiale de la Santé 2025**

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme : guide de mise en œuvre de référence, deuxième édition [Malaria surveillance assessment toolkit: implementation reference guide, second edition]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2025. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <https://iris.who.int/?locale-attribute=fr&>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <https://www.who.int/publications/book-orders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <https://www.who.int/fr/copyright>.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Table des matières

Remerciements	v
Acronymes	vi
Glossaire	vii
Résumé d'orientation	xi
Partie A: Présentation générale	1
Partie B: Guide de mise en œuvre détaillé	10
Phase 1: Lancement de l'évaluation	14
1.1 Établir un comité d'orientation composé des principales parties prenantes qui participent à la conception et à la mise en œuvre de l'évaluation	14
1.2 Rédiger et modifier une note de synthèse et/ou un protocole pour l'évaluation	17
1.3 Adapter les outils de collecte de données	25
Phase 2: Collecte et examen des données	27
2.1 Effectuer une analyse documentaire	27
2.2 Effectuer un contrôle de la qualité des données (CQD)	31
2.3 Mener une enquête auprès du personnel de surveillance à tous les niveaux concernés du système de santé (agents de santé communautaires, établissements de santé et hôpitaux, bureaux de district/régionaux)	43
Phase 3: Analyse des données et élaboration des résultats	48
3.1 Résultats de l'analyse documentaire	49
3.2 Résultats du CQD au niveau documentaire	50
3.3 Agréger et analyser les données du CQD au niveau de la prestation de services	51
3.4 Gérer et nettoyer les données d'enquête	52
3.5 Utiliser les tableaux de plan d'analyse pour capturer les résultats des données d'enquête	52
3.6 Fiche d'évaluation et tableaux de bord	52

Phase 4: Priorisation des recommandations et diffusion	55
4.1 Préparer le rapport final, la note technique et la présentation de débriefing	55
4.2 Élaborer et prioriser des recommandations avec le comité d'orientation en fonction des résultats	56
4.3 Élaborer un plan d'action pour combler les lacunes prioritaires	58
Références bibliographiques	61
Pour en savoir plus	62
Annexes	63
Annexe 1. Liste de contrôle suggérée pour les parties prenantes et/ou les personnes interrogées	64
Annexe 2. Liste de contrôle des documents suggérés	67
Annexe 3. Variables et indicateurs de base du paludisme	73
Annexe 4. Variables de base pour le CQD	82
Annexe 5. Vérifications de la cohérence entre les variables de base pour le CQD	90
Annexe 6. Vérifications de la cohérence des indicateurs de base au fil du temps pour le CQD	91

Remerciements

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) exprime sa gratitude aux membres actuels et anciens suivants du personnel du Programme mondial de lutte contre le paludisme pour leurs contributions techniques à l'élaboration de la première édition de la Boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme, telle que décrite dans ce guide de référence : Laura Anderson, Amy Barrette, Chan Yuen Ching, Tamara Ehler, Beatriz Galatas, Xiao Hong Li, Kimberly Lindblade, Mwalenga Nghipumbwa, Deepa Pindolia, Amanda Tiffany, Ryan Williams et Katelyn Woolheater. Laura Anderson était cheffe de projet, sous la supervision d'Abdisalan Noor.

L'OMS tient également à remercier les participants à la consultation technique portant sur l'évaluation des systèmes de surveillance, organisée par l'OMS en décembre 2018. Leurs commentaires ont joué un rôle déterminant dans la conceptualisation du projet et l'examen de la première version de la boîte à outils. Ces contributeurs étaient : John Aponte, Maru Aregawi, Gawrie Galappaththy, Xiao Hong Li, Kimberly Lindblade, Abdisalan Noor et Ryan Williams (Programme mondial de lutte contre le paludisme de l'OMS) ; Ebenezer Baba (Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique) ; Jeff Bernson (PATH, États-Unis d'Amérique) ; Chris Cotter (Université de Californie, San Francisco) ; Erin Eckert (RTI International, États-Unis d'Amérique) ; Jordi Landier (Unité de recherche sur le paludisme de Shoklo, Thaïlande) ; Neel Lakhani (Clinton Health Access Initiative, Boston, États-Unis d'Amérique) ; John Painter (United States Centers for Disease Control and Prevention, États-Unis d'Amérique) ; Arantxa Roca-Feltrer (Malaria Consortium, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ; Francisco Saute (Centro de Investigação em Saúde Manhica, Mozambique) ; et Yazoume Ye (ICF, États-Unis d'Amérique).

L'OMS remercie la Clinton Health Access Initiative pour sa contribution à l'élaboration de la boîte à outils. En particulier, Arnaud Le Menach, Deepa Pindolia et Katelyn Woolheater ont dirigé la formulation initiale, avec des contributions supplémentaires de Sameen Babur, Dominic Lucero, Thibaud de Chevigny, Elijah Filip, Emmanuel Yovo, Abigail Ward et Julia Dunn.

Nous remercions tout particulièrement les personnes suivantes pour les commentaires qu'elles ont formulés au cours du processus de développement : Ruth Ashton et Thomas Eisele (Université de Tulane, États-Unis d'Amérique) ; Anna Bowen (United States Centers for Disease Control and Prevention, États-Unis d'Amérique) ; Adam Bennett (PATH, États-Unis d'Amérique) ; Neil Lobo et Allison Tatarsky (Université de Californie, San Francisco, États-Unis d'Amérique) ; David Boone (John Snow Inc., États-Unis d'Amérique) ; Misun Choi et Lia Florey (U.S. President's Malaria Initiative, États-Unis d'Amérique) ; Michael Hainsworth (PATH, États-Unis d'Amérique) ; et Christopher Lourenco (Population Services International, États-Unis d'Amérique). Tous les commentaires ont été reçus entre 2020 et 2022.

Enfin, l'OMS exprime sa sincère gratitude aux programmes nationaux de lutte contre le paludisme et à leurs partenaires au Burkina Faso, au Bénin, au Cameroun, au Ghana et en République démocratique du Congo qui étaient chargés de la mise en œuvre pilote de la boîte à outils et ont fourni des informations précieuses.

L'OMS exprime sa gratitude aux membres actuels du personnel du Programme mondial de lutte contre le paludisme pour leurs contributions techniques à l'élaboration de la deuxième édition de la Boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme, telle que décrite dans ce guide de référence : Laura Anderson, Tamara Ehler et Deepa Pindolia.

Cette boîte à outils a été produite avec le soutien financier de la Fondation Gates.

Acronymes

AMM	administration de masse de médicaments
CEE	comité d'évaluation éthique
CIM	classification internationale des maladies
CPS	chimioprévention du paludisme saisonnier
CQD	contrôle de la qualité des données
CTA	combinaison thérapeutique à base d'artémisinine
DHIS	logiciel d'information sanitaire de district
DHS	enquête démographique et sanitaire
EQD	examen de la qualité des données
ES	établissement de santé
iDES	surveillance intégrée de l'efficacité des médicaments
MFL	liste de référence des établissements de santé
MON	mode opératoire normalisé
ODK	Open Data Kit
OMS	Organisation mondiale de la Santé
P.	<i>Plasmodium</i> (<i>P. falciparum</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. knowlesi</i> et <i>P. vivax</i>)
PNLP	programme national de lutte contre le paludisme
PSN	plan stratégique national
QD	qualité des données
RPP	revue du programme paludisme
SARA	évaluation de la préparation et de la disponibilité des services
SGIS	système de gestion de l'information sanitaire
SIMR	surveillance intégrée de la maladie et riposte
TDR	test de diagnostic rapide
TET	tests d'efficacité thérapeutique
TPIg	traitement préventif intermittent pendant la grossesse
TPIn	traitement préventif intermittent du nourrisson

Glossaire

Sauf indication contraire, les définitions sont tirées du manuel de référence *Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation (1)* et de la *Terminologie OMS du paludisme, mise à jour de 2021 (2)*.

Terme	Définition
Cas de paludisme	Apparition de l'infection palustre chez une personne chez qui la présence de plasmodies dans le sang a été confirmée par un test de diagnostic. <i>Note</i> : Un cas suspect ne peut pas être considéré comme un cas de paludisme tant qu'il n'y a pas eu confirmation parasitologique. Un cas de paludisme peut être classé comme importé, autochtone, induit, introduit, de rechute ou de recrudescence (en fonction de l'origine de l'infection), et comme symptomatique ou asymptomatique. Dans les contextes de lutte contre le paludisme, un « cas » est l'apparition d'une infection palustre confirmée associée à une affection ou une maladie. Dans les régions où l'on cherche à éliminer activement la maladie ou lorsqu'elle a été éliminée, un « cas » correspond à l'apparition de toute infection palustre confirmée, avec ou sans symptômes.
Détection active des cas	Détection des cas de paludisme par des agents de santé au niveau des communautés et des ménages, parfois dans des groupes de population considérés comme à haut risque. La détection active des cas peut consister en un dépistage des personnes fébriles suivi d'un examen parasitologique de tous les patients trouvés fébriles ou en un examen parasitologique d'une population cible, sans dépistage préalable de la fièvre. <i>Note</i> : La détection active des cas peut être entreprise en réponse à un cas ou un groupe de cas confirmés, avec dépistage de la population potentiellement liée à ces cas (faisant référence à la « détection réactive des cas »), ou peut être entreprise chez les groupes à haut risque, sans relation avec la détection de cas (faisant référence à la « détection proactive des cas »).
Détection des cas	L'une des activités des opérations de surveillance, comportant la recherche des cas de paludisme dans une communauté. <i>Note</i> : La détection des cas est un processus de dépistage au cours duquel la présence de fièvre ou de caractéristiques épidémiologiques, telles que des situations ou des groupes à risque élevé, représente l'élément indicateur. Il s'avère nécessaire d'avoir recours à un test de diagnostic afin de détecter les infections palustres asymptomatiques.
Détection passive des cas	Détection de cas de paludisme chez des patients qui se rendent d'eux-mêmes dans des services de santé pour être diagnostiqués et traités, le plus souvent pour une affection fébrile.

Évaluation de la surveillance du paludisme	Une approche systématique de l'évaluation des systèmes de surveillance existants, comprenant notamment l'évaluation des performances des systèmes et la compréhension des déterminants de ces performances, dans le but de fournir des recommandations exploitables et priorisées sur la manière de renforcer le système de surveillance des activités de lutte contre le paludisme en vue de son élimination.
Investigation des cas	Collecte d'informations destinée à permettre la classification d'un cas de paludisme en fonction de l'origine de l'infection, c'est-à-dire selon qu'il s'agit d'un cas importé, autochtone, induit, introduit, de rechute ou de recrudescence. <i>Note</i> : L'investigation des cas peut comprendre l'administration d'un questionnaire standardisé à une personne chez qui une infection palustre est diagnostiquée, ainsi que le dépistage et le test des personnes vivant dans le même foyer ou dans des zones environnantes.
Investigation des foyers	Collecte d'informations permettant de classer un foyer de paludisme (une localité définie et délimitée située dans une zone actuellement ou anciennement impaludée où prévalent les conditions épidémiologiques et écologiques nécessaires à la transmission du paludisme) par type : à savoir actif, résiduel, non actif ou éliminé. <i>Note</i> : L'investigation des foyers peut inclure des éléments épidémiologiques (par le biais d'une investigation des cas ou d'une détection active des cas) ou peut être mise en œuvre de manière autonome dans le but de comprendre les déterminants de la transmission entomologiques, environnementaux et interventionnels. L'objectif est d'identifier les principales caractéristiques de la région du foyer, notamment les populations les plus à risque, les taux d'infection ou de maladie, la répartition des vecteurs responsables de la transmission du paludisme et les conditions sous-jacentes qui favorisent cette transmission.
Niveau de la prestation de services	Terme désignant l'ensemble des lieux de prestation de services de diagnostic et de traitement (hôpitaux, établissements de santé publics et privés, laboratoires, agents de santé communautaires) aux niveaux infranationaux (p. ex., établissement, district, région).
Niveau infranational	Terme désignant tous les niveaux inférieurs au niveau national (p. ex., province, région, état, district, commune).
Suivi des produits de base	La collecte, l'analyse et l'interprétation continues et systématiques de données sur les produits de base destinés à la lutte contre le paludisme (p. ex., tests de diagnostic rapide, traitement) dans le but d'éclairer la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Suivi et évaluation	Le suivi est un processus continu qui consiste à collecter et à utiliser des données sur la mise en œuvre des programmes (de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle), dans le but de vérifier que les programmes fonctionnent de manière satisfaisante et de procéder à des ajustements, le cas échéant. Le processus de suivi a souvent recours à des données administratives pour évaluer les apports, les processus et les services produits, même s'il peut également porter sur les résultats et les impacts programmatiques. L'évaluation est une appréciation plus complète d'un programme ; elle est habituellement entreprise à des périodes définies et porte essentiellement sur les résultats et les impacts à plus long terme. L'objectif général du suivi et de l'évaluation est d'améliorer l'efficacité, l'efficience et l'équité des programmes.
Surveillance (4)	La collecte, l'analyse et l'interprétation continues et systématiques de données spécifiques sur la maladie, et l'utilisation de ces données pour la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des pratiques de santé publique. <i>Note</i> : La surveillance peut être effectuée à différents niveaux du système de santé (p. ex., établissements de santé, communauté), en utilisant différents systèmes de détection (p. ex., détection active ou passive fondée sur les cas) et différentes stratégies d'échantillonnage (p. ex., sites sentinelles, enquêtes).
Surveillance agrégée (1)	Pratique consistant à enregistrer et/ou à communiquer des données agrégées dans le temps de tous les cas confirmés de paludisme au cours d'une période donnée. Dans la plupart des cas de surveillance agrégée du paludisme, les cas sont additionnés chaque semaine ou chaque mois et notifiés au niveau des districts, des provinces et du pays sous forme de nombre de cas par établissement de santé et par unité de temps.
Surveillance du paludisme	La collecte, l'analyse, l'interprétation et l'utilisation continues et systématiques des données sur le paludisme et des données connexes. <i>Note</i> : Il peut s'agir d'un système spécifique au paludisme ou d'une composante de la surveillance intégrée des maladies (p. ex., SIS, système de SIMR). Il peut s'agir de rapports au cas par cas ou de rapports agrégés (hebdomadaires ou mensuels). La surveillance du paludisme peut également inclure des stratégies supplémentaires qui appuient la planification, la mise en œuvre et l'évaluation du programme de lutte contre le paludisme, telles que la surveillance entomologique, le suivi des produits de base, le suivi et l'évaluation des interventions, l'alerte précoce et le suivi des épidémies, et le suivi de la résistance aux insecticides et aux médicaments.

Surveillance entomologique	La collecte, l'analyse et l'interprétation continues et systématiques de données entomologiques pour l'évaluation des risques, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des interventions de lutte antivectorielle.
Surveillance fondée sur l'identification des cas (3)	Pratique consistant à enregistrer et à communiquer les données concernant les patients pour tous les cas confirmés de paludisme. <i>Note :</i> Dans la plupart des cas de surveillance fondée sur les cas, chaque cas confirmé de paludisme est immédiatement notifié au niveau des districts, des provinces et du pays. Une enquête complète de chaque cas est menée pour déterminer s'il s'agit d'un cas importé, acquis localement résultant d'une transmission par les moustiques (introduit, autochtone, de rechute) ou induit.
Surveillance intégrée de la maladie et riposte (SIMR)	Système et cadre de notification permettant d'intégrer plusieurs systèmes de surveillance et d'intervention pour les principales maladies à déclaration obligatoire, et d'établir un lien entre les données de surveillance, les données de laboratoire et d'autres données et l'action de santé publique (4).
Système de gestion de l'information sanitaire (SGIS)	Un système conçu pour enregistrer, stocker, récupérer et traiter les données sur la santé afin de surveiller et d'évaluer les prestataires et les organisations de soins, et de soutenir leurs principaux processus décisionnels. Cela comprend : • la collecte et la gestion de l'information sur la santé et la prestation de services à tous les niveaux ; • la vérification, le traitement et l'analyse des données collectées ; • l'utilisation d'indicateurs et d'informations pertinentes pour appuyer la gestion du programme et le processus décisionnel ; et • la diffusion des informations sur la santé (p. ex., rapports annuels, bulletins, sites Web).

Résumé d'orientation

La *Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016–2030* (5) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) met l'accent sur la surveillance en tant qu'intervention essentielle pour accélérer les progrès vers l'élimination du paludisme dans les zones d'endémie. Le document *Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence* (1) fournit des orientations sur les principes et les exigences d'un système de surveillance du paludisme solide. L'OMS recommande que les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, avec l'appui des organisations partenaires, entreprennent des évaluations de surveillance du paludisme pour déterminer si les pays répondent aux exigences énoncées dans le manuel, en vue d'aboutir à des recommandations fondées sur des données probantes et priorisées sur le renforcement des systèmes de surveillance.

À ce jour, des évaluations de la surveillance du paludisme ont été mises en œuvre dans de nombreux pays et dans divers contextes de transmission dans le but commun d'améliorer les performances des systèmes de surveillance. Cependant, les approches et les outils antérieurs n'étaient pas facilement adaptables à tous les stades de la transmission du paludisme et n'étaient pas normalisés dans l'ensemble des pays ou dans le temps. La boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme a donc été élaborée, en s'appuyant sur les meilleures pratiques des évaluations précédentes. L'objectif était d'harmoniser et d'adapter les outils disponibles afin d'obtenir un seul ensemble normalisé pouvant être utilisé pour effectuer des évaluations de surveillance du paludisme dans tous les contextes de transmission. L'utilisation de ces outils normalisés permet de comparer les résultats entre les pays et au sein d'un même pays au fil du temps, ce qui permet aux pays de suivre leurs progrès vers le renforcement des systèmes de surveillance. La boîte à outils est accessible par l'intermédiaire d'une plateforme numérique (<https://malsurtoolkit.who.int>).

Cette deuxième édition du document Boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme, Guide de mise en œuvre de référence, est un document de référence complet ainsi qu'un guide détaillé pour la réalisation d'évaluations de surveillance.

Approche de l'élaboration

La boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme a été initialement élaborée par le Programme mondial de lutte contre le paludisme de l'OMS en collaboration avec la Clinton Health Access Initiative, en s'appuyant sur un examen des outils d'évaluation de la surveillance disponibles, sur les contributions d'experts et sur les enseignements tirés des évaluations antérieures dans les pays. La mise en œuvre pilote de la boîte à outils a été effectuée au Burkina Faso, au Ghana et en République démocratique du Congo ; les outils ont par la suite été affinés sur la base des commentaires des programmes nationaux de lutte contre le paludisme et des experts en surveillance.

Une consultation technique organisée par l'OMS en décembre 2018 a contribué davantage au contenu, en veillant à ce qu'il soit aligné sur les besoins des pays et les priorités mondiales en matière de surveillance. La boîte à outils a été examinée par les bureaux régionaux de l'OMS et des experts indépendants, et finalisée à la suite des commentaires de pairs.

Cette deuxième édition du guide de mise en œuvre de référence de la boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme comprend des images actualisées qui reflètent la dernière version de la boîte à outils de surveillance numérique. Ces mises à jour permettent d'assurer que le guide représente fidèlement la plateforme actuelle et ses fonctionnalités.

Tous les experts externes impliqués dans l'élaboration de la boîte à outils ont soumis des déclarations d'intérêts, qui ont été examinées par l'OMS. Aucun conflit pouvant nuire à leur objectivité ou à leur indépendance n'a été identifié.

Partie A. Présentation générale

Contexte et justification

La *Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030* (5) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) met l'accent sur la surveillance en tant qu'intervention essentielle pour accélérer les progrès vers l'élimination du paludisme dans les zones d'endémie. Des systèmes de surveillance robustes sont nécessaires pour suivre avec précision et fiabilité la charge du paludisme, contrôler la mise en œuvre des interventions visant à réduire les cas et les décès, et évaluer leur impact.

Le document *Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence* (1) fournit des orientations sur les principes et les exigences d'une surveillance efficace du paludisme. L'évaluation régulière des systèmes de surveillance existants est un principe fondamental recommandé à tous les stades de la transmission du paludisme.

Qu'est-ce qu'une évaluation de surveillance du paludisme et quelle en est l'importance ?

Une évaluation de la surveillance du paludisme est une approche systématique permettant de mesurer les performances des systèmes de surveillance de la maladie ainsi que d'identifier et d'évaluer les déterminants de ces performances. Dans la plupart des zones d'endémie, la surveillance du paludisme est pleinement intégrée à la surveillance d'autres maladies effectuée dans le cadre du système de gestion de l'information sanitaire (SGIS) ; dans d'autres contextes, il peut exister un système d'information distinct pour le paludisme. Une évaluation de la surveillance du paludisme doit être effectuée en utilisant le ou les systèmes existants de détection des cas et des décès dus à la maladie, et peut relever d'une évaluation plus vaste du SGIS. Les résultats des évaluations de la surveillance du paludisme peuvent être utilisés pour fournir des recommandations exploitables et priorisées sur la manière de renforcer les systèmes de surveillance des activités de lutte contre la maladie en vue de son élimination. Les programmes nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP) et/ou les SGIS peuvent utiliser ces résultats pour la planification et la mise en œuvre des programmes. Dans les contextes d'élimination, une évaluation de la surveillance peut aider le pays à préparer la documentation et à contrôler la qualité des données avant d'entamer le processus de certification de l'élimination du paludisme.

Quand faut-il procéder à une évaluation de la surveillance du paludisme ?

Une évaluation de la surveillance du paludisme peut être entreprise à tout moment. Il est recommandé qu'elle soit mise en œuvre dans le cadre des principales étapes de la planification du PNLP, telles que la revue du programme paludisme (RPP) et l'élaboration d'un plan stratégique national (PSN). L'objectif est de veiller à ce que les principales recommandations et les activités connexes pour le renforcement des systèmes de surveillance soient correctement priorisées et dotées de ressources suffisantes en les intégrant dans les PSN et les demandes de subventions du Fonds mondial, le cas échéant. À la suite de l'évaluation initiale de la surveillance, des contrôles plus fréquents et réguliers peuvent être entrepris (p. ex. annuellement) pour suivre les progrès vers le renforcement du système de surveillance, fournir un retour d'information aux personnels concernés et redéfinir l'ordre de priorité des activités de surveillance, au besoin. Dans les contextes d'élimination, il est recommandé d'effectuer une évaluation avant d'entamer le processus de certification de l'élimination du paludisme.

Qui doit procéder à une évaluation de la surveillance du paludisme ?

Tous les pays d'endémie palustre doivent entreprendre une évaluation du système de surveillance, quelle que soit la charge du paludisme. Une évaluation nationale pour les contextes d'élimination est recommandée lorsque le pays compte moins de 100 cas de paludisme et/ou après trois ans de déclaration de zéro cas. L'évaluation doit également déterminer s'il existe un programme visant à prévenir la réapparition du paludisme. Pour les pays comptant plus de 100 cas, une évaluation de la surveillance de l'élimination peut être effectuée dans les zones où des activités d'élimination sont menées au niveau infranational.

Les évaluations de la surveillance doivent être effectuées par les PNLP et/ou les SGIS dans les pays, et peuvent être appuyées par des partenaires (OMS, donateurs et partenaires d'exécution). Il est recommandé qu'un comité d'orientation composé des principaux acteurs de la surveillance du paludisme soit mis en place pour chaque évaluation.

Pourquoi était-il nécessaire d'élaborer une boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme ?

À ce jour, de nombreuses évaluations de la surveillance du paludisme ont été entreprises dans les zones d'endémie palustre dans le but commun de permettre aux pays d'améliorer les performances du système de surveillance (6, 7, 8), mais en utilisant une variété d'outils et d'approches. En l'absence d'outils normalisés, il est difficile de comparer les résultats entre les pays, entre les régions d'un même pays ou au fil du temps dans une région géographique donnée. Pour résoudre ce problème, une boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme normalisée a donc été mise au point et peut être consultée par l'intermédiaire d'une plateforme numérique (<https://malsurtoolkit.who.int>).

Pour quelles évaluations la boîte à outils est-elle utilisée ?

Qu'il s'agisse d'un contexte de réduction de la charge ou d'élimination, la boîte à outils évalue principalement dans quelle mesure le système de surveillance du paludisme capture les cas et les décès qui sont attribuables à la maladie. Elle peut également servir pour l'évaluation de haut niveau de la surveillance des interventions et des stratégies de lutte contre le paludisme dans le cadre plus général du système de surveillance intégré.

La boîte à outils évalue quatre objectifs de la surveillance du paludisme (Tableau 1):

- (1) Performance
- (2) Contexte et infrastructure
- (3) Technique et processus
- (4) Comportement

Le Tableau 1 décrit les quatre objectifs et les sous-objectifs qui leur sont associés. Chaque sous-objectif est évalué à l'aide de plusieurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui sont classés comme « prioritaires » ou « facultatifs ». Les indicateurs prioritaires constituent un ensemble minimum d'indicateurs devant être inclus dans toutes les évaluations. Ils fournissent des résultats normalisés qui permettent des comparaisons entre les pays et au sein des pays au fil du temps.

Tableau 1. Aperçu du cadre d'évaluation

Objectif ou sous-objectif	Nom	Description	Nombre d'indicateurs
<i>Produits/performance de la surveillance du paludisme</i>			
1	Performance	Mesurer la performance du système de surveillance	30
1.1	Couverture du système de surveillance	Évaluer si les cas de paludisme et les décès associés sont capturés avec précision par la surveillance à chaque niveau du système de santé	9
1.2	Qualité des données	Mesurer la qualité des données collectées au niveau de la prestation de services et communiquées aux niveaux national et sous-national (exhaustivité, ponctualité, concordance et cohérence)	14
1.3	Utilisation des données	Identifier les preuves d'une planification programmatique basée sur des données et de l'utilisation des données pour la prise de décision	7
<i>Intrants/déterminants de la performance de la surveillance du paludisme</i>			
2	Contexte et infrastructures	Décrire et évaluer les aspects contextuels et infrastructurels de la surveillance pouvant influencer la performance. Cela comprend une évaluation des rapports des secteurs de la santé, si des données minimales sont saisies pour la lutte contre le paludisme et les interventions et stratégies mises en œuvre dans le pays, les systèmes d'information utilisés, la disponibilité et le respect des directives, les ressources humaines et financières et les infrastructures.	17
2.1	Secteurs et stratégies de surveillance	Décrire la surveillance des stratégies de lutte contre le paludisme et les secteurs notifiant les indicateurs clés à chaque niveau du système de santé, et évaluer les définitions et algorithmes utilisés	4
2.2	Systèmes d'information	Décrire les systèmes d'information utilisés pour la surveillance du paludisme et évaluer leur flexibilité, acceptabilité, fonctionnalité et interopérabilité/intégration	6
2.3	Directives et modes opératoires normalisés (MON)	Évaluer la disponibilité et le contenu des documents clés (directives, manuels de procédures et réglementations) pour la surveillance du paludisme	2
2.4	Ressources	Identifier le personnel, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la surveillance du paludisme et évaluer ce qui est disponible à tous les niveaux du système de santé	4
2.5	Aide financière	Décrire le budget disponible pour la surveillance du paludisme et identifier les éventuels manques de financement	1
3	Technique et processus	Décrire et évaluer les processus et les aspects techniques du système de surveillance pouvant influencer la performance. Cela comprend une évaluation des processus, des outils et du personnel impliqués dans le flux et l'utilisation des données, depuis l'enregistrement jusqu'à l'intervention.	22

Objectif ou sous-objectif	Nom	Description	Nombre d'indicateurs
3.1	Gestion des cas	Évaluer la gestion des cas, y compris l'utilisation normalisée des définitions de cas et des produits adéquats pour le dépistage et le traitement	3
3.2	Enregistrement	Décrire et évaluer les processus d'enregistrement des données (p. ex., les outils, le personnel et la fréquence de chaque type de point de service)	4
3.3	Notification	Décrire et évaluer le flux d'informations à travers le système de surveillance (p. ex., les outils, le personnel et la fréquence à chaque niveau du système de santé)	5
3.4	Analyse	Décrire et évaluer le processus d'analyse et les produits attendus	3
3.5	Assurance qualité	Décrire et évaluer les activités, les processus de retour d'informations et les mécanismes en place pour assurer la qualité des données (c.-à-d. le nettoyage des données, la supervision, les évaluations de la qualité des données et les réunions de revue des données, y compris la recherche de doublons et le contrôle de la cohérence interne)	4
3.6	Accès aux données	Décrire et évaluer l'accès aux données dans le système de surveillance (accès à la base de données ou demande, personnel, fréquence)	3
4	Comportement	Décrire et évaluer les aspects comportementaux du système de surveillance qui peuvent influencer la performance. Cela comprend une évaluation des structures de gouvernance en place et la promotion d'une culture de l'information, ainsi que la compétence, la motivation et la responsabilité du personnel impliqué dans la surveillance du paludisme dans un pays.	12
4.1	Gouvernance	Déterminer les structures de gouvernance en place pour la surveillance du paludisme, y compris la planification documentée, les cibles et la structure organisationnelle, ainsi que la surveillance externe	3
4.2	Promotion d'une culture de l'information	Déterminer les processus en place pour promouvoir une culture d'utilisation des données et les perceptions qui en découlent parmi le personnel de surveillance (c.-à-d., le personnel est-il encouragé à utiliser les données et motivé à produire des données de qualité ?)	2
4.3	Supervision	Décrire et évaluer les processus en place pour la supervision et la gestion du personnel de surveillance	3
4.4	Compétence du personnel de surveillance	Déterminer les processus en place et les perceptions qui en découlent concernant la compétence professionnelle du personnel de surveillance (c.-à-d., le personnel est-il compétent pour les tâches de surveillance désignées et comment ? [p. ex., formation/documentation])	4

Les outils de collecte de données sont conçus pour recueillir les données nécessaires pour mesurer chaque indicateur. Une fois que les indicateurs de l'évaluation ont été sélectionnés, le contenu des outils est automatiquement choisi de sorte à capturer les informations se rapportant uniquement à ces indicateurs. Certains des outils d'évaluation peuvent exiger une contextualisation supplémentaire pour le pays (p. ex., changer les noms des variables pour refléter les termes utilisés dans le pays, traduction dans les langues locales ; voir la section 1.3.1).

Quel est le contenu de la boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme ?

La boîte à outils fournit un cadre d'évaluation complet mais adaptable et un ensemble d'outils normalisés associés : documents d'orientation, outils de collecte et d'analyse des données et documents de rapport.

Le Tableau 2 fournit la liste complète des outils, qui peuvent également être utilisés dans le cadre plus général d'évaluations du SGIS. Plusieurs des outils et des fonctionnalités de la boîte à outils sont accessibles par l'intermédiaire d'une plateforme numérique en français et en anglais (<https://malsurtoolkit.who.int>).

Tableau 2. Contenu de la boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme

Fonction	Outils et fonctionnalités	Accès via la plateforme numérique	Description
Définir le champ d'application	Cadre d'évaluation	Oui	Un ensemble d'objectifs, de sous-objectifs et d'indicateurs clés qui peuvent être utilisés pour quantifier et/ou qualifier les forces et les faiblesses du système de surveillance. Cet outil doit être utilisé comme point de départ d'une évaluation pour définir la portée de l'évaluation, l'approche et les indicateurs à inclure.
	Note de synthèse et protocole	Non	Un modèle pour l'ébauche d'une courte note de synthèse visant à affiner le champ d'application, les méthodes, les produits et les résultats attendus d'une évaluation, ainsi qu'une ébauche de protocole plus détaillée requise pour les évaluations complètes.
	Outil de planification de l'évaluation de la surveillance	Non	Un modèle de budgétisation pour aider les pays à développer un plan chiffré pour entreprendre une évaluation complète.
Collecter et analyser les données	Modèle d'analyse documentaire	Oui	Un ensemble de questions, de tableaux, de graphiques et de diagrammes utilisés pour collecter des informations et résumer ce que l'on sait de la surveillance du paludisme par le biais d'un examen des documents et des données, et d'entretiens facultatifs avec le personnel du programme de surveillance et d'autres partenaires pertinents. Les indicateurs prioritaires se voient automatiquement attribuer une note à mesure qu'ils sont atteints, partiellement atteints ou pas atteints sur la base d'un ensemble défini de critères qui diffèrent pour chaque indicateur. Des informations sont incluses sur la façon d'évaluer chaque indicateur.

Fonction	Outils et fonctionnalités	Accès via la plateforme numérique	Description
Collecter et analyser les données	Outils d'évaluation et d'analyse de la qualité des données	Oui	Des outils et des conseils pour la collecte et l'analyse des données afin d'évaluer spécifiquement la qualité des données aux niveaux national, régional, du district et de la prestation de services.
	Banque de questions	Oui	Une bibliothèque de questions qui peuvent être utilisées pour élaborer des questionnaires d'enquête pour la collecte de données au niveau régional/du district, de la prestation de services et de la communauté. Des questionnaires d'auto-évaluation anonymes sont également inclus pour certains indicateurs. Les questionnaires sont générés et exportés automatiquement en fonction des questions sélectionnées dans la banque. Un ensemble de tableaux de plan d'analyse au format Excel est utilisé pour résumer les résultats d'analyse de l'enquête. Les tableaux sont générés automatiquement en fonction des questions sélectionnées.
Élaborer et prioriser les recommandations	Plan de note technique et de rapport	Non	Un modèle de rapport pour organiser, visualiser et interpréter les résultats de l'évaluation. La note technique est utilisée pour mettre en évidence un sous-ensemble de résultats prioritaires, tandis que le rapport complet comprend tous les résultats de l'évaluation.
	Outils visuels		
	Fiche d'évaluation	Oui	Une fiche qui capture si les indicateurs prioritaires évalués ont été atteints, partiellement atteints ou pas atteints en se basant sur l'analyse documentaire, le CQD et l'enquête. Des notes globales sont également fournies pour les sous-objectifs et les objectifs.
	Tableaux de bord	Oui	Des tableaux de bord sont générés automatiquement à partir de la fiche d'évaluation pour comparer les indicateurs entre les pays (tableau de bord par pays), les sous-objectifs entre les régions de l'OMS (tableau de bord régional) et les objectifs entre les pays (tableau de bord mondial). Les pays peuvent choisir de ne pas afficher leurs données sur ces tableaux de bord partagés.

Utilisation de la boîte à outils

Approche de l'évaluation

La portée de l'évaluation (c.-à-d. le contexte de transmission choisi, les interventions et stratégies de lutte contre le paludisme et les indicateurs) déterminera l'approche requise, à savoir rapide, sur mesure ou complète (Tableau 3). Cela déterminera quels outils de collecte de données sont nécessaires. Par exemple, si un pays souhaite évaluer tous les indicateurs, une évaluation complète doit être effectuée et tous les outils de collecte de données sont nécessaires. Il est recommandé que toutes les évaluations, y compris celles utilisant une approche rapide, portent sur des indicateurs prioritaires.

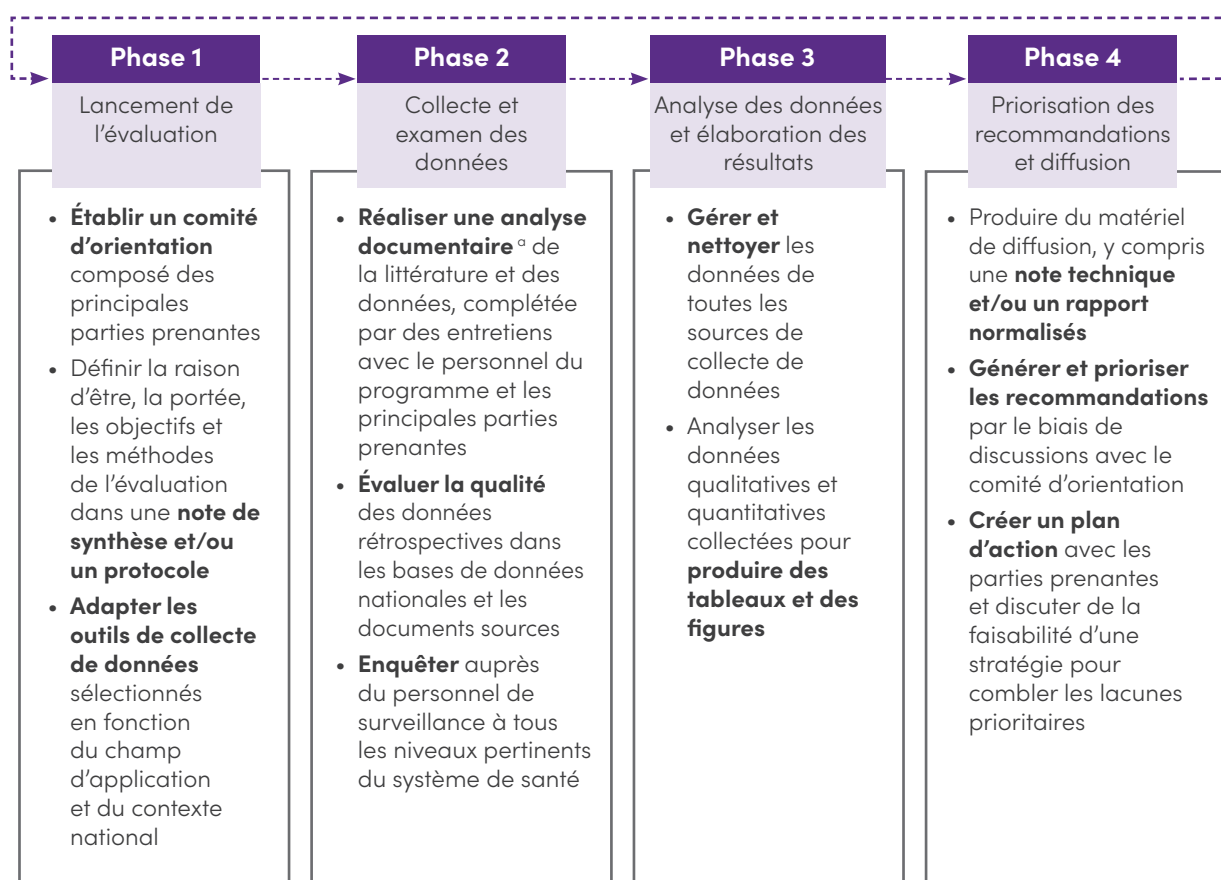
Tableau 3. Diverses approches d'évaluation à l'aide de la boîte à outils

Approche	Rapide	Sur mesure	Complète
Portée	Seuls les indicateurs prioritaires pour la surveillance des cas et des décès dus au paludisme par contexte de transmission (réduction de la charge et/ou élimination) et les indicateurs prioritaires pour les autres stratégies de lutte et d'intervention antipaludiques mises en œuvre dans le pays sélectionné pour l'évaluation.	Indicateurs prioritaires + indicateurs facultatifs sélectionnés par l'utilisateur qui sont d'intérêt pour la surveillance des cas et des décès dus au paludisme par contexte de transmission, et indicateurs prioritaires pour les autres stratégies de lutte et d'intervention antipaludiques mises en œuvre dans le pays sélectionné pour l'évaluation.	Tous les indicateurs pour la surveillance des cas et des décès dus au paludisme par contexte de transmission et les indicateurs prioritaires pour toutes les autres stratégies de lutte et d'intervention antipaludiques mises en œuvre dans le pays.
Méthodes	Principalement limité à une analyse documentaire avec quelques visites essentielles sur le terrain. Dans les contextes d'élimination, un CQD doit être effectué au niveau de la prestation de services.	Analyse documentaire et enquêtes à différents niveaux du système de santé (c.-à-d. national, infranational, échantillon d'établissements et d'agents de santé communautaires).	Analyse documentaire et enquêtes à différents niveaux du système de santé (c.-à-d. aux niveaux national et infranational ainsi que sur un échantillon d'établissements et d'agents de santé communautaires).
Estimation du besoin en matière de ressources	Faible : 2 à 4 semaines.	Moyen/élevé : de 3 mois minimum à 12 mois selon le contexte.	Élevé : de 3 mois minimum à 12 mois selon le contexte.
Fréquence suggérée	Une fois tous les 3 à 5 ans, conformément à la RPP et à l'élaboration du PSN. Annuellement dans les contextes d'élimination ou au besoin dans les contextes de réduction de la charge pour suivre les progrès vers l'amélioration.	Une fois tous les 3 à 5 ans, conformément à la RPP et à l'élaboration du PSN. Annuellement dans les contextes d'élimination, en fonction des besoins et des ressources.	Une fois tous les 3 à 5 ans, conformément à la RPP et à l'élaboration du PSN. Annuellement dans les contextes d'élimination, en fonction des besoins et des ressources.

Phases de la mise en œuvre

L'évaluation de la surveillance du paludisme doit être mise en œuvre dans un pays en quatre phases, comme décrit à la Figure 1. Il est recommandé d'exécuter ces phases dans l'ordre, chacune contribuant à éclairer celle qui suit. Le temps et les ressources nécessaires à la mise en œuvre de chaque phase varieront en fonction de la portée et de l'approche de l'évaluation.

Figure. 1. Phases de mise en œuvre d'une évaluation de la surveillance du paludisme réalisée à l'aide de la boîte à outils



^a L'analyse documentaire peut débiter dès la phase 1 afin d'éclairer le protocole ou la note technique.

Résultats attendus d'une évaluation à l'aide de la boîte à outils

Les résultats de chaque indicateur évalué peuvent être présentés dans un ensemble de tableaux de bord, une note technique et/ou un rapport ou une présentation de débriefing (Tableau 4).

Tableau 4. Méthodes de présentation des résultats d'une évaluation de la surveillance du paludisme

Méthode de présentation	Description
Tableau de bord des résultats pour les indicateurs prioritaires	Les résultats peuvent être présentés dans un ensemble de tableaux de bord, qui sont disponibles sur la plateforme numérique. La fiche d'évaluation du tableau de bord résume les constatations tirées des indicateurs prioritaires. Le pays peut également ajouter la raison expliquant le score pour chaque indicateur en mettant en évidence les principales réalisations et difficultés. Une recommandation de renforcement de la surveillance peut être incluse à côté de chaque indicateur, si nécessaire. Ces scores, résumés par sous-objectif et par objectif, peuvent être comparés entre les pays et au fil du temps sur les tableaux de bord régionaux et mondiaux de l'OMS.
Note technique et/ou rapport portant sur les constatations approfondies	Les modèles de diffusion des résultats approfondis comprennent un résumé des méthodes, une description détaillée des résultats de l'évaluation (tous les indicateurs évalués) et un texte narratif pour contextualiser et interpréter les constatations. Les modèles comprennent des exemples de systèmes d'information et d'organigrammes de données. Des recommandations priorisées doivent être incluses dans ces documents, une fois élaborés en collaboration avec le comité d'orientation, ainsi qu'un plan d'activités.
Présentation de débriefing	Un ensemble de diapositives comprenant le contexte, les méthodes, les principaux résultats et les recommandations.

Les résultats doivent être examinés au moyen d'un débriefing présentant les principales constatations avec le comité d'orientation afin d'élaborer des recommandations en collaboration. Les recommandations et les activités connexes seront priorisées en consultation avec le PNLP et d'autres parties prenantes, en fonction de leur impact et de leur faisabilité en vue de renforcer les systèmes de surveillance. Les recommandations priorisées peuvent être utilisées pour étayer les mesures de renforcement, et les activités qui en découlent peuvent faire l'objet d'un suivi afin de surveiller les progrès au fil du temps.

Partie B. Guide de mise en œuvre détaillé

L'évaluation de la surveillance du paludisme dans les pays comporte quatre phases :

1. Lancement de l'évaluation
2. Collecte et examen des données
3. Analyse des données et élaboration des résultats
4. Priorisation des recommandations et diffusion.

La Figure 2 décrit les quatre phases et la Figure 3 résume les étapes de chaque phase. Chaque phase est décrite en détail dans le Tableau 5 et dans les sections suivantes du présent guide.

Il est recommandé d'exécuter les phases dans l'ordre, chacune contribuant à éclairer celle qui suit. Cependant, on peut s'attendre à un certain degré de chevauchement entre les phases et les étapes ; par exemple, une partie de l'analyse documentaire (étape 2.1) servira de base à la finalisation du protocole (étape 1.2), et l'analyse se poursuivra tout au long de l'évaluation, à mesure que de nouveaux documents seront disponibles. Le processus est cyclique, en ce sens que les résultats de la phase 4 éclairent la phase 1 des évaluations futures (Figure 2).

Figure 2. Phases d'une évaluation de la surveillance du paludisme réalisée à l'aide de la boîte à outils

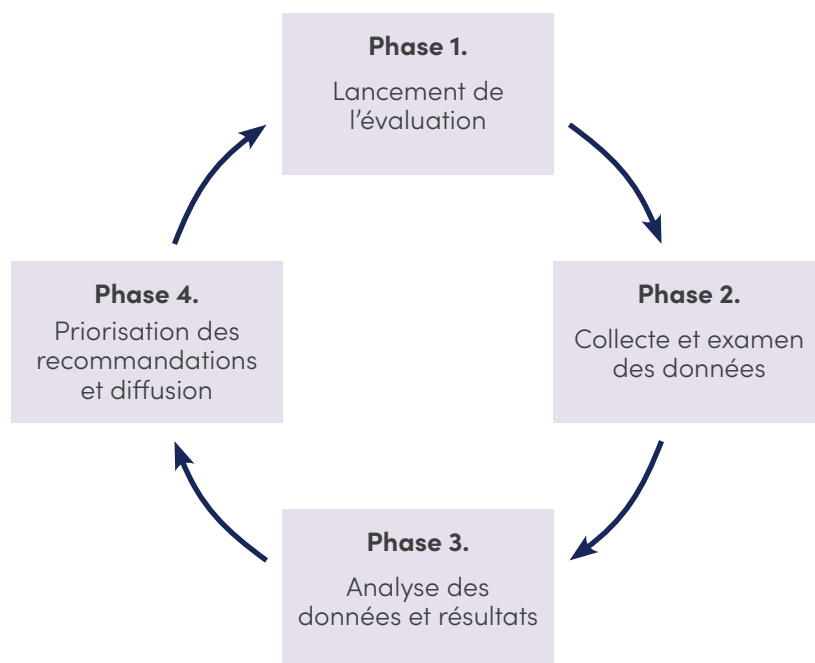


Figure 3. Principales étapes de chaque phase d'une évaluation de la surveillance du paludisme réalisée à l'aide de la boîte à outils

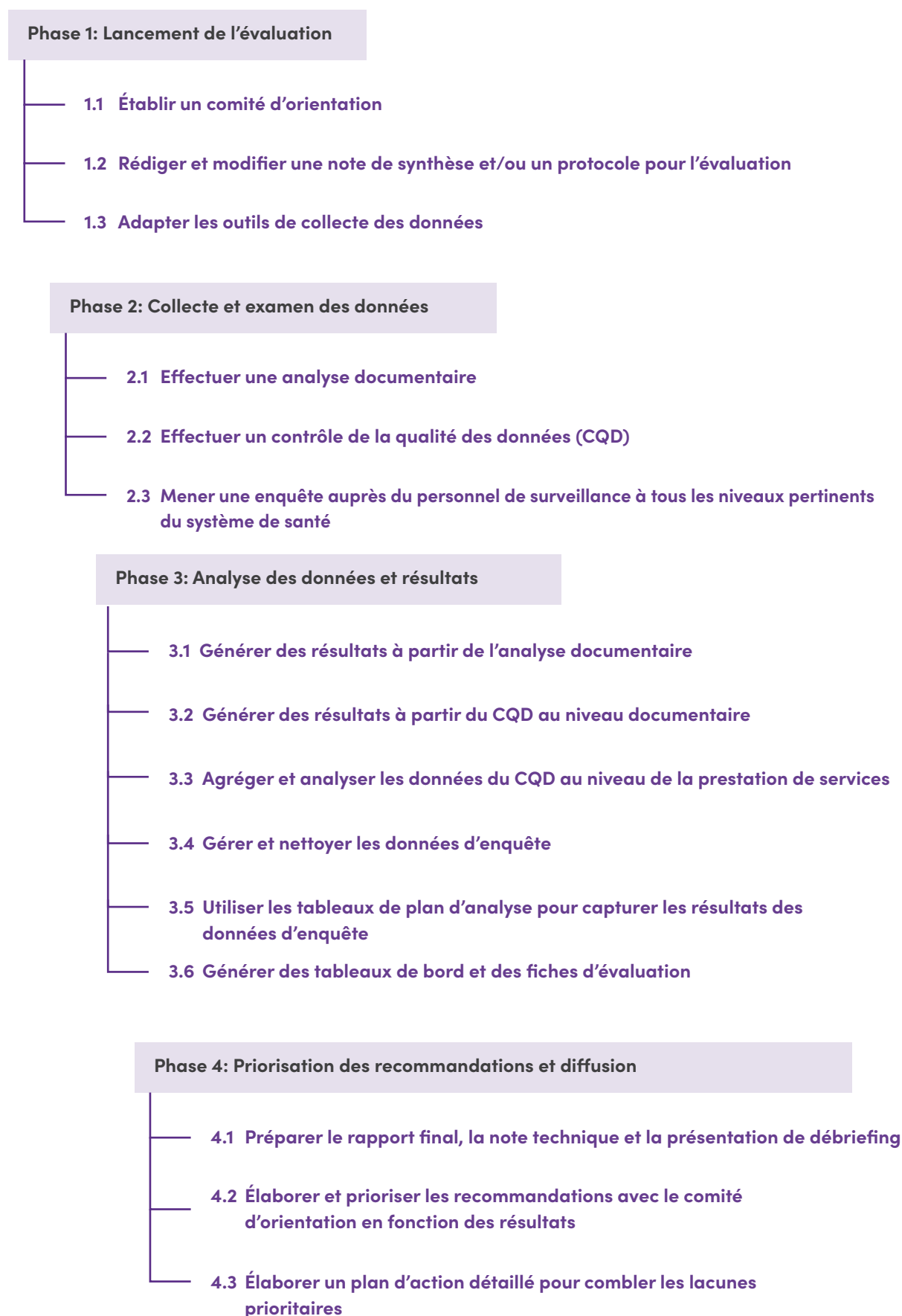


Tableau 5. Liste de contrôle de mise en œuvre pour les principales étapes et prestations d'une évaluation de la surveillance du paludisme menée à l'aide de la boîte à outils

Étapes	Achevé
Phase 1: Lancement de l'évaluation	
1.1 Établir un comité d'orientation composé des principales parties prenantes qui participent à la conception et à la mise en œuvre de l'évaluation.	
1.1.1 Cartographier le paysage des parties prenantes (voir Annexe 1)	☐
1.1.2 Obtenir l'engagement et définir les rôles et responsabilités du comité d'orientation	☐
1.1.3 Présenter l'évaluation et la boîte à outils de surveillance du paludisme aux parties prenantes	☐
1.1.4 Préparer et obtenir l'approbation du cadre de référence	
Les étapes suivantes doivent être effectuées pour compléter les sections pertinentes des modèles de note de synthèse et/ou de protocole.	
1.2.1 Effectuer un premier examen de la surveillance du paludisme antérieure et actuelle	☐
1.2.2 Définir la portée et les méthodes d'évaluation	☐
1.2.3 Définir la stratégie d'échantillonnage pour l'évaluation	☐
1.2.4 [Facultatif/au besoin] Obtenir un accord de partage de données	☐
1.2.5 Préparer et obtenir l'approbation des estimations relatives aux coûts, aux ressources et aux échéanciers	☐
1.2.6 [Facultatif/au besoin] Soumettre la demande au comité d'évaluation éthique (CEE)	☐
1.3 Adapter les outils de collecte de données	
1.3.1 Modifier les outils de collecte de données sélectionnés en fonction du contexte national	☐
1.3.2 [Facultatif/au besoin] Contextualiser et traduire les outils de collecte de données	☐
Phase 2: Collecte et examen des données	
2.1 Effectuer une analyse documentaire	
2.1.1 Réaliser un examen des documents à l'aide de l'outil d'analyse documentaire	☐
2.1.2 Cartographier les systèmes d'information, les outils d'enregistrement et de notification du paludisme, les variables et les indicateurs de base dans les bases de données nationales	☐
2.1.3 Procéder à des entretiens d'intervenants clés auprès du personnel des programmes concernés et des parties prenantes essentielles	☐
2.2 Effectuer un contrôle de la qualité des données (CQD)	
2.2.1 Sélectionner et compiler les données pour les variables de base dont la qualité des données doit être évaluée	☐
2.2.2 [Facultatif/au besoin] Publier une invitation à soumissionner (ou similaire) pour une entreprise de collecte de données	☐

Étapes	Achevé
2.2.3 [Facultatif/au besoin] Obtenir l'approbation d'un contrat avec une entreprise de collecte de données	☐
2.2.4 [Facultatif/au besoin] Préparer, planifier et mener la formation de mise en œuvre, y compris la mise à l'essai des outils de collecte de données	☐
2.3 Mener une enquête auprès du personnel de surveillance à tous les niveaux concernés du système de santé (agents de santé communautaires, établissements de santé et hôpitaux, bureaux de district/régionaux)	
2.3.1 Configurer les questionnaires à l'aide de la banque de questions pour chaque type de répondant visé	☐
2.3.2 Mener et suivre une enquête auprès du personnel de surveillance à tous les niveaux concernés du système de santé	☐
Phase 3: Analyse des données et résultats	
3.1 Générer des résultats à partir de l'analyse documentaire	☐
3.2 Générer des résultats à partir du CQD au niveau documentaire	☐
3.3 Agréger et analyser les données du CQD au niveau de la prestation de services	☐
3.4 Gérer et nettoyer les données d'enquête	☐
3.5 Utiliser les tableaux de plan d'analyse pour capturer les résultats des données d'enquête	☐
3.6 Générer des tableaux de bord et des fiches de performance	☐
Phase 4: Priorisation des recommandations et diffusion	
4.1 Préparer le rapport final, la note technique et la présentation de débriefing	☐
4.2 Élaborer et prioriser les recommandations avec le comité d'orientation en fonction des résultats	
4.2.1 Élaborer les recommandations	☐
4.2.2 Utiliser la matrice de priorisation dans le plan du rapport pour prioriser les recommandations	☐
4.3 Élaborer un plan d'action pour combler les lacunes prioritaires	
4.3.1 Diffuser le rapport final, comme convenu avec le PNLP et le comité d'orientation, aux parties prenantes dans le pays et discuter de la faisabilité des mesures visant à combler les lacunes prioritaires	☐
4.3.2 Créer un plan d'action et intégrer les activités dans la RPP ou le PSN	☐

Phase 1. Lancement de l'évaluation

Cette phase comprend des discussions entre le PNLP, les partenaires nationaux et les principales parties prenantes afin de déterminer la portée, les objectifs et les méthodes d'une évaluation de la surveillance dans le pays et de comprendre les principales lacunes en matière de surveillance. L'objectif est de formuler une note de synthèse et/ou un protocole à l'initiative du pays, devant être soumis à un examen éthique, le cas échéant. Les activités de cette phase consistent à :

- identifier les initiatives d'évaluation de la surveillance et les stratégies de surveillance existantes ;
- cartographier les parties prenantes, obtenir leur engagement et convenir des rôles et des responsabilités pour l'évaluation ;
- déterminer la portée, les objectifs et les méthodes de l'évaluation ;
- sélectionner les outils et le contenu les plus pertinents pour la portée des travaux définie ; et
- identifier les ressources disponibles et convenir d'un échéancier général pour l'évaluation.

1.1 Établir un comité d'orientation composé des principales parties prenantes qui participent à la conception et à la mise en œuvre de l'évaluation

Une première étape essentielle vers une mise en œuvre réussie consiste à rassembler les parties prenantes et à les mobiliser autour de l'évaluation.

1.1.1 Cartographier le paysage des parties prenantes

L'une des premières activités consiste à identifier les parties prenantes opérant dans le domaine de la surveillance du paludisme ainsi que les initiatives de renforcement de la surveillance qui sont en cours et soutenues par ces parties. L'Annexe 1 donne une liste des groupes, des personnes et des organisations à prendre en considération.

Il convient d'énumérer les parties prenantes impliquées dans la surveillance à tous les niveaux du système de santé, puis de résumer la portée des travaux pour chacune d'entre elles. Les détails tels que le nom, la description, l'intérêt dans l'évaluation, les ressources disponibles et le niveau potentiel de participation à l'évaluation doivent être indiqués pour chacune (Tableau 6).

Cette carte des parties prenantes sera utilisée tout au long de l'évaluation pour établir le comité d'orientation pour l'évaluation, déterminer les personnes à interroger et sélectionner les personnes à inclure dans les processus de diffusion des résultats et de planification des actions, entre autres.

Tableau 6. Exemple de cartographie des parties prenantes de la surveillance du paludisme

Nom de l'organisation, du groupe ou de la personne concernée	Description de la partie prenante ^a	Intérêt de la partie prenante dans l'évaluation ^b	Ressources disponibles ^c	Niveau d'implication dans l'évaluation
Partenaire 1 (p. ex., Clinton Health Access Initiative)	Évaluation des systèmes de surveillance épidémiologiques, entomologiques et d'intervention	+ pour O neutre - contre	2 employés à temps plein et des tablettes pour la collecte de données	Invité à participer aux processus décisionnels clés, tels que l'examen ou l'approbation du plan d'action et la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre le plan d'action. Consulté périodiquement (à titre formel ou informel).
Partenaire 2				
Partenaire 3				
Partenaire 4				

^a Objectif principal ; activités spécifiques à la lutte contre le paludisme ; portée géographique des activités ; temps passé dans le pays ; affiliation ; source de financement

^b Soutient ou s'oppose à l'évaluation, dans quelle mesure et pourquoi

^c Personnel, financement, technologie, information, influence

Adapté de (9).

1.1.2 Obtenir l'engagement et définir les rôles et responsabilités du comité d'orientation

Parmi les parties prenantes identifiées, un groupe central de parties participant aux activités de renforcement de la surveillance doit être contacté afin d'obtenir son engagement pour l'évaluation. Ces parties prenantes peuvent être mobilisées pour former un comité d'orientation qui participera à la conception de l'évaluation et au suivi des progrès accomplis vers sa mise en œuvre. Dans certains cas, plutôt que d'établir un nouveau comité d'orientation, les groupes de travail techniques existants sur la surveillance et le suivi et l'évaluation peuvent être utilisés si toutes les parties prenantes concernées sont incluses, si les responsabilités attendues peuvent être assumées et les prestations peuvent être accomplies.

Le personnel du PNLP doit participer au comité d'orientation et jouer un rôle actif dans la définition de la portée de l'évaluation ; la collecte, la validation et l'analyse des données ; l'interprétation des résultats ; et la formulation des recommandations. Les membres du personnel du PNLP recommandés sont les suivants :

- gestionnaire du PNLP ;
- analyste de données ou épidémiologiste du PNLP ;
- agent de suivi et d'évaluation ou responsable de la qualité des données du PNLP ou du SGIS ; et
- administrateur de l'OMS recruté sur le plan national.

Les rôles du comité d'orientation peuvent inclure :

- déterminer la portée, les objectifs et les méthodes de l'évaluation ;
- formuler la justification de l'évaluation et les résultats escomptés, en fonction des besoins du pays ;
- soutenir la planification, la préparation et la mise en œuvre de la collecte des données pour l'évaluation ;
- mener les entretiens ;
- contribuer à l'analyse des données ;
- contribuer à l'interprétation des résultats ;
- élaborer et prioriser les recommandations ;
- participer à la diffusion et à la promotion des constatations pour éclairer les mesures de renforcement de la surveillance ; et
- faciliter l'élaboration d'un plan d'action avec l'ensemble des parties prenantes de la surveillance.

Les prestations attendues du comité d'orientation comprennent :

- les mesures découlant des discussions lors des réunions du comité d'orientation ;
- l'examen des documents essentiels (p. ex., protocole, outils de collecte de données, rapport) ; et
- les approbations finales du protocole, des outils de collecte de données et du rapport.

1.1.3 Présenter l'évaluation de la surveillance du paludisme et la boîte à outils aux parties prenantes

L'évaluation de la surveillance du paludisme et la boîte à outils doivent être présentées aux parties prenantes. Pour cela on peut utiliser ou adapter l'introduction à la boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme.

1.1.4 Préparer et obtenir l'approbation du cadre de référence

Le cadre de référence doit être rédigé de manière à mettre en évidence les principaux participants, ainsi que les responsabilités et les résultats attendus du comité d'orientation. Le cadre de référence doit être signé par tous les membres dudit comité.

Ce dernier doit inclure des donateurs qui investissent dans des activités se rapportant à la surveillance, du personnel du ministère de la Santé et du PNLP, des partenaires d'exécution impliqués dans la surveillance et l'OMS.

Pour mobiliser et coordonner ces parties prenantes et d'autres, il est utile d'identifier une personnalité éminente nationale et influente dotée de pouvoirs décisionnels. Il peut s'agir d'une personne au sein du PNLP, du ministère de la Santé ou de l'organisme national de statistique, ou d'un secteur de programmes importants impliqué dans les systèmes de santé ou la recherche sur le paludisme dans le pays. Cette personne peut faciliter la compréhension, par les parties prenantes, des objectifs de l'évaluation et la façon dont cette dernière s'inscrit dans le processus global de surveillance, de renforcement et de lutte contre le paludisme. Dans l'idéal, elle défendra et assumera également les recommandations et les prochaines étapes qui découleront de l'évaluation.

1.2 Rédiger et modifier une note de synthèse et/ou un protocole pour l'évaluation

L'étape suivante consiste à rédiger une note de synthèse et/ou un protocole pouvant être utilisés pour aborder des discussions dans le pays ; définir les principales activités de mise en œuvre et les échéanciers ; définir et documenter la portée, les méthodes et la stratégie d'échantillonnage de l'évaluation ; et estimer les coûts et les échéances.

La boîte à outils comprend des modèles génériques de note de synthèse et de protocole. Les pays qui souhaitent procéder à une évaluation rapide du système de surveillance peuvent utiliser une note de synthèse, tandis qu'une évaluation plus détaillée doit être définie dans un protocole. Pour les évaluations complètes et sur mesure, il peut être nécessaire ou utile de rédiger une note de synthèse avant d'élaborer le protocole d'étude complet. La principale différence entre une note de synthèse et un protocole réside dans l'ordre et le niveau des informations détaillées fournies sur les procédures de collecte de données : la note de synthèse est plus brève, fournissant un résumé pour chacune des sections énumérées ci-dessous, tandis que le protocole donne davantage de détails.

Les deux documents comprennent :

- Contexte et justification
- But et objectifs
- Portée de l'évaluation
- Méthodes
- Produits et résultats attendus
- Considérations éthiques
- Plan de travail et budget

On peut s'attendre à plusieurs versions de la note de synthèse ou du protocole aux premières étapes de l'évaluation, en fonction des commentaires des parties prenantes.

Dans certains cas, l'outil d'analyse documentaire (Encadré 2 de la section 2.1) peut être utilisé pour compiler et organiser l'information requise pour finaliser la note de synthèse ou le protocole, par exemple les secteurs notifiant des données sur les cas, les autres stratégies de surveillance existantes et les systèmes d'information qui sont en place.

Les sous-sections suivantes donnent des orientations sur la manière de compiler ces informations en coordination avec le comité d'orientation.

1.2.1 Effectuer un premier examen de la surveillance du paludisme antérieure et actuelle

Pour comprendre le système de surveillance du paludisme dans le pays et pourquoi une évaluation peut être nécessaire, il est suggéré d'effectuer un bref examen des documents. Les informations utiles comprennent :

- les facteurs démographiques, sociopolitiques, financiers et écologiques de la transmission du paludisme dans le pays au cours des 5 dernières années ;
- l'épidémiologie du paludisme aux niveaux national et infranational – elle peut être publiée dans un rapport annuel ou une RPP ;
- les stratégies de surveillance utilisées et la façon dont elles sont mises en œuvre, y compris les réalisations et les difficultés – cette information est normalement décrite dans le PNS ;

- l'examen des constatations de toute évaluation de la surveillance antérieure et de toute documentation relative aux forces et aux faiblesses actuelles de la surveillance ;
- les initiatives pertinentes de renforcement de la surveillance antérieures, actuelles et futures – celles-ci peuvent être disponibles dans le plan de suivi et d'évaluation ; et
- la justification de l'évaluation.

Ces informations peuvent être organisées dans la section 1 (Contexte et justification) de la note de synthèse ou du protocole.

1.2.2 Définir la portée et les méthodes d'évaluation

Lors de la conception d'une évaluation de la surveillance à l'aide de la boîte à outils, la première étape consiste à définir la portée. Il s'agit de sélectionner le contexte de transmission pour la surveillance des cas de paludisme (réduction de la charge et/ou élimination), d'identifier les interventions et les stratégies de lutte pour lesquelles la surveillance sera évaluée, et d'établir les indicateurs à inclure dans chaque objectif (cadre d'évaluation). Ces décisions seront motivées par des discussions entre le PNLN et les partenaires, et doivent tenir compte de l'information recueillie pour le contexte et la justification ainsi que des ressources et de l'expertise disponibles.

Lors de la préparation d'une évaluation, le cadre d'évaluation (Encadré 1) est le premier point de référence. Cette fonctionnalité de la plateforme numérique permet aux utilisateurs de définir la portée de l'évaluation en identifiant :

- Le **contexte de transmission** pour la surveillance des cas de paludisme (réduction de la charge et/ou élimination). L'objectif principal de la boîte à outils est la surveillance des cas de paludisme dans les contextes de transmission élevée, modérée et faible (réduction de la charge) et/ou les contextes d'élimination (y compris les investigations des cas et des foyers). Si les pays participent à des activités d'élimination au niveau infranational, l'évaluation de la surveillance peut être effectuée à l'aide du module d'élimination pour des zones spécifiques du pays et du module de réduction de la charge pour le reste du pays. Dans cette situation, il faut choisir à la fois la réduction de la charge et l'élimination.
- Les **interventions et les stratégies de lutte contre le paludisme** utilisées dans le pays pour évaluer la surveillance. La boîte à outils peut être utilisée dans le cadre plus large du système de surveillance intégré pour l'évaluation de haut niveau des éléments suivants :
 - la surveillance de la mise en œuvre de l'intervention – pour la chimioprévention (traitement préventif intermittent pendant la grossesse [TPIg], traitement préventif intermittent du nourrisson [TPIIn], chimioprévention du paludisme saisonnier [CPS] et administration de masse de médicaments [AMM]) et la lutte antivectorielle (moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées par le biais de canaux de routine et/ou de campagnes de masse, pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent et gestion des gîtes larvaires) ;
 - le suivi des produits de base ;
 - la surveillance entomologique ;
 - la surveillance de l'efficacité des médicaments ; et
 - la surveillance génomique (pharmacorésistance et délétions du gène *pfhrp2/3*).

L'objectif de l'évaluation de ces stratégies est de comprendre quelles informations sont recueillies et si les données sont intégrées et utilisées avec les données de surveillance de routine sur les cas et les décès dus au paludisme. La boîte à outils ne comprend pas de contrôles de la qualité des données ni d'enquête pour ces stratégies.

- Les **indicateurs** à inclure dans l'évaluation. Les utilisateurs peuvent sélectionner des indicateurs organisés par sous-objectifs relevant des objectifs (1) performance, (2) contexte et infrastructures, (3) technique et processus, et (4) comportement, comme décrit dans le Tableau 2 du présent document (dans la Partie A).
 - Une évaluation complète inclura tous les indicateurs pour la surveillance des cas de paludisme par contexte de transmission et des indicateurs prioritaires spécifiques pour d'autres stratégies de lutte et d'intervention antipaludiques mises en œuvre dans le pays.
 - Une évaluation rapide ne comportera que les indicateurs prioritaires. Des étapes de sélection supplémentaires ne sont nécessaires que pour les approches d'évaluation sur mesure qui incluent tous les indicateurs prioritaires et une sélection d'indicateurs facultatifs pertinents au contexte du pays.

Une fois qu'un ensemble d'indicateurs est sélectionné, l'outil du cadre d'évaluation (Encadré 1) indiquera les méthodes de collecte de données les plus appropriées pour évaluer chaque indicateur. Une évaluation de la surveillance menée à l'aide de la boîte à outils comporte deux méthodes principales de collecte : l'analyse documentaire et les enquêtes auprès des établissements de santé. Ces méthodes sont mises en œuvre au niveau national ou au niveau de la prestation des services (Tableau 7). Pour les évaluations complètes ou sur mesure, il convient d'effectuer des entretiens d'intervenants clés auprès du personnel des programmes concernés et un contrôle de la qualité des données (CQD) et/ou une enquête auprès du personnel de surveillance au niveau de la prestation de services. Pour les évaluations rapides, tous les indicateurs peuvent être évalués au niveau documentaire à l'aide de l'outil d'analyse documentaire et du CQD. Certains indicateurs peuvent également être évalués au niveau de la prestation de services en effectuant des visites sur le terrain ; il revient au pays de décider de la méthode la mieux adaptée au contexte national. Dans les contextes d'élimination, l'évaluation rapide nécessite des éléments au niveau documentaire et de la prestation de services.

Tableau 7. Méthodes de collecte des données et niveau de mise en œuvre

Méthode de collecte des données	Niveau de mise en œuvre	Outils	Processus
Analyse documentaire	National	Outil d'analyse documentaire	Compilation de documents et de données à l'échelle nationale pour examiner et décrire les systèmes de surveillance. Entretiens d'intervenants clés aux niveaux national et infranational, le cas échéant.
		CQD documentaire et tableau de bord DHIS2 (logiciel d'information sanitaire de district) ^a	Effectuer un CQD initial sur les données rétrospectives des systèmes de surveillance nationaux.
Enquête	Prestation de services	Banque de questions	Entretiens à l'aide de questionnaires pour chaque unité/niveau à interroger.
		CQD au niveau de la prestation de services ^a	Collecte de données primaires à partir de registres et comparaison avec les rapports agrégés au niveau national/infranational.

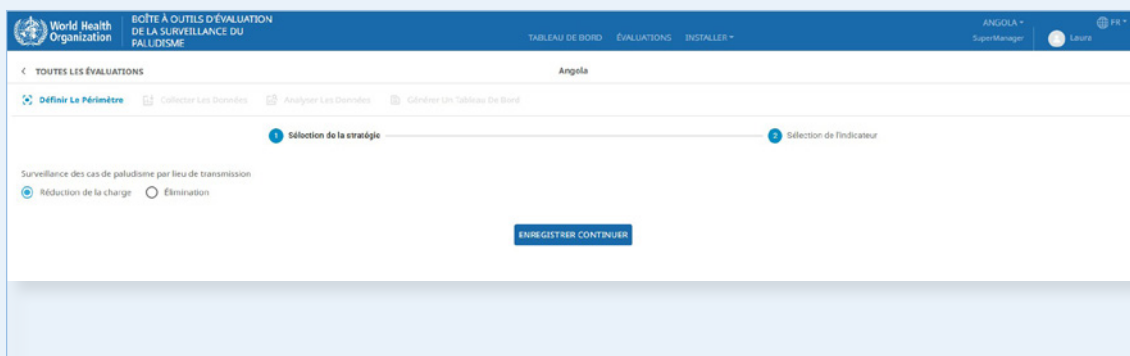
^a Dans les contextes d'élimination, les outils de CQD au niveau documentaire et de la prestation de services sont combinés.

Ces informations peuvent être résumées dans les sections 2 « But et objectifs », 3 « Portée de l'évaluation » et 4 « Méthodes » de la note de synthèse ou du protocole.

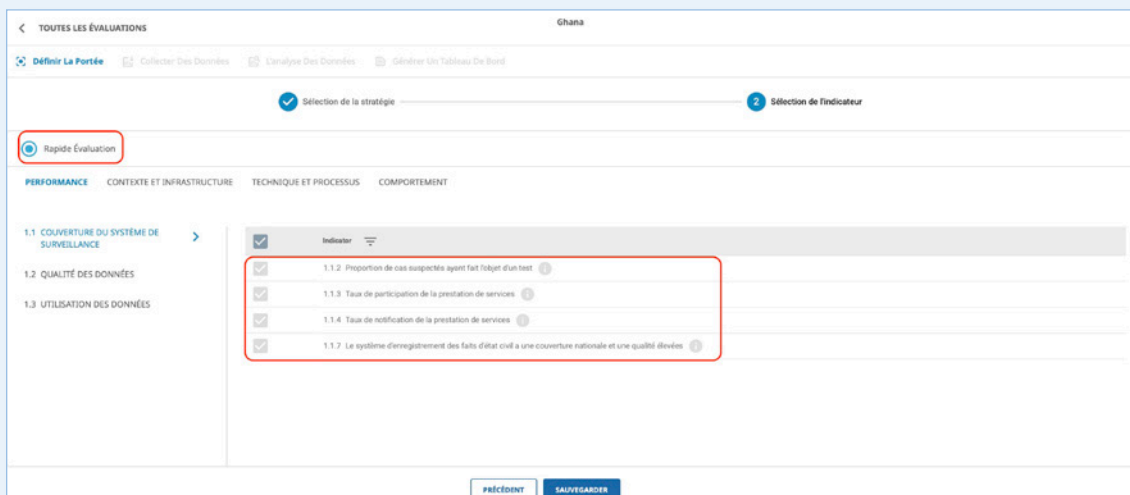
Encadré 1. Cadre d'évaluation

Le cadre d'évaluation est inclus dans la boîte à outils afin de fournir un cadre normalisé mais adaptable pour les évaluations de la surveillance du paludisme, pouvant être comparé dans le temps et entre les zones géographiques. Cette fonction de la plateforme numérique peut être utilisée pour sélectionner les indicateurs relevant des quatre objectifs qui seront mesurés et suivis dans le cadre de l'évaluation.

Étape 1. Sélectionner la surveillance des cas et des décès dus au paludisme par contexte de transmission, ainsi que toutes les stratégies de lutte et d'intervention antipaludiques mises en œuvre dans le pays concerné.



Étape 2. Sélectionner les indicateurs pour le contexte de transmission concerné sur la base de l'approche d'évaluation (évaluation rapide = indicateurs prioritaires uniquement (sélectionnés automatiquement) ; évaluation complète = tous les indicateurs (sélectionnés automatiquement) ; évaluation sur mesure = indicateurs prioritaires + sélection d'indicateurs facultatifs (sélectionnés manuellement par l'utilisateur). Chaque icône « i » en regard de l'indicateur donne des informations supplémentaires qui aident l'utilisateur à décider de son inclusion dans l'évaluation.



1.2.3 Définir la stratégie d'échantillonnage pour l'évaluation

Pour les évaluations rapides, il est acceptable d'utiliser une approche non systématique pour définir la stratégie d'échantillonnage (voir la section 2.2.1).

Des évaluations complètes ou sur mesure, dans le cadre desquelles des CQD et/ou des enquêtes sont prévues au niveau de la prestation de services, nécessiteront systématiquement la collecte de données et l'échantillonnage des établissements de santé notifiant des données sur le paludisme. Lorsqu'un CQD et/ou une enquête systématiques sont mis en œuvre, les éléments suivants doivent être définis (Tableau 8):

- l'unité d'échantillonnage ;
- la base d'échantillonnage ;
- le calcul/la formule et les hypothèses utilisées pour déterminer la taille de l'échantillon; et
- la stratégie d'échantillonnage (Tableau 8).

La stratégie d'échantillonnage peut varier considérablement selon le cas, en fonction de la précision souhaitée et du type d'estimations voulu, du nombre d'établissements et/ou d'agents de santé communautaires dans le pays et des objectifs spécifiques de l'évaluation.

Il est recommandé de consulter un statisticien afin de choisir une stratégie d'échantillonnage appropriée. Le Tableau 8 peut être utilisé comme guide pour l'échantillonnage d'une évaluation menée à l'aide de cette boîte à outils.

Il est recommandé que l'échantillon d'établissements de santé utilisé pour mener le CQD au niveau de la prestation de services soit le même que celui utilisé pour les entretiens avec les agents de santé.

Tableau 8. Orientation sur la stratégie d'échantillonnage pour la collecte de données au niveau de la prestation de services effectuée en vue d'une évaluation complète ou sur mesure

Unité d'échantillonnage

Pour le CQD et les enquêtes au niveau de la prestation de services, l'établissement de santé est utilisé comme unité d'échantillonnage. Pour les enquêtes, un nombre fixe de personnes interrogées sera sélectionné dans les établissements de santé échantillonnés.

Base d'échantillonnage

Une base d'échantillonnage est une liste d'unités (établissements de santé) à partir desquelles l'échantillon sera prélevé. Celle-ci doit être déterminée le plus tôt possible dans le processus d'élaboration du protocole au cas où il serait nécessaire de recenser des établissements ou d'autres unités à utiliser comme base d'échantillonnage. Une liste complète de toutes les installations d'un pays (publiques et privées), avec des identifiants uniques, doit être utilisée. Elle doit comprendre des informations sur les éléments d'intérêt pertinents : intensité de la transmission du paludisme, région/district, type d'établissement, autorité de gestion et désignation urbaine/rurale de chaque établissement. S'il existe une liste de référence des établissements de santé (MFL) pour un pays, celle-ci peut servir de base d'échantillonnage.

Une liste initiale obtenue auprès du ministère de la santé devra en général être complétée par des informations provenant de plusieurs autres sources, telles que des organismes de coordination du secteur privé ; les ministères sociaux où les organisations non gouvernementales enregistrent leurs activités ; ou directement auprès d'organisations d'inspiration religieuse, privées et gouvernementales.

Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une liste fiable des installations pour la base d'échantillonnage, une méthode d'échantillonnage à double base peut être utilisée (11). Cette méthode combine un échantillon aléatoire simple d'hôpitaux et de grands établissements avec un échantillon de zones géographiquement définies dans le pays.

Dès le départ, les critères d'inclusion et d'exclusion pour la participation à une enquête d'évaluation de la surveillance doivent être définis. Tous les établissements de santé non conformes aux critères d'inclusion doivent être retirés de la base d'échantillonnage. Par exemple, tous les lieux de prestation de services qui fournissent des services de lutte contre le paludisme seraient inclus, à l'exception de ceux dont les activités ont débuté au cours des 3 derniers mois.

Calcul de la taille d'échantillon

Une méthodologie doit être choisie pour calculer la taille de l'échantillon pour les enquêtes au niveau de la prestation de services. La formule de calcul de la taille d'échantillon utilisée dans l'évaluation de la préparation et de la disponibilité des services (SARA) (12) est recommandée pour les enquêtes au niveau des établissements de santé. L'équation nécessaire pour estimer la taille d'échantillon est la suivante :

$$n = [(z^2 \times p \times q) + ME^2] / [ME^2 + (z^2 \times p \times q / N)] \times d$$

Où :

n = taille d'échantillon

z = niveau de confiance à 95 %

ME = marge d'erreur

p = proportion prévue d'installations ayant l'attribut d'intérêt

q = 1 – p

N = nombre total d'établissements de santé dans la base d'échantillonnage pour les strates spécifiques

d = effet du plan d'échantillonnage

Remarques sur les paramètres :

n	Taille d'échantillon par strate
z	Un niveau de confiance à 95 % est généralement utilisé, pour lequel la valeur Z correspondante est de 1,96. Ainsi, $2 \times Z = 3,84$.
ME	La marge d'erreur est la quantité d'erreurs d'échantillonnage aléatoires dans les résultats d'une enquête. Une marge d'erreur de 15 % est généralement utilisée.
p	Représente le « pourcentage d'établissements ayant l'attribut X ». Par exemple, il peut s'agir de la proportion d'enregistrements soumis avec précision et à temps au DHIS2 (logiciel d'information sanitaire de district). Il faut avoir une certaine idée de la valeur p afin d'utiliser la formule pour calculer la taille d'échantillon. La valeur p utilisée pour calculer la taille d'échantillon n'a pas besoin d'être très précise (sinon, il n'y aurait pas besoin de mener l'enquête), et elle peut être obtenue à partir d'enquêtes antérieures menées dans le pays ou de pays semblables ayant mené des enquêtes similaires. Si p n'est pas connu, 0,5 peut être utilisé comme estimation prudente.
d	L'effet du plan d'échantillonnage est une valeur qui reflète le rapport des variances d'échantillonnage, où le numérateur est la variance du plan utilisé pour l'enquête sur les établissements en question, et le dénominateur est la variance qui résulterait de l'utilisation d'un échantillon aléatoire simple d'établissements de taille identique. Cet effet reflète les effets de la stratification, des étapes de sélection et du degré de regroupement utilisés dans l'enquête sur les établissements. D'une manière générale, la composante de regroupement contribue l'effet le plus important ; celle-ci correspond à une estimation de la mesure dans laquelle deux établissements d'un même groupe ont la même caractéristique par rapport à deux établissements sélectionnés au hasard dans la population d'établissements. L'effet

du plan d'échantillonnage montre à quel point l'échantillon est peu fiable par rapport à un simple échantillon aléatoire de la même taille. Par exemple, si l'effet du plan était de 1,2, la variance d'échantillonnage de l'échantillon d'établissements serait supérieure de 20 % à celle d'un autre plan utilisant un échantillonnage aléatoire simple. Pour un échantillon stratifié tiré d'une liste de base sans regroupement, l'effet du plan d'échantillonnage devrait être d'environ 1,0 selon la stratégie d'échantillonnage recommandée pour la SARA. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser une valeur $d = 1,0$ pour un échantillon de liste stratifié. Si une stratégie différente (p. ex., un échantillon en groupes) est utilisée, l'effet de plan d'échantillonnage pourrait être plus élevé. Si un pays dispose d'informations provenant d'une enquête précédente qui suggèrent la valeur de l'effet du plan d'échantillonnage, cette valeur doit être utilisée pour calculer la taille des échantillons. Pour l'échantillonnage combiné mentionné ci-dessus, effectué à partir d'une liste et de zones, il est recommandé d'utiliser une valeur $d = 1,2$.

Stratégie d'échantillonnage

Il faut choisir la stratégie qui sera utilisée pour échantillonner le nombre d'unités déterminé ci-dessus. Une fois que la base d'échantillonnage a été établie et que le nombre requis d'établissements de santé par strate a été identifié, les principes d'échantillonnage aléatoire sont utilisés pour sélectionner les établissements à inclure dans l'évaluation. Habituellement, un plan d'échantillonnage stratifié ou à plusieurs degrés est suivi pour assurer la représentation des établissements admissibles dans divers domaines. Dans l'échantillonnage aléatoire stratifié, la base d'échantillonnage (à savoir, la liste des établissements de santé) est divisée en strates (p. ex., catégories et régions de transmission du paludisme, autorités de gestion, transmission urbaine ou rurale, combinaisons de celles-ci), qui sont ensuite échantillonnées de manière indépendante.

Au sein de chaque strate, les établissements de santé peuvent être échantillonnés à l'aide d'une probabilité proportionnelle à la taille d'échantillon afin de prioriser les établissements de santé qui, par exemple, notifient le plus grand nombre de cas de paludisme. Il est également possible de sélectionner les établissements de santé au hasard (échantillonnage aléatoire simple) à partir de la liste des établissements de santé pour chaque strate.

Des remplacements pour les établissements fermés ou inaccessibles peuvent être sélectionnés en utilisant la même méthode. Cela signifie que le nombre d'établissements de santé sélectionnés peut dépasser la taille d'échantillon requise afin que des remplacements soient facilement disponibles. Pour faciliter la logistique, on peut également sélectionner l'établissement le plus proche du même type dans la même zone géographique.

Dans les contextes d'élimination, les critères suivants doivent être pris en compte :

- Inclusion de toutes les provinces, régions ou districts qui présentent des foyers actifs ou une transmission en cours.
- Les établissements de santé doivent être stratifiés en fonction du nombre de cas de paludisme notifiés (faible, moyen, élevé).
- Des établissements de santé publics et privés doivent être inclus, ainsi que des hôpitaux (ou hôpitaux de recours) et des laboratoires.
- Des entretiens doivent être menés avec tous les bureaux régionaux et de district et auprès d'un échantillon d'agents de santé communautaires.
- Inclusion des provinces, régions ou districts ne présentant aucun cas de paludisme ou cas sporadique.
- Les établissements de santé ou les laboratoires ayant notifié des cas au cours des 3 dernières années et un échantillon d'établissements de santé ou de laboratoires n'ayant notifié aucun cas doivent être inclus.
- Les établissements de santé peuvent être stratifiés en fonction du risque de reprise de la transmission dans la zone géographique définie, ou les provinces, régions ou districts exempts de paludisme peuvent être stratifiés en fonction de la date de survenue du dernier cas autochtone.
- Des établissements de santé publics et privés doivent être inclus.

- Des entretiens doivent être menés avec tous les bureaux régionaux et de district et auprès d'un échantillon d'agents de santé communautaires.
- Inclusion de provinces, de régions ou de districts déclarés exempts de paludisme.
- Des établissements de santé publics et privés doivent être inclus dans l'examen de la vigilance au niveau des services généraux. Pour la certification, il est important d'évaluer si un système est en place pour sensibiliser et former les médecins à suspecter le paludisme en fonction des symptômes, et d'effectuer un suivi à l'aide de tests.
- Des entretiens avec tous les bureaux régionaux et de district doivent être inclus afin d'examiner les systèmes et les mécanismes de notification, en mettant l'accent sur la prévention de la reprise et en veillant à ce que tout cas de paludisme détecté soit notifié et fasse l'objet d'une enquête en temps opportun.

Le pays souhaitera peut-être mener des entretiens avec l'ensemble des provinces, régions et districts restants ainsi qu'observer les systèmes et mécanismes existant afin d'assurer la cohérence dans tout le pays.

1.2.4 [Facultatif/au besoin] Obtenir un accord de partage de données

Une évaluation de la surveillance implique l'analyse de données rétrospectives provenant des systèmes de surveillance du paludisme ; par conséquent, si nécessaire, préparer un accord de partage de données entre les PNLP et les partenaires d'exécution. Cet accord doit être rédigé et signé par les parties prenantes pouvant avoir accès aux données et participant à leur analyse, et doit inclure les éléments suivants :

- Une description détaillée des points de données à partager, notamment :
 - ventilation temporelle et géographique des données nécessaires, ainsi que d'autres métadonnées pertinentes ;
 - liste des sources de données attendues ; et
 - noms des propriétaires de données concernés.
- Une brève description de l'analyse qui sera effectuée à l'aide des données.
- Un récapitulatif des résultats escomptés.
- Une explication de la façon dont les résultats seront utilisés et diffusés, y compris s'ils seront publiés et où.
- Tout langage juridique pertinent propre aux partenaires concernés.

1.2.5 Préparer et obtenir l'approbation des estimations relatives aux coûts, aux ressources et aux échéanciers

Une fois que la portée, les méthodes et la stratégie d'échantillonnage de l'évaluation sont définies, une estimation des coûts, des ressources et des délais de mise en œuvre peut être effectuée. Ces estimations peuvent varier considérablement selon la portée et le pays. Le protocole et la note de synthèse incluent des annexes comprenant :

- un modèle de plan de travail ; et
- un modèle de budget basé sur l'outil de planification de l'évaluation de la surveillance et destiné à être utilisé en même temps que celui-ci.

L'outil de planification de l'évaluation de la surveillance est conçu pour aider les pays à élaborer un budget chiffré pour une évaluation complète. Il comprend une composante de budgétisation qui contient des activités adaptables au contexte du pays, la ventilation des coûts et l'allocation des unités/personnes à chiffrer. L'outil comprend également un calendrier de planification mensuel et hebdomadaire que les pays peuvent personnaliser en fonction de leurs besoins et de

leurs échéanciers. La composante de budgétisation permet aux pays de déterminer le montant des fonds qui seront nécessaires pour réaliser l'évaluation, et sert aussi de méthode pour calculer les coûts associés à des fins de planification et d'intégration futures.

Pour les évaluations rapides, les coûts sont en général faibles. Les pays doivent tenir compte des coûts liés à la nécessité d'engager des consultants externes et à deux réunions des parties prenantes devant avoir lieu au début et à la fin de l'évaluation de la surveillance.

Si le budget n'est pas disponible pour une évaluation du système de surveillance dans le cadre du PSN actuel, la mise au point d'une note de synthèse et/ou d'un protocole avant l'élaboration du prochain PSN, ou une RPP ou un examen à mi-parcours, peuvent aider à prioriser cette évaluation en tant qu'activité essentielle relevant du renforcement des systèmes de surveillance.

Ces informations peuvent être résumées dans les sections 7 (Supervision du projet) et 8 (Plan de travail et budget) de la note de synthèse et/ou du protocole.

1.2.6 [Facultatif/au besoin] Soumettre la demande au comité d'évaluation éthique

Cela ne s'applique qu'aux soumissions de protocole. Une fois que le protocole d'évaluation a été élaboré et examiné par toutes les parties concernées, y compris les membres du comité d'orientation, il doit être présenté aux comités d'évaluation éthique (CEE) concernés, selon le cas pour le pays et les parties prenantes impliqués. Il est courant que le traitement des demandes soumises au CEE dans le pays prenne quelques mois ; par conséquent, une planification adéquate doit commencer dès qu'une première ébauche du protocole est disponible. Les demandes auprès du CEE nécessitent souvent la soumission d'outils de collecte de données provisoires en plus du protocole ; cela peut toutefois différer en fonction des exigences spécifiques du CEE en question. Avant de procéder à la soumission, les lignes directrices applicables du CEE doivent être recherchées et examinées en détail.

Noter que les outils finaux de collecte de données personnalisés et contextualisés de l'étape 1.3 doivent être inclus dans un protocole final remis au CEE.

1.3 Adapter les outils de collecte de données

Au besoin, les outils de collecte de données peuvent être adaptés au contexte du pays. Les outils doivent être mis en correspondance avec les indicateurs de l'outil du cadre d'évaluation. À l'aide de la plateforme digitale, ils sont automatiquement filtrés en ajoutant ou en supprimant des stratégies et des indicateurs.

Pour la composante CQD, il peut être nécessaire d'adapter davantage les outils en fonction des indicateurs et des variables pertinents pour le paludisme qui sont sélectionnés pour l'évaluation. Par exemple, il peut être nécessaire de remplacer les noms des variables par ceux qui sont utilisés dans le pays.

D'autres modifications peuvent être nécessaires une fois que la collecte de données commence (p. ex., les informations tirées de l'analyse documentaire peuvent être utilisées pour adapter les questionnaires). La formulation des questions peut également être modifiée pour s'adapter au contexte du pays.

La section 2.3.1 donne plus de détails sur la création de questionnaires à partir de la banque de questions.

1.3.1 [Facultatif/au besoin] Contextualiser et traduire les outils de collecte de données

Tous les outils de collecte de données nécessitent un certain degré d'adaptation aux contextes spécifiques à chaque pays. Par exemple, les noms des unités administratives, les rôles du personnel de surveillance et les systèmes d'information varieront d'un pays à l'autre. Les outils eux-mêmes proposent des suggestions d'adaptation.

En outre, il peut être nécessaire de traduire les outils et les documents d'appui (c'est-à-dire la note de synthèse, le protocole et les questionnaires) dans les langues locales.

Phase 2. Collecte et examen des données

Une évaluation de la surveillance menée à l'aide de la boîte à outils comporte deux méthodes de collecte de données : l'analyse documentaire et l'enquête. En fonction de la portée et de l'approche de l'évaluation (rapide, sur mesure ou complète), l'une ou l'autre de ces options ou les deux seront applicables.

Habituellement, les activités de cette phase consistent à :

- compiler la documentation et les ensembles de données existants ;
- cartographier les outils d'enregistrement et de notification, les variables et les indicateurs pertinents pour le paludisme ;
- procéder à une analyse documentaire et à des entretiens d'intervenants clés auprès du personnel des programmes concernés ;
- déterminer les principales variables et indicateurs du paludisme à évaluer pour le CQD ;
- demander l'accès aux bases de données nationales ;
- déterminer qui effectuera les activités de collecte de données, puis recruter et former le personnel (si nécessaire) ;
- recueillir des informations supplémentaires au niveau de la prestation de services ; et
- mener une enquête auprès du personnel de surveillance.

2.1 Effectuer une analyse documentaire

Pour commencer à comprendre les caractéristiques du système de surveillance et les déterminants de performance associés, il faut procéder à une analyse documentaire, à savoir un processus systématique d'examen de l'ensemble des documents, des lignes directrices et des articles disponibles sur la surveillance, ainsi que de certaines données essentielles. Cette analyse doit être complétée par des entretiens d'intervenants clés effectués auprès du personnel des programmes concernés et des parties prenantes essentielles de la surveillance. L'information peut être résumée et organisée sous forme de tableaux et de figures dans l'outil d'analyse documentaire, comme décrit dans l'Encadré 2. L'analyse doit être effectuée en collaboration ou en communication avec les partenaires techniques ou d'exécution, ainsi qu'avec le PNLP et les parties prenantes concernées. Elle doit également être itérative et recevoir des mises à jour à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles.

L'analyse documentaire doit être effectuée pour toutes les évaluations de la surveillance. Il faut commencer avant le CQD afin d'identifier les documents sources et les bases de données nationales utilisés pour la surveillance des cas de paludisme et des décès dus à la maladie. L'analyse doit en outre être achevée avant l'enquête afin que les options de réponse au questionnaire puissent être modifiées en fonction des informations qui en découlent.

Les sous-sections suivantes donnent des orientations pour la réalisation de l'analyse documentaire.

2.1.1 Réaliser un examen des documents à l'aide de l'outil d'analyse documentaire

Tous les documents et les données existants qui sont pertinents pour l'évaluation, en fonction des indicateurs sélectionnés, doivent être compilés en collaborant avec le personnel ou les partenaires pertinents du PNLP et en effectuant des recherches en ligne (voir Annexe 2). L'outil d'analyse documentaire indique automatiquement quels documents et données doivent être examinés pour chaque indicateur sélectionné. Noter que les noms et la disponibilité des documents varient selon les pays.

Il est particulièrement important de demander et d'obtenir une liste de référence des établissements de santé (MFL). Celle-ci est essentielle pour les évaluations qui comprennent une enquête systématiquement échantillonnée, pour lesquelles elle servira de base d'échantillonnage. Il est également nécessaire d'évaluer si tous les établissements inclus à la MFL ont notifié des cas au niveau national. Si le pays ne dispose pas d'une telle liste, en prendre note comme une recommandation immédiate et se reporter aux orientations de l'OMS pour les pays sur le renforcement de la MFL (13).

2.1.2 Cartographier les systèmes d'information, les outils d'enregistrement et de notification du paludisme, les variables et les indicateurs de base dans les bases de données nationales

Tous les systèmes d'information, les outils d'enregistrement et de notification du paludisme, ainsi que les variables de ces outils et systèmes d'information ou des bases de données nationales doivent être recensés. Il s'agit d'identifier les systèmes, les outils et les variables existants, la manière dont ils interagissent les uns avec les autres et leurs principales lacunes. Cela nécessite une collaboration étroite et des discussions avec le PNLP et/ou les équipes d'information du ministère de la Santé.

Cartographier les systèmes d'information (objectif 2 du cadre d'évaluation)

Établir une liste de tous les systèmes d'information capturant des données sur le paludisme et indiquer comment ils sont intégrés ou non. Utiliser cette liste pour élaborer un diagramme des systèmes d'information. L'outil donne des exemples de tels diagrammes. Des informations doivent être recueillies sur les principales caractéristiques de chaque système afin de cerner les lacunes et les améliorations potentielles en matière d'intégration et d'interopérabilité.

Cartographier les outils d'enregistrement et de notification des données (objectif 3 du cadre d'évaluation)

Établir une liste des outils d'enregistrement et de notification pertinents utilisés pour la surveillance du paludisme. Il est important de noter les dates auxquelles ces outils ont été utilisés et des changements ont été apportés. La couverture de chaque outil doit également être documentée – par exemple, si certains outils spécifiques ne sont pas normalisés pour l'ensemble du pays et diffèrent selon le secteur de santé ou la région géographique. Il est utile d'obtenir des copies (p. ex., des captures d'écran) de ces outils à des fins de référence et de comparaison.

Cartographier les variables et indicateurs de base du paludisme qui sont collectés et notifiés dans les systèmes d'information (objectif 3 du Cadre d'évaluation)

L'Annexe 3 énumère les variables et indicateurs de base du paludisme recommandés par l'OMS devant être collectés dans le cadre de la surveillance de routine pour chaque stratégie. Ceux-ci sont souvent ventilés par catégorie (p. ex., âge, sexe) ou par secteur de la santé (p. ex., public, privé, communautaire).

Obtenir et examiner la liste de toutes les variables et de tous les indicateurs de base du paludisme, avec leur ventilation respective, qui sont collectés au niveau de la prestation de services, infranational et national. Indiquer l'outil d'enregistrement et/ou de notification dont proviennent ces variables.

S'il n'apparaît pas clairement quelles variables sont utilisées pour calculer les indicateurs, demander des précisions au PNLP, au ministère de la Santé ou aux gestionnaires des bases de données/systèmes d'information respectifs.

Les noms ou les définitions des variables peuvent évidemment changer dans le temps. Prendre note de ces changements pour faciliter l'interprétation de l'analyse plus tard (p. ex., les cas confirmés étaient ceux positifs par microscopie uniquement et sont désormais ceux positifs par microscopie + TDR). Noter que les variables de base du paludisme ne sont pas nécessairement spécifiques à cette maladie (p. ex., décès toutes causes confondues).

Une fois que les variables et les outils sont cartographiés, les variables de base pour le CQD doivent être sélectionnées (voir la section 2.2).

2.1.3 Procéder à des entretiens d'intervenants clés auprès du personnel des programmes et des parties prenantes

Des entretiens d'intervenants clés doivent être menés auprès du personnel des programmes et des diverses parties prenantes impliqués dans la surveillance du paludisme pour compléter l'examen des documents. Une liste de contrôle des personnes interrogées suggérées est fournie à l'Annexe 1. L'outil d'analyse documentaire précise les indicateurs devant être évalués à l'aide d'entretiens d'intervenants clés. Les méthodes d'analyse qualitative ne sont pas recommandées, car les entretiens ne sont pas destinés à être systématiques, mais visent plutôt à combler les lacunes dans les connaissances.

Le personnel de surveillance recherché pour ces entretiens est habituellement composé de membres du personnel du PNLP au niveau national, du ministère de la Santé et du SGIS, ainsi que de partenaires ; toutefois, il peut être nécessaire de procéder à des entretiens avec du personnel au niveau infranational dans certains contextes. La première étape consiste à déterminer la liste des personnes à interroger et les objectifs de chaque entretien, compte tenu du rôle de la personne interrogée dans le programme de lutte contre le paludisme et/ou de surveillance, ainsi que les lacunes de l'analyse documentaire que la personne peut être en mesure de combler.

Pour chaque personne ou groupe interrogé, un guide d'entretien distinct doit être élaboré en fonction des questions fournies dans l'Encadré 2. Les entretiens peuvent être menés en personne, par téléphone ou par téléconférence, selon ce qui est faisable dans le pays. Les entretiens peuvent être enregistrés pour référence ultérieure.

Encadré 2. Outil d'analyse documentaire

L'outil d'analyse documentaire soutient un examen documentaire de la surveillance du paludisme. De plus amples détails sur son utilisation sont fournis dans l'outil en question.

L'outil d'analyse documentaire comporte un onglet pour chaque objectif et les sous-objectifs associés. Les indicateurs qui ont été sélectionnés dans l'outil du cadre d'évaluation apparaîtront automatiquement sous chaque sous-objectif. Pour chaque indicateur, après avoir cliqué sur « Évaluer », une fenêtre « Comment évaluer » s'affiche suggérant des documents à examiner et des répondants à interroger, et donnant des instructions sur la façon de résumer et de compiler l'information et les données dans les tableaux et les figures associés.

The screenshot displays the 'Outil d'analyse documentaire' interface. At the top, there are tabs: 'Définir La Période', 'Collecter Les Données', 'Analyser Les Données', and 'Sélectionner Un Tableau De Bord'. The 'Analyser Les Données' tab is active, showing 'Examen documentaire' and 'Évaluation de la qualité des données'. The 'RÉDUCTION DE LA CHARGE' sidebar lists 'PERFORMANCE', 'CONTEXTE ET INFRASTRUCTURE', 'TECHNIQUE ET PROCESSUS', and 'COMPORTEMENT'. Under 'PERFORMANCE', indicator 1.1.2 is highlighted. The main table lists indicators with their status and evaluation buttons. The 'ÉVALUER' button for indicator 1.1.2 is highlighted. Below, the 'Comment évaluer' window is open, showing instructions and a chart for indicator 1.1.2b.

Statut	Indicateur	ÉVALUER
En cours	1.1.2 Proportion de cas suspects ayant fait l'objet d'un test	ÉVALUER
En cours	1.1.3 Taux de participation des points de prestation de services	ÉVALUER
En cours	1.1.4 Taux de déclaration des points de prestation de services	ÉVALUER
En cours	1.1.7 Le registre d'état civil a une couverture nationale et une qualité élevée	ÉVALUER

Comment évaluer

Déterminer la proportion de tous les cas répondant à la définition de cas suspect qui ont reçu un test parasitologique (TDR) et/ou microscopique. Ceci peut être calculé à partir des données extraites pour le TDR. Si les cas suspects de paludisme ne sont pas directement collectés, ils peuvent être calculés par cas suspects « présumés » testés. Dans les contextes de réduction de la charge, si les données ne sont pas disponibles, le numérateur et les dénominateurs peuvent être obtenus à partir de l'ensemble RDS. Le dénominateur peut être estimé par la proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant de la fièvre qui ont demandé des soins et ont reçu un test de dépistage du paludisme dans le cadre d'une enquête RDS ou RDT. Cet indicateur peut être désagrégré par zone géographique, secteur de santé (public/privé) et/ou groupe d'âge. Graphique et indiquez si la proportion de cas suspects testés a changé au fil du temps et les causes possibles.

De quoi as-tu besoin

- registre des patients/registre national (zones d'élaboration)
- de routine : nombre de cas testés par microscopie et TDR, cas suspects

Figure 1.1.2a Proportion De Suspects Testés Au Fil Du Temps

Indiquer l'année et le pourcentage des suspects testés. Veuillez entrer l'année dans l'ordre croissant. Un minimum d'un point dans le temps doit être saisi pour l'année de données la plus récente afin de compléter l'évaluation de cet indicateur.

Figure 1.1.2b Proportion De Suspects Testés Par Région Pour L'année

Pas atteint

☐ Cet indicateur ne peut pas être évalué

SAUVEGARDER FINALISER

Les champs obligatoires sont en surbrillance et doivent être remplis pour achever l'évaluation de l'indicateur. Certains champs incluent des règles de validation pour éviter la saisie de résultats erronés. Pour chaque indicateur prioritaire, le système attribue automatiquement un score « Atteint », « Partiellement atteint » ou « Pas atteint ». Ces scores sont basés sur des critères propres à chaque indicateur, qui peuvent être consultés en passant la souris sur l'icône « i ».

The screenshot displays the 'Outil d'analyse documentaire' interface. At the top, there are tabs: 'Définir La Période', 'Collecter Les Données', 'Analyser Les Données', and 'Sélectionner Un Tableau De Bord'. The 'Analyser Les Données' tab is active, showing 'Examen documentaire' and 'Évaluation de la qualité des données'. The 'RÉDUCTION DE LA CHARGE' sidebar lists 'PERFORMANCE', 'CONTEXTE ET INFRASTRUCTURE', 'TECHNIQUE ET PROCESSUS', and 'COMPORTEMENT'. Under 'PERFORMANCE', indicator 1.1.2 is highlighted. The main table lists indicators with their status and evaluation buttons. The 'ÉVALUER' button for indicator 1.1.2 is highlighted. Below, the 'Comment évaluer' window is open, showing instructions and a chart for indicator 1.1.2b.

Statut	Indicateur	ÉVALUER
En cours	1.1.2 Proportion de cas suspects ayant fait l'objet d'un test	ÉVALUER
En cours	1.1.3 Taux de participation des points de prestation de services	ÉVALUER
En cours	1.1.4 Taux de déclaration des points de prestation de services	ÉVALUER
En cours	1.1.7 Le registre d'état civil a une couverture nationale et une qualité élevée	ÉVALUER

Comment évaluer

Déterminer la proportion de tous les cas répondant à la définition de cas suspect qui ont reçu un test parasitologique (TDR) et/ou microscopique. Ceci peut être calculé à partir des données extraites pour le TDR. Si les cas suspects de paludisme ne sont pas directement collectés, ils peuvent être calculés par cas suspects « présumés » testés. Dans les contextes de réduction de la charge, si les données ne sont pas disponibles, le numérateur et les dénominateurs peuvent être obtenus à partir de l'ensemble RDS. Le dénominateur peut être estimé par la proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant de la fièvre qui ont demandé des soins et ont reçu un test de dépistage du paludisme dans le cadre d'une enquête RDS ou RDT. Cet indicateur peut être désagrégré par zone géographique, secteur de santé (public/privé) et/ou groupe d'âge. Graphique et indiquez si la proportion de cas suspects testés a changé au fil du temps et les causes possibles.

De quoi as-tu besoin

- registre des patients/registre national (zones d'élaboration)
- de routine : nombre de cas testés par microscopie et TDR, cas suspects

Figure 1.1.2a Proportion De Suspects Testés Au Fil Du Temps

Indiquer l'année et le pourcentage des suspects testés. Veuillez entrer l'année dans l'ordre croissant. Un minimum d'un point dans le temps doit être saisi pour l'année de données la plus récente afin de compléter l'évaluation de cet indicateur.

Figure 1.1.2b Proportion De Suspects Testés Par Région Pour L'année

Atteint

☐ Cet indicateur ne peut pas être évalué

SAUVEGARDER FINALISER

L'utilisateur peut préciser si un indicateur ne peut pas être évalué et en indiquer la raison.

Statut	Indicateur	Action
Complété	1.1.2 Proportion de cas suspects ayant fait l'objet d'un test	ÉVALUER
En cours	1.1.3 Taux de participation des points de prestation de services	ÉVALUER
En cours	1.1.4 Taux de déclaration des points de prestation de services	ÉVALUER
En cours	1.1.7 Le registre d'état-civil a une couverture nationale et une qualité élevée	ÉVALUER

Les indicateurs peuvent être évalués dans n'importe quel ordre. Une fois qu'un indicateur a été évalué, son statut passe à « terminé », ce qui permet aux pays de suivre les progrès réalisés. Les informations saisies pour chaque indicateur peuvent également être enregistrées et complétées à une date ultérieure.

Statut	Indicateur	Action
Complété	1.1.2 Proportion de cas suspects ayant fait l'objet d'un test	ÉVALUER
En cours	1.1.3 Taux de participation de la prestation de services	ÉVALUER
En cours	1.1.4 Taux de notification de la prestation de services	ÉVALUER
En cours	1.1.7 Le système d'enregistrement des faits d'état civil a une couverture nationale et une qualité élevée	ÉVALUER

2.2 Effectuer un contrôle de la qualité des données (CQD)

Des décisions éclairées étant fondées sur des données solides, il est essentiel de veiller à la qualité de ces dernières. Le CQD est un processus d'évaluation qui utilise des indicateurs de qualité spécifiques (p. ex., exhaustivité, actualité, cohérence, concordance) pour déterminer si les données répondent à la qualité requise pour soutenir leur utilisation prévue. Un CQD à l'aide de la boîte à outils ne sera réalisé que pour la surveillance des cas de paludisme et des décès dus au paludisme dans les contextes de réduction de la charge et d'élimination. La boîte à outils ne fournit pas d'outils de CQD pour l'évaluation des stratégies de lutte et d'intervention antipaludiques.

Un CQD peut être réalisé à deux niveaux :

- une analyse au niveau documentaire des données qui ont été notifiées à l'échelle nationale (c.-à-d. les données des systèmes de surveillance nationaux) ; et
- une évaluation (ou un audit) au niveau de la prestation de services pour valider les données notifiées à l'échelle nationale à l'aide des données sources primaires (c.-à-d. les registres de patients).

Les deux niveaux d'évaluation nécessitent l'extraction de données compilées rétrospectivement à partir de bases de données nationales (p. ex., SGIS, système de surveillance intégrée de la maladie et riposte [SIMR], système d'information sur le paludisme) pendant une période spécifique (minimum suggéré de 3 ans pour un CQD au niveau documentaire et de 3 mois pour un CQD au niveau de la prestation de services dans les contextes à transmission élevée, et jusqu'à 12 mois dans les contextes à faible transmission).

Toutes les évaluations de surveillance doivent inclure un CQD au niveau documentaire, qui ne nécessite pas la collecte de données primaires. Les données de surveillance de routine sont extraites du système national principal de surveillance du paludisme et évaluées pour en vérifier l'exhaustivité, l'actualité, la cohérence et la concordance. Dans les contextes d'élimination, les données relatives aux cas doivent être extraites. Bien que l'évaluation doive être effectuée sur le système national de surveillance du paludisme, si d'autres systèmes capturent également les cas de paludisme et les décès associés, des données doivent en être extraites à des fins de comparaison afin d'assurer qu'aucun cas ou décès n'a été omis du système national de surveillance du paludisme. Dans les contextes d'élimination, il est particulièrement important d'inclure dans l'évaluation les données provenant d'un système intégré de notification des maladies existant, tel qu'un système de SMIR ou un SGIS, car celui-ci est susceptible de devenir le principal système de notification du paludisme une fois que la maladie aura été éliminée.

Le CQD au niveau de la prestation de services (souvent appelé audit) exige la collecte de données primaires à partir de sources de données primaires (p. ex., registres de patients, formulaires de collecte de données) au niveau de la prestation de services. Dans les contextes de réduction de la charge, les données compilées à partir des registres des établissements de santé sont comparées aux données agrégées provenant de rapports hebdomadaires ou mensuels extraits des bases de données nationales.

Les évaluations complètes doivent inclure un CQD au niveau de la prestation de services avec un échantillonnage systématique. Les évaluations sur mesure et rapides peuvent inclure un CQD au niveau de la prestation de services avec ou sans échantillonnage systématique. Dans les contextes d'élimination, les données de patients sous forme de liste extraites du système national de surveillance du paludisme doivent être comparées aux données des registres et des formulaires d'investigation des cas pour en garantir l'exhaustivité et l'exactitude, en vérifiant que tous les cas diagnostiqués ont été notifiés, en évaluant si tous les cas confirmés ont fait l'objet d'une investigation et si les formulaires utilisés pour ce faire peuvent être trouvés, et en vérifiant si les cas ont été correctement classés ou non.

La boîte à outils d'évaluation de la surveillance du paludisme s'appuie sur l'approche décrite dans la boîte à outils pour l'examen de la qualité des données de l'OMS (14), qui donne des orientations sur la réalisation d'un CQD général pour les systèmes d'information sanitaire, habituellement effectué par le personnel du SGIS. Le CQD intégré dans cette boîte à outils fournit :

- des indicateurs de qualité des données normalisés supplémentaires spécifiques aux données de surveillance systématique du paludisme ;
- un examen plus approfondi des variables spécifiques au paludisme ; et
- des outils facultatifs adaptés au paludisme pour les niveaux documentaire et de la prestation de services.

Les outils présentés dans cette boîte à outils peuvent ne pas être nécessaires si les outils ou méthodes actuellement utilisés pour réaliser le CQD du programme de lutte contre le paludisme dans le pays incluent les indicateurs de CQD requis pour l'évaluation. Les résultats d'autres activités de CQD (p. ex., les évaluations récentes de CQD du SGIS ou les CQD de routine) peuvent également être utilisés plutôt que de refaire la collecte de données. En outre, certaines plateformes de surveillance (p. ex., le logiciel d'information sanitaire de district DHIS2) ont des contrôles de la qualité des données intégrés pouvant être utilisés directement pour examiner les indicateurs de CQD.

Les sous-sections suivantes décrivent les étapes d'un CQD spécifique au paludisme à l'aide de la boîte à outils. Des détails supplémentaires sur la logistique et la mise en œuvre d'un CQD au niveau de la prestation de services, tels que les rôles et les responsabilités, la mise en place d'un comité de coordination, les échéanciers et les budgets, figurent dans le guide de mise en œuvre de l'examen de la qualité des données de l'OMS (14).

2.2.1 Sélectionner et compiler les données pour les variables de base dont la qualité des données doit être évaluée

Tous les indicateurs de qualité des données fournis dans l'outil du cadre d'évaluation au titre du sous-objectif 1.2 (Qualité des données) sont prioritaires et doivent être évalués. Les indicateurs de qualité des données sont également résumés dans le Tableau 9.

Tableau 9. Indicateurs de la qualité des données et définitions

Indicateur	Définition
Ponctualité	de la notification
	Pourcentage des rapports escomptés reçus à la date d'échéance au cours d'une période donnée
	des rapports de notification de cas
	Pourcentage des rapports de notification de cas reçus dans les 24 heures après la détection, ou conformément aux lignes directrices
	des rapports d'investigation de cas
	Pourcentage des rapports d'investigation de cas reçus dans les 3 jours après la détection, ou conformément aux lignes directrices
	des rapports d'investigation de foyer
	Pourcentage des rapports d'investigation de foyer reçus dans les 7 jours après la détection, ou conformément aux lignes directrices
Exhaustivité	de la notification
	Pourcentage des rapports escomptés reçus au cours d'une période donnée ^a
	des rapports d'enquête de cas
	Pourcentage de cas confirmés ayant fait l'objet d'un rapport d'investigation de cas
	des [1] variables de base dans les rapports
	Pourcentage de rapports reçus (ou de cas notifiés dans les contextes d'élimination) au cours d'une période donnée où toutes les variables de base sont complétées
	des [1] variables de base dans les registres
	Pourcentage de registres (ou de cas notifiés dans les contextes d'élimination) au cours d'une période donnée où toutes les variables de base sont complétées
Cohérence	entre les [1] variables de base sélectionnées
	Pourcentage de rapports reçus (ou de cas notifiés dans les contextes d'élimination) au cours d'une période donnée où toutes les [2] vérifications de la cohérence entre les variables de base sont réussies
	dans le temps pour les [3] tendances des indicateurs de base
	Pourcentage des [3] tendances des indicateurs de base qui sont constantes au cours d'une période donnée (le minimum suggéré est de 3 ans)

Indicateur		Définition
	des [1] variables de base entre deux systèmes de notification	Pourcentage des [4] valeurs de variables de base qui correspondent entre deux systèmes de notification (ou nombre de cas et de décès dans les contextes d'élimination) au cours d'une même période donnée
Concordance	des [1] variables de base dans les registres et les rapports ^a	Pourcentage de valeurs de variables de base qui correspondent entre les registres et les rapports agrégés (ou entre les données de patients sous forme de liste du système national de surveillance du paludisme et des registres dans les contextes d'élimination) au cours de la même période donnée
Erreur de notification^b		Liée à la concordance ci-dessus ; différence de valeur absolue pour chaque variable de base entre une première source de données (D1) et une deuxième source de données (D2)

[1] Les variables de base sont l'ensemble minimum de variables (appelées éléments de données dans le DHIS2) devant être enregistrées dans le système de surveillance du paludisme et dont la qualité des données doit être évaluée. Les variables de base recommandées par l'OMS pour le CQD du paludisme figurent dans l'Annexe 4.

[2] Les vérifications de la cohérence entre les variables de base sont des tests de validation qui permettent d'assurer que les données collectées ont un sens logique. Les vérifications de la cohérence suggérées entre les variables de base figurent dans l'Annexe 5.

[3] Les vérifications de la cohérence dans le temps pour les tendances des indicateurs de base sont utilisées pour déterminer si les tendances sont constantes dans le temps ou, en cas de changements rapides, si ces changements peuvent être expliqués. Des changements rapides dans les données qui ne peuvent pas être expliqués indiquent des problèmes de qualité des données. Ces contrôles doivent être effectués en traçant les valeurs des indicateurs de base dans le temps (mois ou année). Les contrôles suggérés à l'aide d'indicateurs de base pour la surveillance des cas de paludisme figurent dans l'Annexe 6.

[4] Les valeurs des variables de base qui correspondent entre deux systèmes de déclaration sont les valeurs des variables de base correspondantes qui sont notifiées dans le système d'information primaire sur le paludisme et les valeurs de ces mêmes variables notifiées dans un autre système d'information (p. ex., SGIS, système IDSR, laboratoire, données d'état civil). L'objectif est de déterminer si le système de surveillance primaire a capturé tous les cas et si les données sont exactes.

^a Dans les contextes d'élimination, s'il existe à la fois des systèmes agrégés et des systèmes fondés sur les cas, le nombre de cas confirmés notifiés par les deux systèmes doit être comparé. De plus, s'il existe deux systèmes pour saisir les données fondées sur les cas, le nombre de cas dans les deux systèmes doit être comparé. Dans les pays où il n'y a qu'un seul système fondé sur les cas, les cas confirmés notifiés dans les registres des établissements de santé doivent être comparés aux données sous forme de liste extraites du système national de surveillance.

^b Ces indicateurs nécessitent la collecte de données au niveau de la prestation de services. En fonction des objectifs définis pour l'évaluation de la surveillance et pour les ressources et le temps disponibles, il faut décider si ces éléments seront évalués au moyen d'un échantillonnage systématique ou non systématique.

Étape 1. Déterminer les variables de base qui seront utilisées pour évaluer les indicateurs de qualité des données

La première étape consiste à identifier les variables de base qui sont enregistrées et dont la qualité des données peut être évaluée. Se reporter à la section 2.1.2 pour en savoir plus sur la cartographie des variables et des indicateurs de base du paludisme dans les bases de données nationales, ainsi que les outils d'enregistrement et de notification.

Les variables de base recommandées par l'OMS figurent dans l'Annexe 4.

Les questions à noter pour les variables de base sélectionnées sont les suivantes.

- Les pays peuvent sélectionner toutes les variables de base du paludisme ou certaines d'entre elles dans la liste recommandée, en fonction de la disponibilité. Des variables facultatives qui sont d'intérêt pour un pays peuvent également être incluses. Les outils de CQD sont automatiquement personnalisés en fonction de la sélection des variables par l'utilisateur.
- Il convient de noter si et quand les définitions des variables de base changent au fil du temps, car cela peut affecter la qualité des données qui leur sont associées.
- Lors de la comparaison des données entre deux systèmes d'information ou entre des rapports et des registres, les variables de base doivent être définies de la même manière et la couverture géographique et temporelle des systèmes doit être identique (p. ex., comparaison entre les mêmes districts et la même période).
- Les ventilations suivantes sont proposées :
 - par unité administrative (p. ex., région, district) ou par établissement de santé ;
 - par période (p. ex., mois, année) ;
 - par type d'établissement de santé (p. ex., public, privé, communautaire) ; et
 - par patients ambulatoires par opposition aux patients hospitalisés, si les formulaires de notification sont distincts.

Pour certains indicateurs, il est possible que la ventilation puisse être limitée à un certain niveau. Par exemple, dans les contextes à forte charge de morbidité où les données sont agrégées et rapportées dans le DHIS2 au niveau des districts, l'exhaustivité des variables de base dans les rapports ne peut être évaluée que jusqu'au niveau du district par le biais d'un CQD au niveau documentaire.

Étape 2. Accéder aux bases de données nationales ou faire une demande de données

On peut accéder directement aux données des bases de données nationales ou déposer une demande auprès du PNLP, du ministère de la Santé ou du gestionnaire de la base de données concernée.

Si les données sont accessibles directement à partir d'un système d'information (p. ex., la plateforme DHIS2), elles peuvent en être téléchargées. Si les données sont extraites de la plateforme DHIS2, il peut être plus facile d'y accéder et de les extraire directement par l'intermédiaire de l'API au lieu d'utiliser de tableaux croisés dynamiques.

Si les responsables de la mise en œuvre n'ont pas accès aux données des systèmes d'information, une demande d'accès doit être déposée auprès du ministère de la santé concerné, du PNLP ou d'autres propriétaires ou gestionnaires des systèmes d'information de surveillance du paludisme concernés. La demande doit notamment comprendre :

- le nom et la définition de la variable ou de l'indicateur, y compris les calculs (numérateur et dénominateur) ;
- la ventilation géographique requise (p. ex., par district) ;
- la ventilation temporelle nécessaire (p. ex., par mois) ;

- la période d'extraction des données souhaitée (p. ex. 3 ans, de janvier 2017 à décembre 2019) ; et
- le nom du document source et du système d'information d'où proviennent les variables, si possible.

Dans l'idéal et à des fins d'efficacité, l'ensemble des données pertinentes doit faire l'objet d'une seule demande. Toutefois, plusieurs demandes peuvent être nécessaires si des sous-ensembles de données attendus sont absents.

Il est recommandé que les données soient extraites au niveau administratif du système le plus bas possible (pour les bases de données DHIS2, il peut s'agir des districts dans certains pays et d'établissements de santé dans d'autres), et en utilisant la ventilation temporelle la plus faible disponible (p. ex., hebdomadaire).

S'il existe plusieurs bases de données au sein d'un pays (p. ex., plusieurs instances de la plateforme DHIS2), les données pertinentes doivent être extraites de toutes les bases de données disponibles. Les extractions provenant de plusieurs bases de données doivent être aussi comparables que possible (p. ex., suivre une ventilation géographique et temporelle commune).

Étape 3. Effectuer un CQD au niveau documentaire avec l'outil d'évaluation de CQD au niveau documentaire

Si les contrôles de qualité des données et les supports visuels sont déjà intégrés dans les systèmes électroniques, ceux-ci peuvent être utilisés directement dans l'évaluation sans qu'il soit nécessaire d'extraire et d'analyser les données séparément. Il est néanmoins probable qu'une analyse supplémentaire allant au-delà de ce qui est disponible dans le cadre d'un système existant puisse être utile dans la plupart des pays. Des conseils sur l'analyse des données sont fournis sous la Phase 3 dans le présent document.

The screenshot shows the 'Évaluation de la qualité des données' (Data Quality Assessment) tool interface. The interface is in French and shows a step-by-step process for evaluating data quality. The current step is 'Évaluation de la qualité des données' (Data Quality Assessment). The interface is divided into three main sections: 'Niveau Bureau' (Office Level), 'Niveau De Prestation De Service' (Service Delivery Level), and 'Variables'. The 'Variables' section contains a table with checkboxes for various data quality indicators. The 'Concordance' column has a red box around it. The 'Variables' column has a red box around the 'Variables' header. The 'Niveau Bureau' section has a red box around the 'Sélectionnez les systèmes de données' (Select data systems) header. The 'Niveau De Prestation De Service' section has a red box around the 'Sélectionnez les variables à inclure' (Select variables to include) header. The interface also includes a 'RÉINITIALISER' (Reset) button and a 'Télécharger' (Download) button.

Variables	Concordance
☒ Nombre total de cas de paludisme (confirmés + présumés)	☒
☒ Cas de paludisme confirmés	☒
☒ Testés par microscopie	☒
☒ Testés par TDR	☐
☒ Positifs à la microscopie	☐
☒ Positifs au TDR	☐
☒ Patients ambulatoires toutes causes confondues	☐
☒ Patients hospitalisés toutes causes confondues	☐
☒ Décès toutes causes confondues	☐
☒ Patients hospitalisés imputés	☐

A. Database - Health Facility (HF) data from HMIS/DHIS 2																											
Variables - Primary															Variables - Optional												
Province	District	Health Facility	Public / Private	Year	Month	Reports Due Time	Reports Received	Expected Reports	Total malaria cases (Prevalence - Prevalence)	Confirmed malaria cases (Prevalence - Prevalence)	Missingness (Prevalence - Prevalence)	ROI (Prevalence - Prevalence)	Missingness (Prevalence - Prevalence)	ROI (Prevalence - Prevalence)	All cases (Prevalence - Prevalence)	All cases (Prevalence - Prevalence)	All cases (Prevalence - Prevalence)	Malaria (Prevalence - Prevalence)	Malaria (Prevalence - Prevalence)	Suspected malaria cases	Presumed malaria cases	RTP 1-4	ABIS 1-4	Confirmed malaria cases (Prevalence - Prevalence)	Confirmed malaria cases (Prevalence - Prevalence)		
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	1	1	1	1	1650	1237	400	242	995	2309	1283	63	1	1602	210	30	155	10	10	10	10		
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	2	0	1	1	1033	543	577	118	253	1177	80	24	1587	50	135	105	36	102	36	102	36	102	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	3	0	1	1	1052	1052	275	202	900	2390	1089	117	7	105	105	36	102	36	102	36	102	36	102
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	4	1	1	1	1022	793	636	367	781	602	2820	1091	203	4	1238	229	145	30	68	68	68	68	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	5	1	1	1	1182	525	475	279	293	540	1324	754	15	1505	273	46	124	65	65	65	65	65	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	6	1	1	1	1036	694	523	242	223	681	110	690	120	12	980	142	34	106	79	79	79	79	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	7	1	1	1	1008	871	372	33	578	1791	647	175	24	980	237	87	127	53	53	53	53	53	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	8	1	1	1	1035	935	685	143	121	814	110	690	140	11	930	40	60	60	60	60	60	60	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	9	1	1	1	1077	695	433	33	223	456	1044	132	23	895	232	141	76	67	67	67	67	67	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	10	0	1	1	1030	737	712	171	120	677	101	120	236	11	1443	241	120	42	63	63	63	63	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	11	1	1	1	1100	502	356	237	250	662	934	936	146	21	1000	208	12	71	73	73	73	73	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2017	12	1	1	1	103	331	669	262	103	218	1030	909	294	71	181	181	64	25	25	25	25	25	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	1	1	1	1	105	160	367	364	74	76	936	1241	338	93	3	1951	185	183	68	68	68	68	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	2	1	1	1	104	362	443	298	101	261	253	1052	988	231	15	747	62	106	34	34	34	34	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	3	1	1	1	101	225	695	354	84	68	2554	792	62	124	9	369	359	48	97	97	97	97	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	4	1	1	1	104	253	300	613	78	175	1789	620	151	257	10	1153	251	153	138	138	138	138	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	5	1	1	1	1077	363	230	795	145	224	2604	1221	237	195	12	1090	174	63	19	19	19	19	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	6	1	1	1	106	409	204	308	104	225	2180	743	143	145	28	1232	127	21	24	24	24	24	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	7	1	1	1	1062	362	661	577	110	243	2650	1026	50	65	3	1230	6	5	13	13	13	13	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	8	1	1	1	1004	486	530	923	109	227	1009	1051	143	201	4	1433	268	180	185	185	185	185	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	9	1	1	1	105	518	845	783	276	242	1175	1881	281	113	7	1638	207	68	37	37	37	37	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	10	1	1	1	1045	236	73	537	55	241	1039	705	51	153	10	610	82	3	170	216	216	216	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	11	1	1	1	1094	411	285	721	104	227	2308	1608	80	144	17	398	252	147	1	30	30	30	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2018	12	1	1	1	1066	277	380	382	106	91	2778	1514	238	77	23	142	189	36	14	6	6	6	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	1	1	1	1	1047	535	690	74	256	279	144	11	141	11	141	112	42	88	44	44	44	44	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	2	1	1	1	104	360	611	505	240	7	182	1444	66	262	7	1186	154	190	77	20	20	20	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	3	1	1	1	1038	440	622	622	234	234	1942	192	275	4	100	71	82	30	30	30	30	30	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	4	1	1	1	1003	371	630	355	62	269	1032	153	248	22	685	132	6	120	17	17	17	17	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	5	0	1	1	106	232	642	535	12	130	1036	191	180	28	1177	152	167	146	21	21	21	21	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	6	1	1	1	1067	373	777	270	35	278	1276	235	245	19	1047	54	103	109	20	20	20	20	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	7	1	1	1	1059	373	232	236	105	108	1153	137	70	1	1088	86	35	132	23	23	23	23	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	8	1	1	1	1039	950	236	643	80	70	601	109	11	109	11	109	109	3	3	3	3	3	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	9	1	1	1	1076	391	439	912	120	271	768	145	2	1351	185	93	104	32	32	32	32	32	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	10	1	1	1	1072	274	202	203	100	230	1070	180	21	1070	180	52	54	34	34	34	34	34	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	11	1	1	1	1020	291	602	571	232	53	1000	106	6	106	6	106	123	54	127	21	21	21	
Province A	District 1	Health Facility 1	Public	2019	12	1	1	1	1019	233	423	450	102	101	1317	137	117	5	127	206	186	161	6	6	6	6	
Province A	District 1	Health Facility 2	Private	2017	1	1	1	1	481	272	317	474	126	146	1603	1037	145	20	1591	239	39	200	16	16	16	16	
Province A	District 1	Health Facility 2	Private	2017	2	1	1	1	1044	548	772	437	253	287	2810	643	268	3	1029	38	43	127	43	43	43	43	
Province A	District 1	Health Facility 2	Private	2017	3	1	1	1	1076	309	304	377	203	106	1417	695	132	3	1501	267	151	8	18	18	18	18	
Province A	District 1	Health Facility 2	Private	2017	4	1	1	1	1030	375	436	438	144	171	1604	652	205	10	1752	203	120	144	15	15	15	15	
Province A	District 1	Health Facility 2	Private	2017	5	1	1	1	1023	351	390	781	180	241	2441	1402	202	20	1691	272	16	99	31	31	31	31	
Province A	District 1	Health Facility 2	Private	2017	6	0	0	1	107	322	300	362	116	206	1773	1752	275	13	1270	240	113	8	27	27	27	27	
Province A	District 1	Health Facility 2	Private	2017	7	1	1	1	1062	322	300	362	116	206	1773	1752	275	13	1270	240	113	8	27	27	27	27	

Les indicateurs de qualité des données sont automatiquement calculés et affichés sous forme de graphiques et de tableaux aux niveaux national et infranational. Ceux-ci peuvent être consultés dans la section Analyse des données, et chaque image peut être exportée pour être utilisée directement dans un rapport.

Définir La Portée
Collecter Des Données
L'analyse Des Données
Générer Un Tableau De Bord

Examen Documentaire

Évaluation De La Qualité Des Données

1 Niveau bureau

2 Niveau de prestation de service

Indicateur

1.2.1 Exhaustivité des notifications

1.2.3 Punctualité des notifications

1.2.7 Exhaustivité des variables de base dans les rapports

1.2.8 Cohérence entre les variables de base

1.2.9 Cohérence dans le temps pour les indicateurs de base

1.2.10 Concordance des variables de base entre deux systèmes de notification

Résumé des résultats

EXPORTER

VUE

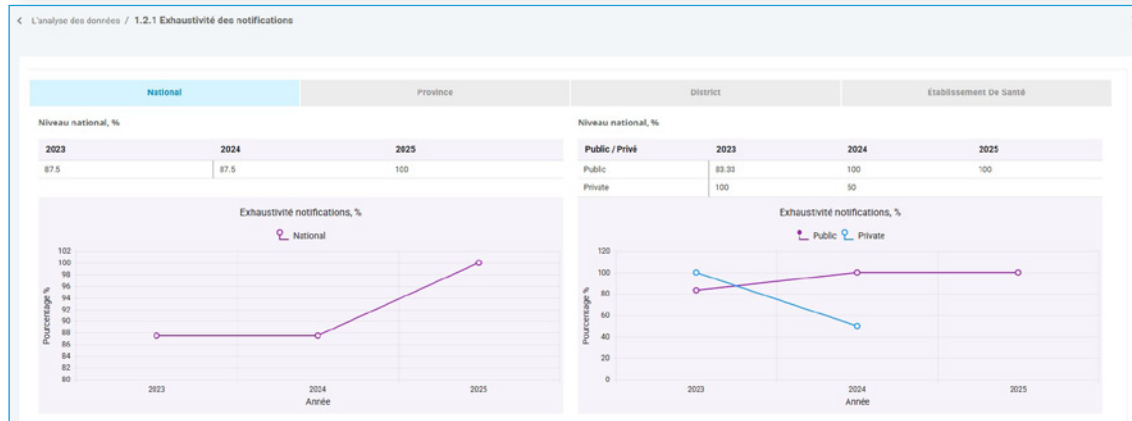
VUE

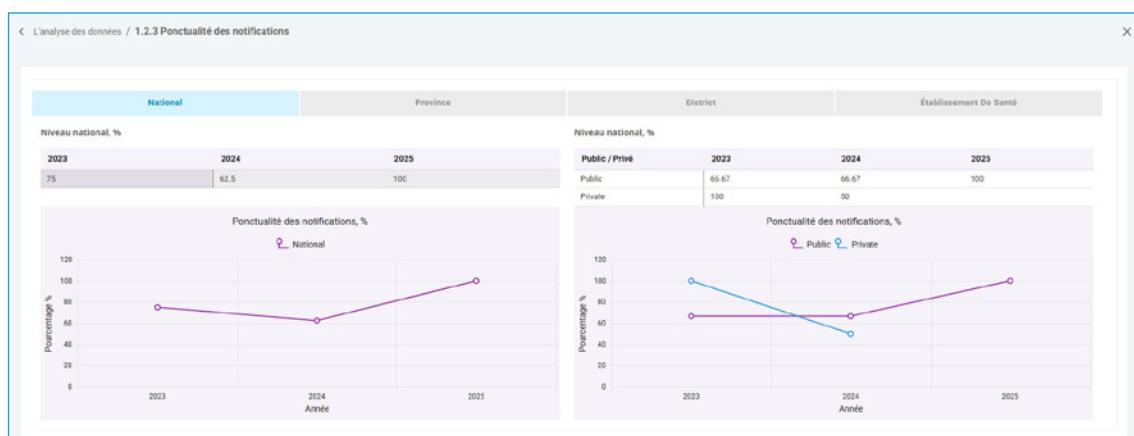
VUE

VUE

VUE

VUE





Un tableau récapitulatif de tous les indicateurs de qualité des données à l'échelle nationale est également fourni.

< L'analyse des données / Résumé des résultats

Année des résultats: 2019

Indicateurs	Résultats au niveau national (%)	Cible au niveau national
1.2.1 Intégrité des rapports	100	80
1.2.3 Délai de notification	86	90
1.2.7 Complétude des variables de base dans les rapports	81	90
1.2.8 Cohérence entre les variables de base	0	80
1.2.10 Concordance des variables de base entre deux systèmes de déclaration	64	80

1.2.9 Cohérence dans le temps pour les indicateurs de base

Si un indicateur n'a pas été évalué, veuillez sélectionner « oui » pour la cohérence dans le temps afin qu'elle n'ait pas d'impact négatif sur le résultat final (atteint/non atteint).

Tendance constante (Oui/Non)

- Proportion de patients ambulatoires atteints de paludisme: ☒ Oui ☐ Non ☐ NA
- Proportion de patients hospitalisés pour paludisme: ☒ Oui ☐ Non ☐ NA
- Proportion de décès de patients hospitalisés pour le paludisme: ☒ Oui ☐ Non ☐ NA
- Taux de positivité des tests: ☒ Oui ☐ Non ☐ NA
- Taux de positivité labo: ☒ Oui ☐ Non ☐ NA
- Taux de positivité des RDT: ☒ Oui ☐ Non ☐ NA
- Proportion de suspects testés: ☒ Oui ☐ Non ☐ NA

1.2.14 Raisons de la cohérence dans le temps pour les indicateurs de base

1.2.14 Raisons des résultats observés en matière de qualité des données.

* Cible de couleur pour les données avec pourcentage : les cellules **rouges** indiquent que le pourcentage est inférieur à 80 % et supérieur à 100 % ; les cellules **jaunes** indiquent que le pourcentage est compris entre 80 % et 95 % et les cellules **vertes** indiquent que le pourcentage est supérieur à 95 %

EXPORTER

Dans les contextes d'élimination, l'outil Microsoft Excel peut être téléchargé à partir de la plateforme numérique. Le remplissage du modèle normalisé avec des données fondées sur les cas générera automatiquement des graphiques et des tableaux dans l'outil lui-même. Il est nécessaire de personnaliser l'outil en fonction du contexte du pays. De plus amples détails sur l'utilisation des outils sont inclus sous un onglet d'instructions dans les outils téléchargés manuellement.

Étape 4. Déterminer quels points de collecte de données seront inclus dans le CQD au niveau de la prestation de services

La collecte des données aux points de prestation de services peut être effectuée parallèlement à l'enquête (voir la section 2.3), puisque la base d'échantillonnage est la même, ou bien dans le cadre de la supervision de routine ou d'autres visites programmatiques des établissements.

Déterminer quels établissements feront l'objet d'une vérification dans le cadre du CQD au niveau de la prestation de services. Des renseignements détaillés sur l'échantillonnage systématique se trouvent à la section 1.2.3.

Pour des évaluations rapides ou sur mesure dans les contextes de réduction de la charge, il n'est pas nécessaire d'effectuer un CQD complet au niveau de la prestation des services, mais il est important d'avoir une idée des principales lacunes et des problèmes essentiels pouvant être corrigés dans le cadre des activités de renforcement des systèmes de surveillance. Dans ce cas, deux établissements de santé à faible charge et deux à charge élevée et/ou des agents de santé communautaires dans deux ou trois districts (ou au niveau infranational concerné) peuvent être sélectionnés dans le cadre de l'examen. Le PNLP pourrait profiter de l'occasion pour investiguer auprès des établissements qui présentent des défis connus et pour visiter ceux dont la notification et les données sont de qualité afin d'en tirer des enseignements sur les meilleures pratiques. Ces visites peuvent aussi servir à évaluer la qualité des données à partir des registres de patients et des outils de notification, des outils d'enregistrement, du flux de données et de la vérification/validation des résultats de l'analyse documentaire.

Si le CQD est mis en œuvre dans un contexte d'élimination, les niveaux documentaire et de la prestation de services sont requis. Des outils permettant d'évaluer à la fois les données agrégées (réduction de la charge) et les données fondées sur les cas (élimination) peuvent être nécessaires si le pays dispose d'une combinaison de systèmes de surveillance utilisant des données agrégées et fondées sur les cas.

Étape 5. Désigner du personnel pour les activités de collecte et d'examen des données, et lancer des processus de nomination de personnel supplémentaire au besoin

Le personnel minimum requis pour une évaluation du paludisme effectuée à l'aide de la boîte à outils est le suivant :

- gestionnaire ou responsable de l'évaluation pour superviser toutes les activités de collecte de données applicables (c.-à-d. CQD, analyse documentaire et enquête) ; et
- analyste(s) de données pour effectuer l'examen des documents et l'analyse rétrospective du CQD.

Si l'on effectue une collecte des données au niveau de la prestation de services (CQD et/ou entretiens), du personnel supplémentaire est nécessaire :

- supérieurs hiérarchiques de terrain ;
- personnel chargé de la collecte de données ;
- analystes de données pour gérer et analyser les données d'enquête et de CQD ; et
- personnel chargé de la saisie des données (si celles-ci sont consignées sur papier).

Dans certains cas, la collecte de données au niveau de la prestation de services peut être effectuée en même temps que d'autres activités programmatiques prévues ou courantes. Sinon, il peut s'avérer nécessaire d'engager une entreprise de collecte de données afin de disposer des ressources humaines requises pour réaliser l'enregistrement des données d'enquête et/ou d'audit et les documents de notification.

Étape 6. Collecter des données à partir des documents sources pour le CQD au niveau de la prestation de services

Les outils d'évaluation de CQD au niveau de la prestation de services sont utilisés pour recueillir des données primaires. Ces outils doivent être utilisés pour l'échantillonnage systématique et non systématique afin d'assurer l'uniformité de l'approche et de l'analyse. Des détails sur l'utilisation des outils sont inclus sous un onglet d'instructions dans les outils téléchargés manuellement. Les outils sont utilisés pour recueillir des données à partir d'outils de collecte de données de routine (p. ex., registres au niveau de la prestation de services) et, dans les contextes de réduction de la charge, pour comparer ces données avec des rapports agrégés reçus au niveau national ou au niveau des districts (rapports des établissements de santé). Dans les contextes d'élimination, les données issues des outils de collecte de données de routine sont comparées aux données fondées sur les cas.

Les outils sont adaptables en ce sens qu'ils permettent de modifier les noms des variables de base existantes. Il est important de noter que les variables de base de l'outil doivent être remplacées par celles qui sont couramment utilisées par le pays. La source de données peut également être modifiée pour permettre de comparer des données provenant de différentes sources (p. ex., patients ambulatoires ou patients hospitalisés, établissements de santé ou laboratoires). La période recommandée est de 3 mois complets dans les contextes à forte transmission et jusqu'à 12 mois dans les contextes à faible transmission, se terminant le mois précédant le début de la collecte des données.

Dans les contextes de réduction de la charge (ou ceux où des données agrégées sont utilisées), l'utilisateur commence par sélectionner la période, les variables de base et les registres (ambulatoire, hospitalier et/ou laboratoire) qui seront évalués à l'aide du modèle dans la plateforme numérique.

Un classeur Microsoft Excel normalisé est ensuite exporté en fonction de la sélection. L'outil doit être renseigné avec les données agrégées des rapports de l'établissement de santé évalué, extraites du système national de surveillance. Les données primaires pour les mêmes variables saisies dans le registre de l'établissement peuvent ensuite être saisies dans un onglet différent du même classeur à des fins de comparaison.

Une fois que l'outil d'évaluation de CQD au niveau de la prestation de services a été rempli pour chaque établissement sélectionné, les données doivent être compilées en un seul ensemble de données à des fins d'analyse.

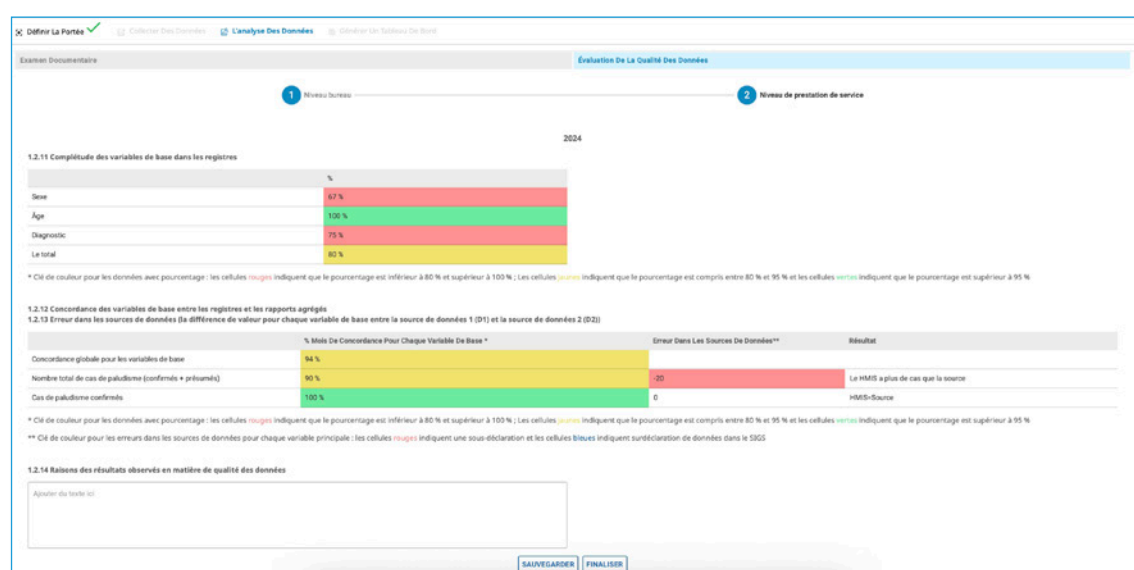
Il existe trois options pour ce processus.

- L'outil d'évaluation de CQD au niveau de la prestation de services dans Microsoft Excel peut être programmé en tant que formulaire de collecte de données électronique (p. ex.,

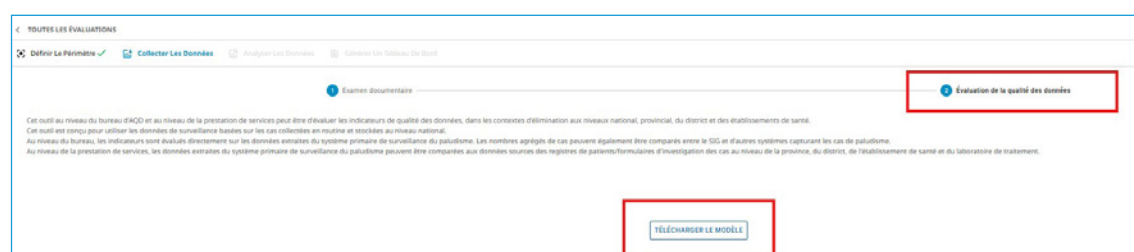
à l'aide de la plateforme de collecte de données Open Data Kit [ODK]). Cela signifie que les données collectées auprès de chaque point de prestation de services ou emplacement infranational peuvent être saisies et automatiquement agrégées dans une base de données unique.

- Une macro Microsoft Excel (développée par le Program for Appropriate Technology in Health, PATH) peut être utilisée pour compiler les classeurs individuels d'évaluation de CQD au niveau de la prestation des services de chaque point de prestation de services ou emplacement infranational en une seule base de données.
- Les données peuvent être saisies dans une base de données (p. ex., Access) manuellement ou à l'aide d'une autre modalité sur mesure.

Le rapport final doit inclure un seul ensemble de résultats de CQD, présentés dans le tableau de bord de CQD des outils d'évaluation de CQD au niveau de la prestation de services. Le résumé des résultats doit être téléchargé ou saisi à nouveau dans la plateforme numérique.



Dans les contextes d'élimination, l'outil de CQD peut être téléchargé à partir de la plateforme numérique. Il doit être renseigné avec les données fondées sur les cas extraites de la base de données nationale de surveillance du paludisme, puis contrôlé pour en vérifier l'exhaustivité et l'exactitude par une comparaison avec les cas figurant dans les registres ou les formulaires d'investigation.



Le nombre de cas signalés à chaque niveau du système de santé pour un même établissement de santé doit également être comparé. En outre, il convient de vérifier l'exactitude de la classification pour chaque cas classifié. Les algorithmes de classification des cas sont fournis sous un onglet d'instructions de l'outil afin de faciliter la classification pour les pays. Les résultats sommaires peuvent être saisis dans un tableau de la plateforme numérique.

Examen Documentaire

Évaluation De La Qualité Des Données

Veuillez compléter le résumé des résultats nationaux de la qualité des données de l'évaluation de l'EQD sur l'élimination.

Année des évaluations
2024

Résumé des résultats nationaux sur la qualité des données	Résultats au niveau national (%)
1.2.1 Intégralité des rapports	☒ Atteint ☐ Pas atteint
1.2.2 Exhaustivité des rapports d'enquête sur les cas	96
1.2.4 Rapidité des rapports de notification des cas	81
1.2.5 Rapidité des rapports d'enquête sur les cas	85
1.2.6 Ponctualité des rapports d'enquête sur les foyers	88
1.2.7 Complétude des variables de base dans le rapports	50
1.2.8 Cohérence entre les variables de base	50
1.2.9 Cohérence dans le temps pour les indicateurs de base* <i>Oui si toutes les tendances sont cohérentes pour chaque indicateur de base ou si les incohérences peuvent être expliquées et ne sont pas dues à des problèmes de qualité des données</i>	☐ Atteint ☒ Pas atteint
Indicateurs de base	Tendance constante (Oui/Non)
1. Nombre de cas confirmés de paludisme notifiés	☒ Oui ☐ Non

2.2.2 [Facultatif/au besoin] Publier une invitation à soumissionner (ou similaire) pour une entreprise de collecte de données

Si une entreprise de données externe est engagée pour effectuer une mise en œuvre partielle de l'évaluation (p. ex., collecte de données primaires au niveau de la prestation de services), une invitation à soumissionner peut être publiée afin d'assurer un processus de candidature et de sélection équitable. Ces invitations doivent être publiées conformément aux directives du pays, à l'aide de modèles spécifiques à chaque pays. Cependant, le contenu suivant doit être inclus :

- un aperçu de l'évaluation (peut être extrait de la note de synthèse) ;
- un tableau qui résume les phases et les activités auxquelles l'entreprise de données participera ;
- une description des outils pertinents de la boîte à outils avec des liens vers ceux-ci ;
- une liste des activités spécifiques dont l'entreprise de données et les partenaires d'exécution seront responsables ;
- une liste des prestations attendues de chaque partie, avec des échéanciers ; et
- un résumé des activités de communication et de notification attendues.

2.2.3 [Facultatif/au besoin] Obtenir l'approbation d'un contrat avec une entreprise de collecte de données

Pour qu'une entreprise de données externe soit engagée avec succès, un contrat signé est nécessaire (avec les signatures de toutes les parties concernées, à savoir le contractant et la partie dirigeante). Les exigences et les formats contractuels varient d'une organisation à l'autre ; toutefois, le contenu suivant doit être inclus, en plus du langage juridique pertinent requis pour les partenaires responsables :

- une liste des activités spécifiques dont l'entreprise de données et les partenaires d'exécution seront responsables ;
- une liste des prestations attendues de chaque partie, avec des échéanciers ;
- un résumé des activités de communication et de notification attendues ;

- un plan de travail détaillé ; et
- un budget détaillé.

2.2.4 [Facultatif/au besoin] Préparer, planifier et mener la formation de mise en œuvre, y compris la mise à l'essai des outils de collecte de données

Une formation sur la mise en œuvre est requise pour les évaluations complètes ou sur mesure avec une collecte de données primaires au niveau de la prestation de services. Pour le personnel de mise en œuvre (collecteurs de données, superviseurs, personnel de saisie et d'analyse des données), une formation complète est essentielle pour garantir une évaluation de la surveillance du paludisme cohérente et fiable. Les objectifs généraux (13) de la formation sont les suivants :

- s'assurer que le personnel connaît bien le contexte plus élargi et la raison d'être des évaluations, les principales activités qui en relèvent et la façon dont elles seront menées ;
- donner aux équipes de collecte de données l'occasion de participer à des exercices pratiques afin qu'elles puissent s'exercer à l'aide d'outils ;
- s'assurer que le personnel comprend ses rôles et responsabilités vis-à-vis de l'enquête, y compris les tâches, les échéanciers, les exigences en matière de notification et les prestations attendues ;
- s'assurer que le personnel est averti des problèmes courants pouvant survenir au cours des activités d'enquête et qu'il comprend les stratégies de résolution pour y remédier ;
- s'assurer que le personnel reconnaît la valeur intrinsèque de données de bonne qualité et qu'il est motivé à en assurer la qualité dans le cadre de ses activités ; et
- soutenir la planification de la collecte de données et la supervision, des opérations de saisie et d'analyse, et de la logistique.

La formation du personnel responsable de la collecte et des superviseurs doit être organisée juste avant la mise en œuvre de la collecte de données primaires. Cependant, ces responsables doivent également faire au préalable des essais des outils au cours du processus. Dans l'idéal, les outils d'enquête doivent être immédiatement mis à jour et prêts à être utilisés sur le terrain.

2.3 Mener une enquête auprès du personnel de surveillance à tous les niveaux concernés du système de santé (agents de santé communautaires, établissements de santé et hôpitaux, bureaux de district/régionaux)

Une enquête réalisée à l'aide de cette boîte à outils consiste à réaliser des entretiens structurés à différents niveaux du système de santé en utilisant la méthodologie d'une enquête transversale systématique, afin de recueillir des informations sur des indicateurs exceptionnels ou de valider des informations provenant d'évaluations au niveau documentaire.

L'enquête peut être menée auprès du personnel de surveillance au niveau infranational (district, régional), ainsi qu'auprès du personnel de surveillance (souvent des agents de santé) au niveau de la prestation de services (y compris les hôpitaux et les établissements de santé) et au niveau

communautaire (agents de santé communautaires). Un questionnaire doit être élaboré et adapté à chacun de ces niveaux du système de santé (types de répondants). L'enquête peut être menée en parallèle ou après le CQD au niveau de la prestation de services. La base d'échantillonnage de l'enquête doit être la même que celle du CQD (se reporter à la section 1.2.3 pour plus d'information sur l'échantillonnage systématique).

Pour les évaluations rapides et sur mesure, plutôt que de mener une enquête systématique, des entretiens non systématiques sont menés dans le cadre du CQD au niveau de la prestation de services, en effectuant si nécessaire des visites supplémentaires des partenaires clés. L'objectif est de valider l'information contenue dans les documents clés, de combler les lacunes dans les connaissances et de vérifier les informations qui ont été consignées dans le cadre de l'analyse documentaire.

2.3.1 Configurer les questionnaires à l'aide de la banque de questions pour chaque type de répondant visé

Une enquête sera réalisée à l'aide de questionnaires configurés à l'aide de la banque de questions de la plateforme numérique. Il s'agit d'une liste complète de questions correspondant à tous les indicateurs applicables dans le cadre d'évaluation. La banque de questions de la plateforme numérique est automatiquement filtrée en fonction des indicateurs sélectionnés dans l'outil du cadre. L'utilisateur peut choisir parmi les questions restantes et les personnaliser en fonction du contexte du pays. Des questionnaires sont générés automatiquement pour tous les niveaux pertinents du système de santé. L'Encadré 3 décrit les étapes de l'élaboration des questionnaires.

2.3.2 Mener et suivre une enquête auprès du personnel de surveillance à tous les niveaux concernés du système de santé

Les étapes standard de l'enquête sont les suivantes.

1. Identifier les personnes interrogées cibles. Il peut y avoir plusieurs membres du personnel responsables de la surveillance, auquel cas plusieurs entretiens peuvent être menés pour produire des données représentatives de l'établissement ou du bureau concerné. Toutefois, un seul entretien peut être fait si un membre du personnel peut répondre aux questions en tant que représentant de l'unité d'intérêt (p. ex., l'établissement).
2. Présenter les méthodes de collecte de données à l'établissement de santé, au prestataire de soins concerné ou au personnel de surveillance. Le personnel responsable de la collecte doit disposer d'un script ou avoir reçu une formation sur la présentation du but, des objectifs et du contenu général de l'enquête aux personnes interrogées afin qu'elles soient informées du processus et en mesure de consentir à l'entretien.
3. Obtenir le consentement. Chaque questionnaire comprend une section qui confirme que le consentement a été obtenu de chaque participant. Le consentement écrit ou verbal de toutes les personnes interrogées doit être obtenu avant de procéder à l'entretien.
4. Réaliser l'entretien. Chaque entretien doit être mené de la même manière et ne doit pas dépasser la durée prévue indiquée dans la formation ou le manuel de terrain. Certaines parties du questionnaire peuvent être mises en œuvre sous forme d'auto-évaluation, c'est-à-dire remises à la personne interrogée pour qu'elle les remplisse elle-même plutôt que par le biais d'un entretien. Les outils d'évaluation auto-administrés peuvent être recueillis lors de la première visite de l'équipe d'enquête ou ultérieurement.
5. Surveiller la collecte des données. Une surveillance étroite est recommandée au cours de la collecte des données (qu'il s'agisse du CQD au niveau de la prestation de services ou de l'enquête). Certaines des meilleures pratiques sont décrites ci-dessous.

Fréquence

Pour la phase initiale de la collecte des données (p. ex., 1 semaine), les données soumises doivent dans l'idéal être analysées à la fin de chaque jour de collecte. En fin de journée, un retour d'information doit être fourni à l'équipe de collecte de données, aux superviseurs et aux équipes responsables de la mise à jour des outils de collecte. Après cette phase, les contrôles de surveillance des données peuvent être moins fréquents.

Rapport

Un bref rapport de surveillance des données doit être élaboré chaque jour, qui comprend les éléments suivants :

- un résumé du nombre d'événements de collecte de données, organisés par équipe de collecte et/ou par région/district (par rapport à ce qui était prévu dans les plans initiaux) ;
- un résumé des données manquantes, incorrectes, incomplètes ou en double ;
- toute autre réponse inattendue ; et
- des recommandations sur la façon de rectifier la trajectoire sur le terrain et d'améliorer l'outil de collecte de données lui-même.

Encadré 3. Banque de questions

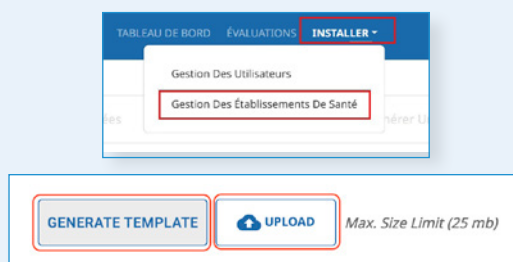
Il s'agit d'une liste complète de questions correspondant à tous les indicateurs applicables dans le cadre d'évaluation. La banque est structurée de manière à ce que des questionnaires distincts et adaptés puissent être élaborés pour chaque niveau du système de santé (type de répondant) à interroger.

Les questionnaires peuvent nécessiter une contextualisation plus poussée par pays. Des notes dans la banque de questions indiquent les cas où cela peut être nécessaire. Cependant, chaque questionnaire doit être soigneusement examiné, révisé et mis à l'essai avant d'être utilisé dans un nouveau contexte.

Les étapes pour élaborer des questionnaires à partir de la banque de questions sont les suivantes.

Étape 1. Télécharger les sites échantillons (établissements de santé)

À l'aide du modèle normalisé de la plateforme numérique sous la rubrique « Health Facility Management » (Gestion des établissements de santé), télécharger les sites échantillons pour l'enquête. Ces sites échantillons seront utilisés pour renseigner automatiquement un menu déroulant dans les questionnaires.



Étape 2. Filtrer par type de répondant

Sélectionner chaque niveau du système de santé à inclure dans l'enquête (niveau infranational – bureau/unité de surveillance, niveau de prestation de services et niveau communautaire). Cela produit des questionnaires distincts pour chaque niveau sélectionné.

The screenshot shows the 'Collect Data' step in the 'MALARIA SURVEILLANCE ASSESSMENT TOOLKIT'. The interface includes a progress bar with four steps: 1. Desk Review, 2. Data Quality Assessment, 3. Question Bank (highlighted with a red box), and 4. Survey Result. Below the progress bar, there is a question: 'Do you want to view list of health facilities?' with radio buttons for 'Yes' and 'No' (selected). Below this, a section titled 'Answer the following questions to configure the survey questionnaires' contains two red-bordered boxes. The first box is labeled 'Select respondent type' and has three checked checkboxes: 'Subnational Level Surveillance Office/Unit', 'Service Delivery', and 'Community'. The second box is labeled 'Do you want to include self assessment questionnaires?' with radio buttons for 'Yes' (selected) and 'No'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'CONFIGURE SURVEY QUESTIONNAIRES'.

Étape 3. Sélectionner les questions à inclure dans les questionnaires à partir de la banque de questions

La banque de questions est automatiquement filtrée en fonction des indicateurs sélectionnés au préalable dans l'outil du cadre d'évaluation. Les questions sont spécifiques à chaque niveau du système de santé, et sont organisées par niveau du système de santé (type de répondant) ainsi que par objectif, sous-objectif et indicateur.

Si souhaité, l'utilisateur peut passer en revue les questions pour chaque indicateur et décider de les inclure ou non et de modifier la formulation des questions en fonction du contexte du pays. Des instructions sont fournies au début de la configuration du questionnaire. Certaines options de réponse doivent être renseignées à partir des résultats de l'analyse documentaire. Celles-ci sont indiquées dans l'outil. Les questions qui sont requises pour l'évaluation d'un indicateur particulier sont marquées comme obligatoires et ne peuvent pas être désélectionnées.

The screenshot shows the 'CONFIGURE SURVEY QUESTIONNAIRES' window. It has a title bar with 'Survey Setup' and 'CONFIGURE SURVEY QUESTIONNAIRES'. Below the title bar, there is a section titled 'How to configure' with a question mark icon. The main content area is divided into three tabs: 'Subnational Level Surveillance Office/Unit' (selected), 'Service Delivery', and 'Community'. Under the 'Subnational Level Surveillance Office/Unit' tab, there are four sub-tabs: 'PERFORMANCE', 'CONTEXT AND INFRASTRUCTURE' (selected), 'TECHNICAL AND PROCESSES', and 'BEHAVIOUR'. Under 'CONTEXT AND INFRASTRUCTURE', there are two sub-sections: '2.2 INFORMATION SYSTEMS' (selected) and '2.2.2 Information system attributes are adequate'. Under '2.2 INFORMATION SYSTEMS', there is a table with two columns: 'Question' and 'Response options'. The first row has a checked checkbox in the 'Question' column and the text 'Which systems do you report malaria cases data into?' in the 'Response options' column. Below the table, there is a text box with the instruction: 'Please fill out these tools first in Desk Review before entering data in Questionnaire'. To the right of the table, there is a section titled 'Notes for interviewer' with the same instruction.

Une fois les questionnaires finalisés, ils seront automatiquement exportés sous forme de classeur Microsoft Excel à partir de la plateforme numérique, avec un classeur associé contenant des tableaux de plan d'analyse pour saisir les résultats, si nécessaire.

BANQUE DE QUESTIONS											
Utilisez ces colonnes pour filtrer par Indicateur. Cliquez "✓" sélectionné. Ceci sera automatisé dans l'application web pour le v2.0.						Utilisez ces colonnes pour sélectionner les questions applicables à chaque type de répondant. Cliquez "✓" sélectionné.			Copiez les questions d'écran dans Word ou Excel pour créer des questionnaires distincts pour chaque type de répondant.		
Étape 1 : Cadre d'évaluation de la surveillance						Étape 2 : Type de répondant			Étape 3 : Banque de questions		
Objectif (sous-objectif)	N° Indicateur	Indicateur	Contenus de réduction de la charge	Contenus d'élaboration	Niveau Informationnel	Niveau d'unité de surveillance	Niveau de la production de données	Niveau communautaire	Code	Question	
2. CONTEXTE ET INFRASTRUCTURE											
2.1 SECTEURS ET STRATÉGIES LIÉS À LA SURVEILLANCE											
	2.1.1	Le paludisme est une maladie à déclaration obligatoire	✓	Élimination	non	oui	oui		vector_1	Qu'est-ce qui déclenche une notification de cas ?	
	2.1.1	Le paludisme est une maladie à déclaration obligatoire	✓	Élimination	non	oui	oui		vector_2	Que se passe-t-il après la notification d'un cas ?	
	2.1.1	Le paludisme est une maladie à déclaration obligatoire		Élimination	non	oui	oui		vector_3	Quelles sont les principales difficultés liées à la notification des cas ?	
	2.1.2	Tous les secteurs sont tenus de déclarer les cas de paludisme		Élimination	non	oui	oui		vector_4	Déterminez-vous l'existence d'un mandat pour signaler les cas de paludisme ?	
	2.1.2	Tous les secteurs sont tenus de déclarer les cas de paludisme		Élimination	non	oui	oui		vector_5	Est-ce que vous notifiez même s'il n'y a aucun cas ?	
	2.1.2	Tous les secteurs sont tenus de déclarer les cas de paludisme	✓	Élimination	non	oui	oui		vector_6	Notifiez-vous des données spécifiques aux cas ?	
2.2 SYSTÈMES D'INFORMATION											
	2.2.1	Systèmes d'information		Élimination	oui	oui	non		SI_1	Dans quels systèmes notifiez-vous les données sur les cas de paludisme ?	
	2.2.2	Les attributs du système d'information		Élimination	oui	oui	non		SI_2	Au cours des deux dernières semaines, avez-vous connu des défaillances temporaires du système d'information qui vous ont empêché de collecter ou de notifier des données ?	
Instructions Informations générales Banque de questions Comment lister des fichiers											

A	B	C	D	E	F	G																				
Indicator selected (Yes)	N° Indicateur	Indicateur	Lien vers la banque de questions (code). Filtrez en utilisant les questions qui ont été sélectionnées pour l'enquête		Tableau structurée vide Les résultats agrégés de toutes les régions, districts et établissements de santé peuvent être saisis ici. Le non chaque réponse doit être saisi dans la colonne G (N) et les pourcentages sont automatiquement calculés en totale (nombre total d'interviewés) comme dénominateur, sauf indication contraire. Ce tableau peut être saisi des données désagrégées (voir explication et exemples dans "Données désagrégées").																					
1	1	PERFORMANCE																								
2	1.3	UTILISATION DES DONNÉES																								
3	Oui	1.3.1	Données utilisées pour les processus stratégiques, politiques et opérationnels	d1ause_1	Quels processus stratégiques et opérationnels ont été étayés par les données de surveillance au cours des 36 derniers mois ? <table> <tr> <td></td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>a. Élaboration de plans opérationnels infranationaux</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Stratification pour le ciblage et la priorisation de l'intervention</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Plaidoyer en faveur d'une politique ou d'un programme</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Suivi des performances/progress du programme en vue de l'atteinte des cibles nationales</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Distribution de produits</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. Aucun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>g. Ne sait pas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h. Autre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>			N	a. Élaboration de plans opérationnels infranationaux		b. Stratification pour le ciblage et la priorisation de l'intervention		c. Plaidoyer en faveur d'une politique ou d'un programme		d. Suivi des performances/progress du programme en vue de l'atteinte des cibles nationales		e. Distribution de produits		f. Aucun		g. Ne sait pas		h. Autre		Total	
	N																									
a. Élaboration de plans opérationnels infranationaux																										
b. Stratification pour le ciblage et la priorisation de l'intervention																										
c. Plaidoyer en faveur d'une politique ou d'un programme																										
d. Suivi des performances/progress du programme en vue de l'atteinte des cibles nationales																										
e. Distribution de produits																										
f. Aucun																										
g. Ne sait pas																										
h. Autre																										
Total																										
4	Oui	1.3.1	Données utilisées pour les processus stratégiques, politiques et opérationnels	d1ause_2	Existe-t-il un examen de routine des données issues de la détection proactive et réac des cas pour déterminer si l'approche est efficace et utile ? <table> <tr> <td></td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>a. Oui</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Non</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Ne sait pas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>			N	a. Oui		b. Non		c. Ne sait pas		Total											
	N																									
a. Oui																										
b. Non																										
c. Ne sait pas																										
Total																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										

Intro

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

Comment lier des fichiers

+

Étape 4. Copier et contextualiser les questionnaires

Les classeurs de questionnaires doivent être copiés pour chaque point d'entrée de données. Pour chaque établissement qu'elles prévoient de visiter, les équipes de terrain doivent recevoir des questionnaires distincts pré-remplis avec le nom de l'établissement de santé. Selon le cas, les questionnaires peuvent également être convertis en documents au format Word (pour la collecte de données sur papier) ou avec un logiciel tel que ODK.

Une mise en forme supplémentaire, une contextualisation selon le pays et une traduction dans les langues locales peuvent aussi s'avérer nécessaires.

Phase 3: Analyse des données et élaboration des résultats

La boîte à outils fournit des orientations et des outils pour l'analyse des données recueillies dans le cadre de l'analyse documentaire, du CQD et de l'enquête. La majorité des résultats sont générés automatiquement à partir des outils. Les résultats attendus sont décrits dans le Tableau 10.

Tableau 10. Résultats attendus de la collecte de données à l'aide de la boîte à outils

Activité	Résultats	Outils et méthodes d'analyse
Analyse documentaire	- Tableaux et figures clés remplis dans le cadre de l'analyse documentaire. - Fiche de performance des indicateurs prioritaires. Les résultats de l'analyse documentaire sont utilisés pour déterminer automatiquement si les indicateurs prioritaires ont été atteints, partiellement atteints ou pas atteints, en fonction de critères précis. Ces résultats sont utilisés pour remplir automatiquement une fiche d'évaluation pour chaque indicateur et calculer des scores composites pour chaque sous-objectif et objectif. - Diagrammes du système de surveillance pour les systèmes d'information et les flux de données	Des tableaux et des figures sont inclus et générés automatiquement dans l'outil d'analyse documentaire pour chaque indicateur et peuvent être exportés. La fiche d'évaluation est générée automatiquement pour les indicateurs prioritaires en fonction des données indiquant si les indicateurs ont été atteints, partiellement atteints ou pas atteints. Les diagrammes doivent être générés par le pays et téléchargés vers la plateforme numérique. Des exemples sont fournis dans la boîte à outils.
CQD au niveau documentaire	- Tableaux et figures pour chaque indicateur de qualité des données aux niveaux national et infranational. - Un tableau récapitulatif pour chaque indicateur au niveau national.	Les tableaux et les figures sont générés automatiquement en utilisant l'outil d'évaluation de CQD au niveau documentaire de la plateforme numérique pour les données agrégées (contextes de réduction de la charge) et dans l'outil Microsoft Excel lui-même pour les données fondées sur les cas (contextes d'élimination), y compris le tableau récapitulatif au niveau national. La fiche d'évaluation sera générée automatiquement pour les indicateurs de qualité des données une fois que les résultats auront été générés ou téléchargés. Les pays peuvent également utiliser des captures d'écran ou télécharger des graphiques à partir de leurs propres systèmes de surveillance (l'Encadré 4 donne des détails sur les autres options).

Activité	Résultats	Outils et méthodes d'analyse
CQD au niveau de la prestation de services	Tableau récapitulatif pour les indicateurs de qualité des données au niveau national.	Les résultats agrégés à l'échelle nationale doivent être saisis dans le tableau récapitulatif fourni dans les outils d'évaluation de CQD au niveau de la prestation des services. Pour les données fondées sur les cas dans les contextes d'élimination, les résultats récapitulatifs sont générés par l'outil Excel, mais ces résultats peuvent aussi être téléchargés vers la plateforme numérique pour renseigner la fiche d'évaluation.
Enquête	- Les données de réponse à l'enquête sont présentées sous forme de tableaux aux niveaux national et infranational. - Si nécessaire, les données brutes de chaque établissement de santé sont extraites dans Microsoft Excel pour une analyse plus approfondie.	Des tableaux de plan d'analyse permettant de saisir des données agrégées pour chaque établissement de santé et chaque question du questionnaire sont fournis dans le cadre de la boîte à outils.

Les activités de cette phase consistent à :

- compiler les résultats de l'analyse documentaire et de l'évaluation de CQD au niveau documentaire ;
- nettoyer et gérer les données recueillies dans le cadre du CQD au niveau de la prestation de services et de l'enquête ;
- analyser les données recueillies dans le cadre du CQD au niveau de la prestation de services ; et
- analyser les données recueillies dans le cadre de l'enquête.

3.1 Résultats de l'analyse documentaire

Comme décrit dans la section 2.1, les données recueillies dans le cadre de l'analyse des documents et des données ainsi que des entretiens sont organisées sous forme de tableaux et de figures dans l'outil d'analyse documentaire. Les tableaux et les figures sélectionnés peuvent être exportés à partir de la plateforme numérique et utilisés directement comme résultats clés dans le rapport final.

Pour les indicateurs prioritaires, une fiche d'évaluation est automatiquement générée sur la base des données fournies dans l'outil d'analyse documentaire précisant si un indicateur a été atteint, partiellement atteint ou pas atteint. Les résultats sont calculés et affichés pour chaque indicateur, et des scores composites sont calculés pour chaque objectif et sous-objectif. La fiche d'évaluation donne plus de détails sur les calculs utilisés pour chaque score. Cette fiche correspond au résultat final, qui doit être utilisé pour identifier les principaux domaines à améliorer. Les raisons expliquant le score attribué à chaque indicateur doivent également être saisies, en mettant en évidence les principales réalisations et difficultés, accompagnées éventuellement d'une recommandation de renforcement et d'amélioration de la surveillance. La fiche d'évaluation peut être exportée à partir de la plateforme numérique.

Les diagrammes du système de surveillance doivent être élaborés manuellement et présentés dans Microsoft PowerPoint. Ils doivent être revus et modifiés à mesure que l'information est recueillie tout au long de l'évaluation. Il est utile de fournir des diagrammes de la situation actuelle des systèmes d'information et du flux de données, ainsi que des diagrammes des plans et changements futurs.

Les tableaux, les figures, la fiche d'évaluation et les diagrammes doivent être insérés dans les modèles de note technique et/ou de rapport, et utilisés en consultation avec le comité d'orientation pour élaborer des recommandations visant à renforcer le système de surveillance.

3.2 Résultats du CQD au niveau documentaire

Les outils d'évaluation de CQD au niveau documentaire fournissent des sorties automatisées de tableaux et de figures pour chaque indicateur de qualité des données sur un ensemble de tableaux de bord. Pour les contextes de réduction de la charge, ceux-ci peuvent être exportés à partir de la plateforme numérique et utilisés directement dans le rapport final. Pour les contextes d'élimination, les graphiques sont disponibles dans l'outil lui-même. Pour chaque indicateur, un tableau récapitulatif des résultats au niveau national est également fourni. Un tableau de bord de CQD a également été développé dans le cadre du module de réduction de la charge du paludisme de la plateforme DHIS2 ; celui-ci affiche les mêmes résultats et présente donc une alternative à l'utilisation de l'outil de CQD si le module paludisme est installé dans le pays. Il existe également différentes options d'analyse et de visualisation des résultats du CQD en fonction du contexte national (Table 11).

Tableau 11. Options pour l'analyse de CQD au niveau documentaire

	Option 1	Option 2
Outil	Tableau de bord de la qualité des données existant qui fait partie du système de surveillance du paludisme ou Tableau de bord de qualité des données de l'OMS dans le module paludisme de la plateforme DHIS2	Outil d'évaluation de CQD au niveau documentaire
Exigences	Le pays dispose d'un système de surveillance électronique avec un tableau de bord de la qualité des données comprenant tous les indicateurs de qualité des données nécessaires à l'évaluation ou Le pays dispose de la plateforme DHIS2 ou Le pays dispose du module paludisme de l'OMS avec tous les tableaux de bord ou d'un module paludisme développé dans le pays installé pour la plateforme DHIS2, avec ou sans tableau de bord de la qualité des données ^a	Le pays ne dispose pas d'un tableau de bord contenant tous les indicateurs de qualité des données nécessaires à l'évaluation, de sorte que les données doivent être extraites pour l'analyse

	Option 1	Option 2
Instructions	Le pays peut utiliser des captures d'écran directes des tableaux de bord de la qualité des données pour le rapport. Si la plateforme DHIS2 est utilisée, la fonction de rapport peut servir à générer plusieurs graphiques pour chaque indicateur. Si le pays dispose d'un module paludisme pour la plateforme DHIS2 n'ayant pas le tableau de bord de la qualité des données recommandé, ce tableau de bord peut être installé et des variables peuvent être cartographiées pour le remplir. L'OMS peut fournir une aide au pays.	Les données nécessaires à l'analyse doivent être extraites du système de surveillance et copiées-collées dans le modèle de base de données de l'outil d'évaluation de CQD au niveau documentaire, qui générera automatiquement des résultats..

- ^a Si le module OMS n'existe pas ou doit être mis à jour, ou si un module paludisme développé dans le pays est utilisé et n'inclut pas de tableau de bord de la qualité des données, le module paludisme actuel peut être installé à l'aide des progiciels de configuration de l'OMS pour la plateforme DHIS2 (15). Il s'agit de saisir ou d'importer des données rétrospectives dans le module paludisme, ce qui peut être fait en utilisant les liens de documentation dans les progiciels de configuration DHIS2 de l'OMS. En collaboration avec l'OMS, le tableau de bord peut être intégré dans le module paludisme du PNLP pour effectuer un CQD. En plus du tableau de bord, l'OMS fournit des lignes directrices pour son utilisation et l'interprétation des indicateurs.

3.3 Agréger et analyser les données du CQD au niveau de la prestation de services

Deux options sont proposées pour collecter, compiler et analyser les données du CQD au niveau de la prestation de services.

- Utiliser un modèle Microsoft Excel avec des macros intégrées – par exemple, un outil développé par PATH avec des macros Microsoft Excel qui regroupe en une seule base de données les classeurs individuels d'évaluation de CQD de la prestation de services pour chaque point de prestation de services ou emplacement infranational, et qui fournit des fonctionnalités pour les analyses de CQD automatisées.
- Élaborer une fiche de dénombrement électronique des données de CQD au niveau de la prestation de services (p. ex., dans le logiciel ODK) qui compile automatiquement les données dans une base centrale à partir de laquelle les analyses requises peuvent être effectuées.

Le rapport final doit inclure un seul ensemble de résultats de CQD, regroupant en un seul tableau de bord les résultats aux niveaux documentaire et de la prestation de services. Des instructions portant sur la création de l'ensemble minimum de supports visuels suggérés sont fournies dans l'outil de CQD.

3.4 Gérer et nettoyer les données d'enquête

Toutes les données quantitatives collectées dans le cadre de l'enquête doivent être compilées dans une seule base de données en vue d'une analyse plus approfondie. Pour cela, deux options sont suggérées.

- Des questionnaires programmés sous forme de formulaires électroniques de collecte de données (p. ex., logiciel ODK) sont remplis, envoyés et automatiquement agrégés dans une base de données unique.
- Des données de questionnaire consignées sur papier ou dans Microsoft Excel peuvent être saisies manuellement ou agrégées dans une base de données unique.

Les pratiques standard de gestion des données doivent être suivies, par exemple en conservant tous les fichiers de données brutes dans un lieu sécurisé distinct, en anonymisant les informations sensibles et en conservant l'historique des étapes de nettoyage mises en œuvre.

3.5 Utiliser les tableaux de plan d'analyse pour capturer les résultats des données d'enquête

La boîte à outils comprend un classeur Microsoft Excel avec des tableaux de plan pour saisir les résultats d'analyse de chaque indicateur évalué dans l'enquête. Chaque tableau est lié à l'indicateur connexe et aux questions utilisées pour évaluer cet indicateur. Ces tableaux doivent être compilés dans une seule base de données à des fins d'analyse. Il est également possible de créer une base de données et d'analyser les données dans un logiciel statistique comme R ou Stata. Il est important de visualiser les données au niveau administratif, ce qui est le plus utile pour l'élaboration de plans opérationnels. Le cas échéant, les tableaux de données peuvent être utilisés pour produire des graphiques ou des cartes illustrant mieux les résultats. Afin de mieux comprendre pourquoi la performance peut être médiocre dans certains districts ou régions, il est recommandé de visualiser les résultats à l'aide de cartes ou de graphiques pour les indicateurs de performance (objectif 1) à côté des indicateurs de facteurs de performance (objectifs 2 à 4).

3.6 Fiche d'évaluation et tableaux de bord

Une fois l'évaluation terminée et les résultats publiés, une fiche d'évaluation à code couleur sera générée pour tous les indicateurs prioritaires de chaque objectif et sous-objectif. Chaque score est affiché comme « atteint » (vert), « partiellement atteint » (jaune), « pas atteint » (rouge) ou « pas évalué » (gris). Les résultats de l'analyse documentaire fournissent les données nécessaires pour calculer ce score. Les scores des indicateurs prioritaires de l'enquête doivent être saisis manuellement dans la fiche d'évaluation. Les critères d'évaluation des indicateurs sont fournis dans la fiche. Il est également important de saisir la raison du résultat, et chaque score doit être associé à une recommandation. La fiche d'évaluation peut être exportée à partir du système pour être utilisée dans le rapport final.

✓ Définir Le Périmètre

✓ Collecter Les Données

✓ Analyser Les Données

✓ Gérer Un Tableau De Bord

La carte de pointage est automatiquement remplie à partir de l'examen documentaire et de l'AQO. Les résultats finaux sont basés sur le calcul suivant de la somme des points pour chaque indicateur (Atteint=2, Partiellement atteint=1 et Non atteint=0) points totaux maximum (nombre d'indicateurs évalués x 2). Les indicateurs qui n'ont pas été évalués sont retirés du calcul. Veuillez ajouter plus de détails sur la raison du résultat (par exemple, les réalisations et les défis) et fournir des recommandations clés pour le renforcement du système de surveillance.

PERFORMANCE

CONTEXTE ET INFRASTRUCTURE

TECHNIQUE ET PROCESSUS

COMPORTEMENT

Résultat objectif: 65% Indicateurs atteints: 10/17=59%

1.1 COUVERTURE DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE

1.2 QUALITÉ DES DONNÉES

1.3 UTILISATION DES DONNÉES

Si un texte est saisi pour la "raison du résultat" et/ou le "résultat de l'enquête", veuillez cliquer sur "enregistrer" avant de passer d'un sous-objectif à l'autre.

Sous-Objectif Résultat: 33%

Séquence	Indicatrice	Résultat	Raison du résultat	Recommandation
1.2.1	Exhaustivité des notifications	Atteint		
1.2.3	Ponctualité des notifications	Partiellement atteint		
1.2.7	Exhaustivité des variables de base dans les rapports	Partiellement atteint		
1.2.8	Cohérence entre les variables de base	Pas atteint		
1.2.9	Cohérence dans le temps pour les indicateurs de base	Atteint		
1.2.10	Concordance des variables de base entre deux systèmes de notification	Pas atteint		
1.2.11	Exhaustivité des variables de base dans les registres	Pas atteint		
1.2.12	Concordance des variables de base entre les registres et les rapports agrégés	Pas atteint		
1.2.13	Erreur dans les sources de données	Pas atteint		

L'année d'évaluation :		2/14/2024 - 11/14/2025					
Objectif	Sous-objectif	Numéro d'ind.	Indicatrice	Result	Raison du résultat	Recommandation	
PERFORMANCE	QUALITÉ DES DONNÉES	1.2.1	Exhaustivité des notifications	Atteint			
PERFORMANCE	QUALITÉ DES DONNÉES	1.2.3	Ponctualité des notifications	Atteint			
PERFORMANCE	QUALITÉ DES DONNÉES	1.2.7	Exhaustivité des variables de base dans les rapports	Atteint			
PERFORMANCE	QUALITÉ DES DONNÉES	1.2.8	Cohérence entre les variables de base	Atteint			
PERFORMANCE	QUALITÉ DES DONNÉES	1.2.9	Cohérence dans le temps pour les indicateurs de base	Atteint			
PERFORMANCE	QUALITÉ DES DONNÉES	1.2.10	Concordance des variables de base entre deux systèmes	Pas atteint			
PERFORMANCE	QUALITÉ DES DONNÉES	1.2.11	Exhaustivité des variables de base dans les registres	Partiellement atteint			
PERFORMANCE	QUALITÉ DES DONNÉES	1.2.12	Concordance des variables de base entre les registres et l	Partiellement atteint			
PERFORMANCE	QUALITÉ DES DONNÉES	1.2.13	Erreur dans les sources de données	Pas atteint			
PERFORMANCE	UTILISATION DES DONNÉES	1.3.1	Données utilisées pour les processus stratégiques, politic	Atteint			
PERFORMANCE	UTILISATION DES DONNÉES	1.3.2	Données utilisées pour les décisions visant à améliorer le	Atteint			
PERFORMANCE	UTILISATION DES DONNÉES	1.3.3	Données examinées pour le suivi	Atteint			
PERFORMANCE	UTILISATION DES DONNÉES	1.3.4	Données utilisées pour générer des produits de routine	Atteint			

La fiche d'évaluation renseigne automatiquement quatre tableaux de bord aux niveaux mondial, régional, national et des indicateurs, qui permettent de faire une comparaison entre les pays et dans le temps. L'utilisateur peut choisir de ne pas publier ouvertement le rapport, auquel cas les résultats de l'évaluation ne seront pas affichés dans d'autres pays. Pour chaque objectif, le tableau de bord mondial affiche une carte des scores composites de l'évaluation la plus récente publiée de chaque pays. Ces cartes peuvent être filtrées pour afficher les résultats uniquement pour les contextes de réduction de la charge ou d'élimination, et les utilisateurs peuvent basculer entre ces différents contextes.

☰

Phase 3: Analyse des données et élaboration des résultats 53

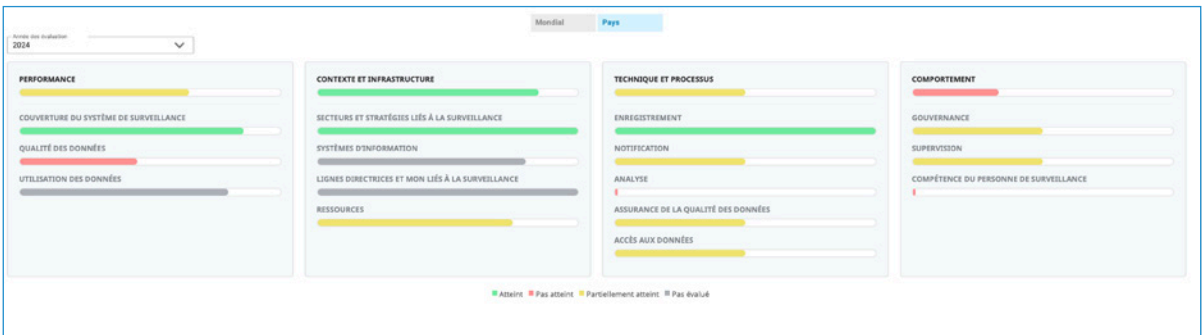
Le tableau de bord régional affiche les scores par sous-objectif dans un graphique à barres pour tous les pays ayant soumis des évaluations dans une région de l'OMS.



Le tableau de bord des indicateurs affiche toutes les évaluations réalisées pour chaque pays par ordre alphabétique et par année dans chaque région de l'OMS. Les résultats de chaque indicateur prioritaire sont présentés. Pour les évaluations complètes, le triangle supérieur représente les « résultats de l'enquête » tandis que le triangle inférieur représente les « résultats de l'analyse documentaire et du CQD » afin de pouvoir comparer les mêmes indicateurs à différents niveaux du système de santé.



Le tableau de bord par pays fournit un résumé visuel rapide des résultats pour les objectifs et les sous-objectifs affichés sous forme de mesures de performance.



Phase 4: Priorisation des recommandations et diffusion

Cette phase comprend l'examen des constatations et l'élaboration de recommandations pour le renforcement des systèmes de surveillance. Il s'agit également d'intégrer des recommandations prioritaires et un plan d'action dans le rapport final, et de diffuser les résultats à toutes les parties prenantes impliquées dans la surveillance du paludisme, aux niveaux national et mondial.

Les activités de cette phase consistent à :

- produire du matériel destiné à être diffusé, y compris un rapport normalisé, une note technique et une présentation ;
- élaborer et prioriser les recommandations dans le cadre de discussions entre le PNLP et les principales parties prenantes ;
- élaborer un plan d'action pour combler les lacunes prioritaires ; et
- évaluer l'évaluation elle-même pour en valider les résultats, et contribuer à améliorer la boîte à outils et la mise en œuvre d'évaluations de la surveillance du paludisme à l'avenir.

4.1 Préparer le rapport final, la note technique et la présentation de débriefing

Une fois que les données d'évaluation ont été analysées et que les résultats ont été produits, ceux-ci doivent être affichés avec le descriptif et l'interprétation du matériel à diffuser. Les principaux graphiques, les tableaux et le tableau de bord peuvent être exportés directement depuis la plateforme numérique afin d'être utilisés dans un rapport ou une présentation. Des captures d'écran des tableaux de bord peuvent également être utilisées pour fournir une vue d'ensemble des résultats.

Des modèles de note technique et de rapport final ont été élaborés pour appuyer la présentation systématique des résultats de l'évaluation de la surveillance (Encadré 4). La présentation de débriefing et la note technique mettent en évidence les résultats prioritaires, tandis que le rapport sert de guide pour présenter tous les résultats de tous les indicateurs et stratégies qui peuvent être inclus dans l'évaluation.

Dans chaque modèle, des espaces réservés sont prévus pour insérer les résultats normalisés de l'analyse documentaire, du CQD et de l'enquête. Ces modèles doivent être adaptés en fonction de la portée de l'évaluation et des méthodes de collecte des données choisies.

Les modèles de rapport sont les suivants :

- des détails sur le contexte, la justification, la portée, les objectifs et les méthodes, qui peuvent être extraits et résumés à partir de la note de synthèse et/ou du protocole d'évaluation, y compris les tableaux pertinents pour chaque section ;
- la section sur les résultats, qui comprend des conseils sur les résultats d'analyse à ajouter et sur la façon de décrire et d'interpréter les résultats ; et

- les sections sur la formulation et la priorisation des recommandations fondées sur les résultats, qui doivent être élaborées dans le cadre d'un processus collaboratif avec le comité d'orientation (décrit à la section 4.2).

La présentation doit servir à amorcer des discussions entre le PNLP et les parties prenantes portant sur les constatations. Elle peut également être utilisée pour élaborer et prioriser les recommandations, et pour diffuser rapidement les résultats de l'évaluation auprès des donateurs et autres partenaires.

On peut s'attendre à ce que plusieurs versions de la note technique et/ou du rapport soient publiées à mesure que les données deviennent disponibles, et en fonction des commentaires du PNLP et des parties prenantes concernées. Le PNLP doit être satisfait du rapport final avant de le partager plus largement avec les donateurs et d'autres partenaires.

Encadré 4. Note technique et rapport

Des outils pour la note technique et le rapport sont inclus dans la boîte à outils pour soutenir la diffusion des résultats de l'évaluation ; leur objectif est d'organiser les résultats à cette fin. Ils fournissent également des conseils sur la description et l'interprétation des résultats qui seront présentés au comité d'orientation afin d'aboutir à des recommandations.

La note technique est un document succinct qui met en évidence les principales constatations tirées des indicateurs prioritaires. Structurée de manière à permettre la normalisation des évaluations, elle assure le matériel de diffusion minimum attendu dans le cadre d'une évaluation menée à l'aide de la boîte à outils.

Le modèle de rapport couvre tous les indicateurs pouvant être évalués à l'aide de la boîte à outils, et constitue donc un guide complet pour l'organisation et l'interprétation des résultats.

4.2 Élaborer et prioriser des recommandations avec le comité d'orientation en fonction des résultats

À l'issue de l'analyse, des recommandations fondées sur des données probantes doivent être élaborées et classées par ordre de priorité.

4.2.1 Élaborer les recommandations

Afin d'encourager et de promouvoir l'appropriation des résultats et des recommandations de l'évaluation, un processus de consultation doit être entrepris avec le comité d'orientation. Cela peut se faire dans le cadre d'une présentation de débriefing ou d'une réunion de haut niveau.

- Avant cette réunion, le PNLP et les partenaires d'exécution doivent se rencontrer pour discuter des principales constatations et des recommandations suggérées. Les membres du comité d'orientation doivent ensuite recevoir une version préliminaire de la note technique ou du rapport (sans que la section des recommandations soit remplie) et/ou de la présentation de débriefing.
- Au cours de la réunion, les membres du comité d'orientation peuvent examiner les résultats de chaque sous-objectif ou indicateur et formuler des recommandations appropriées.

- À la suite de la réunion, il peut être nécessaire de réviser la note technique et/ou le rapport en fonction du retour d'information obtenu du comité d'orientation.

Il peut être utile de formuler des recommandations relatives aux sous-objectifs ou aux indicateurs pour guider les discussions du comité d'orientation.

4.2.2 Utiliser la matrice de priorisation dans le plan du rapport pour prioriser les recommandations

Les recommandations doivent être priorisées en fonction de leur impact potentiel et de leur faisabilité. À cette fin, un ensemble de critères peut être défini en fonction duquel chaque recommandation peut être classée comme étant de priorité élevée (vert), moyenne (jaune) ou faible (rouge) relativement à son incidence sur la performance de la surveillance et les caractéristiques du système (Tableau 12).

Les recommandations peuvent ensuite être catégorisées comme étant à court, à moyen ou à long terme, en fonction de la faisabilité et des ressources disponibles.

Les recommandations finalisées et priorisées doivent être ajoutées au plan de note technique et/ou de rapport. Ce document peut ensuite être examiné et signé par le comité d'orientation avant d'être diffusé auprès d'un plus vaste public.

Tableau 12. Définitions des critères et du classement pour la priorisation des recommandations d'une évaluation de la surveillance du paludisme

Critères	Définition des critères et catégories	Définitions des classes de priorisation		
		Priorité élevée	Priorité moyenne	Priorité faible
Impact	Impact sur la performance de la surveillance (c.-à-d. couverture du système de surveillance, qualité et utilisation des données)	Amélioration significative de la performance	Certain degré d'amélioration de la performance	Peu ou pas d'amélioration de la performance
Faisabilité	Temps nécessaire à la mise en œuvre du début jusqu'à la fin	À court terme (dans les 3 mois)	À moyen terme (3 à 12 mois)	À long terme (1 an et plus)
	Ressources requises (p. ex., personnel, fonds, infrastructure)	Ressources actuellement disponibles pour la mise en œuvre	Les ressources ne sont pas en place, mais peuvent être financées avec le budget actuel	Les ressources sont actuellement indisponibles et un financement est requis

4.3 Élaborer un plan d'action pour combler les lacunes prioritaires

Une fois que le comité d'orientation a formulé des recommandations fondées sur des données probantes et que celles-ci ont été classées par ordre de priorité, l'étape suivante consiste à partager le rapport final avec toutes les parties prenantes concernées et à élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre d'interventions de renforcement de la surveillance.

4.3.1 Diffuser le rapport final, comme convenu avec le PNLP et le comité d'orientation, aux parties prenantes dans le pays et discuter de la faisabilité des mesures visant à combler les lacunes prioritaires

Une fois que la note technique et/ou le rapport, y compris les recommandations priorisées, ont été approuvés par le comité d'orientation (voir section 4.2), ce matériel à diffuser doit être partagé avec les parties prenantes concernées soutenant la surveillance du paludisme au-delà du comité, notamment les départements de santé et les ministères concernés, les partenaires locaux et internationaux de lutte contre le paludisme et les donateurs. L'objectif est d'obtenir le consensus et l'adhésion de toutes les parties concernées par la surveillance du paludisme qui sont en mesure de plaider en faveur du renforcement de la surveillance par le biais de canaux pertinents, et de mobiliser ou d'engager des ressources pour ce faire. Une fois publiés, le rapport final et la présentation de débriefing peuvent être téléchargés vers la plateforme numérique, ce qui permet à toutes les parties prenantes d'y accéder.

4.3.2 Créer un plan d'action et intégrer les activités dans la RPP ou le PSN

Les parties prenantes doivent élaborer ensemble un plan d'action détaillé pour renforcer les activités de surveillance associées à chacune des recommandations de l'évaluation de la surveillance.

Un plan d'action (Tableau 13) doit énumérer des activités spécifiques, réalistes et réalisables qui répondent aux recommandations priorisées sur la base des résultats de l'évaluation de la surveillance du paludisme (9).

L'objectif du plan d'action est de :

- désigner les responsabilités et établir des collaborations ;
- allouer un budget et des ressources pour chaque activité ;
- veiller à ce que les activités soient intégrées dans les plans d'opérations infranationaux et dans la RPP ou le PSN ; et
- suivre les progrès réalisés depuis l'évaluation précédente de la surveillance et déterminer l'incidence des activités mises en œuvre pour améliorer la performance de la surveillance.

Le processus d'élaboration du plan d'action est le suivant.

- Réunir des décideurs et des experts en surveillance pertinents et leur présenter les résultats de l'évaluation et les recommandations suggérées (si la planification des actions n'est pas effectuée en même temps que la diffusion).
- Identifier les activités à mettre en œuvre pour donner suite à chaque recommandation. Les activités prévues dans le plan d'action doivent être menées aux niveaux national et infranational.

- Une fois qu'une activité a été identifiée, la décomposer pour obtenir des tâches distinctes bien définies. Par exemple, il peut être recommandé que le personnel de surveillance ait un accès en temps réel aux données de surveillance de routine, ce qui peut nécessiter la mise en place d'un serveur DHIS2. Cela comprend des tâches comme la configuration de connexions réseau et Internet, le paramétrage des formulaires d'enregistrement et de notification, l'achat d'ordinateurs et de tablettes, la planification des formations, etc. Ces tâches doivent être énumérées dans le modèle de plan d'action (voir le Tableau 13) afin qu'elles puissent être planifiées, chiffrées et attribuées aux personnes ou aux organisations concernées. Le résultat est une feuille de route pour la mise en œuvre de recommandations fondées sur des données probantes.
- Pour chaque tâche il convient de déterminer les échéanciers, le personnel et les organisations responsables, ainsi que les ressources requises (voir le Tableau 13). Les activités et les tâches comprises dans le plan d'action doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinentes et limitées dans le temps (SMART). La responsabilité de la mise en œuvre de chaque activité doit être confiée à une personne ou à une organisation en particulier.
- Une fois finalisé, le plan d'action peut être utilisé pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations, des actions et des tâches avec les parties responsables, suivant les échéances convenues. Le plan d'action doit être inclus dans le RPP ou le PSN.

Tableau 13. Plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations prioritises de l'évaluation de la surveillance

Basé sur les recommandations de l'évaluation			Basé sur l'exercice de planification des actions				
Sous-objectif ou indicateur	Recommandation	Niveau de priorité	Action	Tâches	Échéance	Parties responsables	Ressources requises (personnel, infrastructure)
Énumérer les sous-objectifs ou les indicateurs qui ont été évalués.	Énumérer les recommandations de l'évaluation. Exemple : Assurer un accès en temps réel aux données au personnel de surveillance à tous les niveaux du système de santé.	Indiquer le niveau de priorité de la recommandation (élevée, moyenne ou faible) déterminé par le comité d'orientation.	Déterminer les principales activités requises pour mettre en œuvre la recommandation en question. Exemple : Mettre en place un serveur DHIS2.	Décomposer chaque activité en tâches distinctes. Exemple : Configurer les formulaires d'enregistrement et de notification. Exemple : Établir une connexion réseau et Internet.	Consigner les dates précises (si possible) ou indiquer à court, moyen ou long terme. Exemple : À court terme ; T1 20XX.	Indiquer le ministère, l'organisation ou la personne responsable, et les éventuels partenaires d'exécution. Exemple : PNLP	Estimer ou chiffrer chaque tâche, en tenant compte du personnel, du matériel et de l'infrastructure nécessaires.
On peut également inclure ici des résultats récapitulatifs, tels que la fiche d'évaluation. Il peut y avoir plus d'un sous-objectif ou indicateur par recommandation.				Exemple : Obtenir des ordinateurs et des tablettes. Exemple : Planifier et entreprendre les formations.			

Source: PRISM (9).

Références bibliographiques¹

1. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation : un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (<https://iris.who.int/handle/10665/325605>).
2. Terminologie OMS du paludisme, mise à jour 2021. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/351089>).
3. Cadre pour l'élimination du paludisme. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (<https://iris.who.int/handle/10665/258988>).
4. Guide technique pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte dans la région Africaine : Volume 1 – Section d'introduction. Brazzaville : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l'Afrique ; 2019 (<https://iris.who.int/handle/10665/331254>).
5. Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016–2030, édition 2021. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/351114>).
6. Malaria surveillance system performance in Mozambique: a comprehensive assessment. Malaria Consortium; 2018 (<https://www.malariaconsortium.org/media-downloads/1169>).
7. Mercado CEG., Ekapirat N, Dondorp AM, Maude RJ. An assessment of national surveillance systems for malaria elimination in the Asia Pacific. *Malar J.* 2017;16:127. doi:10.1186/s12936-017-1774-3.
8. Lourenço C, Tatem AJ, Atkinson PM, Cohen JM, Pindolia D, Bhavnani D, et al. Strengthening surveillance systems for malaria elimination: a global landscaping of system performance, 2015–2017. *Malar J.* 2019;18:315 doi:10.1186/s12936-019-2960-2.
9. PRISM: Performance of Routine Information System Management Series. Chapel Hill: MEASURE Evaluation; 2018 (<https://www.measureevaluation.org/resources/prism.html>).
10. Liste des installations principales [site Web]. Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l'Afrique ; 2024 (<https://aho.afro.who.int/mfl/af?lang=fr>).
11. Sampling manual for facility surveys for population, maternal health, child health and STD programs in developing countries, July 2001. Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation; 2001 (<https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-01-03.html>).
12. Mesurer la disponibilité et la capacité opérationnelle des services (SARA) : un outil d'évaluation des établissements de santé : manuel de référence, version 2.2. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2015 (<https://iris.who.int/handle/10665/149026>).
13. Master facility list resource package: guidance for countries wanting to strengthen their master facility list: facilitator guide for the MFL training. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/329492>).
14. Data quality review (examen de la qualité des données) : module 1 : cadre et paramètres. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (<https://iris.who.int/handle/10665/312125>).
15. Collections de configuration de l'OMS pour DHIS2 [demande en ligne]. DHIS2 ; 2024 (<https://dhis2.org/fr/metadata-downloads/>). Un guide d'installation des métadonnées est disponible à l'adresse <https://docs.dhis2.org/fr/implement/health/malaria/malaria-hmis/installation.html#overview>.

¹ Toutes les références ont été consultées le 25 janvier 2025..

Pour en savoir plus

Analysis and use of health facility data: guidance for malaria programme managers. Working document. Geneva: World Health Organization; 2018. (<https://www.who.int/publications/m/item/analysis-and-use-of-health-facility-data-guidance-for-malaria-programme-managers>).

Data quality review (examen de la qualité des données) : module 2 : examen sur dossier de la qualité des données. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (<https://iris.who.int/handle/10665/312127>).

Data quality review (examen de la qualité des données) : module 3 : vérification des données et évaluations des systèmes. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (<https://iris.who.int/handle/10665/312129>).

Practical manual for malaria programme review and malaria strategic plan midterm review. Brazzaville: WHO Regional Office for Africa; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/325003>).

Annexes

Annexe 1. Liste de contrôle suggérée pour les parties prenantes et/ou les personnes interrogées

Annexe 2. Liste de contrôle des documents suggérés

Annexe 3. Variables et indicateurs de base du paludisme

Annexe 4. Variables de base pour le CQD

Annexe 5. Vérifications de la cohérence entre les variables de base pour le CQD

Annexe 6. Vérifications de la cohérence des indicateurs de base au fil du temps pour le CQD

Annexe 1. Liste de contrôle suggérée pour les parties prenantes et/ou les personnes interrogées

Le tableau ci-dessous propose une liste des parties prenantes pour la surveillance du paludisme. Les postes et intitulés de ces fonctions varieront en fonction du pays.

Ce tableau peut être utilisé comme référence pour la cartographie des parties prenantes pendant la phase de lancement de l'évaluation (colonne 1 uniquement), ou comme liste d'intervenants suggérés pour les entretiens menés dans le cadre de l'analyse documentaire (colonnes 1 à 5).

Pour les entretiens, des répondants peuvent être ajoutés ou retirés selon les besoins. Pour chaque répondant, indiquer si un entretien a été demandé, ainsi que la date et le lien vers les résultats des entretiens terminés. Le résumé peut être utilisé comme référence pour réaliser l'analyse documentaire.

Partie prenante ou intervenant ^a	Entretien demandé	Entretien terminé	Date	Lien vers les résultats de l'entretien
Ministère de la santé				
Conseillers principaux, coordonnateurs et membres du cabinet ministériel des programmes suivants :	☐	☐		
Programme national de lutte contre le paludisme	☐	☐		
Division de l'information sanitaire	☐	☐		
Autres programmes de surveillance et d'intervention pour les maladies aiguës, de lutte contre les maladies, de vaccination, de santé maternelle et infantile, de planification familiale et de lutte contre les maladies non transmissibles (le cas échéant)	☐	☐		
Laboratoire de référence national				
Gestion des ressources humaines, des médicaments, de la logistique et des finances de la santé	☐	☐		
Suivi et évaluation et examens de performance annuels	☐	☐		
Enquêtes auprès des établissements	☐	☐		
Programme national de lutte contre le paludisme				
Référénts (p. ex., directeurs de programmes)	☐	☐		
Responsables de projets en matière de surveillance et de suivi et d'évaluation	☐	☐		
Responsables de la gestion des cas	☐	☐		
Responsables du suivi des produits de base	☐	☐		
Référénts de la surveillance d'intervention (p. ex., responsable de lutte antivectorielle)	☐	☐		
Responsables de la surveillance entomologique	☐	☐		

Partie prenante ou intervenant ^a		Entretien demandé	Entretien terminé	Date	Lien vers les résultats de l'entretien
Responsables de la résistance aux médicaments		☐	☐		
Responsables de la surveillance génomique		☐	☐		
Responsables d'investigation des cas et des foyers		☐	☐		
Organisme national de statistique et registre national d'état civil					
Agents et analystes responsables du recensement national de la population		☐	☐		
Agents et analystes responsables des enquêtes auprès des ménages telles que les enquêtes démographiques et sanitaires, les études de la mesure des niveaux de vie et les enquêtes en grappes à indicateurs multiples		☐	☐		
Agents et analystes responsables de l'enregistrement de l'état civil et des rapports de mortalité					
Autres démographes et statisticiens de premier plan		☐	☐		
Autres ministères et organismes gouvernementaux					
Personnes responsables de l'enregistrement des faits d'état civil (généralement le ministère de l'Intérieur ou des institutions publiques locales)		☐	☐		
Personnes responsables de la planification, du suivi et de l'évaluation des programmes sociaux		☐	☐		
Personnes responsables des commissions d'aménagement et/ou de la population		☐	☐		
Instituts de santé publique et universités					
Chercheurs et directeurs des systèmes de surveillance démographique dans le domaine de l'entomologie, ainsi que ceux d'autres instituts et universités soutenant des travaux sur le paludisme		☐	☐		
Donateurs					
Principaux donateurs bilatéraux et multilatéraux du secteur de la santé et de la surveillance		☐	☐		
Partenariats de santé mondiale tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)		☐	☐		

Annexe 2. Liste de contrôle des documents suggérés

Le tableau ci-dessous propose des documents à compiler pour effectuer un examen complet de la littérature, des documents et du matériel à diffuser. La disponibilité et les noms de ces documents varieront en fonction du contexte du pays.

Pour chaque document, des informations peuvent être ajoutées sur le titre, les auteurs et/ou la source (avec un lien Internet, si disponible) et la date de publication. Au besoin, des rangées peuvent être ajoutées pour des documents supplémentaires. Prendre note des documents qui n'ont pas pu être trouvés ainsi que des lacunes dans la documentation disponible.

Document(s) ^a	Demandé(s)	Obtenu(s)	Auteur/source	Date
Documents stratégiques				
Plan stratégique national relatif au secteur de la santé	☐	☐		
Plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme et besoins de financement	☐	☐		
Rapport annuel national sur le paludisme	☐	☐		
RPP/examen à mi-parcours	☐	☐		
Plan de travail/plan d'opérations annuel de lutte contre le paludisme	☐	☐		
Plan de suivi et d'évaluation du paludisme	☐	☐		
Organigramme du PNL P avec des descriptions de poste et de fonction clairement définies	☐	☐		
Lignes directrices, protocoles et modes opératoires normalisés (MON) pour la surveillance	☐	☐		
Politiques de lutte contre le paludisme	☐	☐		
Bulletins mensuels de surveillance du paludisme et autres rapports d'observation	☐	☐		
Évaluations de l'impact sur le paludisme	☐	☐		
Plateforme des comptes nationaux de la santé (System of Health Accounts, SHA 11)	☐	☐		

Document(s) ^a	Demandé(s)	Obtenu(s)	Auteur/source	Date
Orientations en matière d'épidémie et d'intervention	☐	☐		
Système d'information sanitaire et surveillance générale				
Stratégie d'information sanitaire	☐	☐		
Documents directifs sur la protection des données et la confidentialité des patients (peuvent être spécifiques au paludisme ou porter sur politiques de gouvernance des données du SGIS ou à l'échelle du pays), informations sur les serveurs, sauvegarde des systèmes électroniques et cryptage	☐	☐		
Documentation juridique sur la notification du paludisme ou des maladies infectieuses lorsque le paludisme est répertorié comme une maladie à déclaration obligatoire	☐	☐		
Rapports sur toute évaluation antérieure du système de surveillance du paludisme	☐	☐		
Documents de synthèse du système de surveillance ou du répertoire de données	☐	☐		

Document(s) ^a	Demandé(s)	Obtenu(s)	Auteur/source	Date
Guides techniques, manuels et spécifications relatifs au système d'information sanitaire (liés à la technologie)	☐	☐		
Liste de tous les établissements de santé et agents de santé communautaires disponibles avec définitions (publics, privés, communautaires)	☐	☐		
Liste de référence des établissements de santé et documentation de cartographie des établissements de santé et des agents de santé communautaires (indiquant le type d'établissement de santé : public ou privé)	☐	☐		
Enregistrement et notification				
Diagrammes schématiques des systèmes existants qui collectent des données sur le paludisme et des liens entre ces systèmes, flux de données (indiquant le mode de notification à chaque niveau ou système) et fréquence de l'enregistrement et de la notification	☐	☐		
Copies de tous les formulaires et outils d'enregistrement existants (électroniques ou sur papier)	☐	☐		
Lien Internet ou copie papier des lignes directrices sur l'enregistrement et la notification des données (notamment les définitions de l'enregistrement et la notification, et les directives sur les définitions de cas)	☐	☐		
Supports de formation, notamment manuels, présentations, sessions pratiques et outils de formation en ligne pour le personnel participant à la collecte des données et la notification à tous les niveaux	☐	☐		
Qualité des données				
Liste des indicateurs de qualité des données	☐	☐		
Rapports nationaux et infranationaux d'évaluation de la surveillance du paludisme et d'audit de la qualité des données	☐	☐		
Lignes directrices pour l'examen de la qualité des données	☐	☐		

Document(s) ^a	Demandé(s)	Obtenu(s)	Auteur/source	Date
Exemples de rapports, de présentations type ou de modèles de graphiques/tableaux standard pour le suivi des indicateurs de qualité des données au fil du temps ou sur la base de réunions d'examen des données	☐	☐		
Règles de validation des systèmes électroniques et liste des contrôles automatisés	☐	☐		
Liste de contrôle pour la supervision	☐	☐		
MON pour la validation des données	☐	☐		
Analyse des données				
Outils d'analyse de données (modèles d'analyse de données, tableaux de bord, rapports de routine)	☐	☐		
Bulletins mensuels	☐	☐		
Graphiques relatifs à l'épidémie de paludisme	☐	☐		
Exemples des résultats inclus (captures d'écran, rapports, graphiques, tableaux)	☐	☐		
Exemples des résultats diffusés du niveau national au niveau infranational (captures d'écran, rapports, graphiques, tableaux, présentations, liens Internet)	☐	☐		
Carte de stratification basée sur l'incidence du paludisme	☐	☐		
MON pour l'analyse et la diffusion des résultats à chaque niveau	☐	☐		
Exemples de décisions prises sur la base de l'analyse des données de surveillance	☐	☐		
Supports de formation ou détails des cours/ateliers, notamment le programme de formation sur l'analyse et l'utilisation des données	☐	☐		
Documents des partenaires				
Évaluations d'autres programmes de lutte contre les maladies utilisant le même système de surveillance intégrée	☐	☐		
Plans d'opérations des partenaires	☐	☐		
Résumés de routine des données relatives au paludisme	☐	☐		

Document(s) ^a	Demandé(s)	Obtenu(s)	Auteur/source	Date
Entomologie				
Plan de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	☐	☐		
Résultats de la surveillance de la résistance aux insecticides	☐	☐		
Coordonnées géographiques des sites sentinelles	☐	☐		
Coordonnées géographiques et année de début des insectariums et des colonies	☐	☐		
Lignes directrices et MON relatifs à la surveillance entomologique	☐	☐		
Autres ? Préciser :	☐	☐		
Suivi des produits de base				
Documents directifs et stratégiques relatifs au système d'information de gestion logistique (SIGL)	☐	☐		
Lignes directrices et MON relatifs au SIGL	☐	☐		
Surveillance de la mise en œuvre des interventions				
Plans de gestion intégrée pour la lutte antivectorielle	☐	☐		
Plans de distribution et MON pour les moustiquaires à imprégnation durable (campagne systématique et de masse)	☐	☐		
Plans de mise en œuvre et MON pour la pulvérisation intradomiliaire à effet rémanent	☐	☐		
Plans de mise en œuvre et MON pour la gestion des gîtes larvaires	☐	☐		
Plans de mise en œuvre et MON pour la CPS	☐	☐		
Plans de mise en œuvre et MON pour le TPIIn	☐	☐		
Plans de mise en œuvre et MON pour le TPIg	☐	☐		
Plans de mise en œuvre et MON pour l'AMM	☐	☐		
Tout autre plan d'intervention et MON	☐	☐		

Document(s) ^a	Demandé(s)	Obtenu(s)	Auteur/source	Date
Autres				
Enquêtes (p. ex., enquêtes démographiques et sanitaires – estimation du pourcentage de cas au cours des 10 dernières années ayant sollicité un traitement dans les systèmes public, privé, formel ou informel, ou n'ayant reçu aucun traitement)	☐	☐		
Tests d'efficacité thérapeutique ou surveillance intégrée de l'efficacité des médicaments	☐	☐		
Rapports d'études ou de recherche spéciaux (p. ex., surveillance génomique)	☐	☐		
Rapport annuel sur la mortalité	☐	☐		
Diagramme de l'enregistrement des décès à l'hôpital et dans la communauté, avec des copies de tous les documents standard utilisés ainsi que des supports de formation, le cas échéant, indiquant les codes CIM-10/11	☐	☐		

^a Modifier les documents suggérés ci-dessous pour refléter les noms spécifiques des documents pertinents dans le pays ou la zone de mise en œuvre

Annexe 3. Variables et indicateurs de base du paludisme

Variables de base	Réduction de la charge	Élimination
Patients ambulatoires, toutes causes confondues (y compris le paludisme)	✓	✓
Cas suspects de paludisme	✓	✓
Cas présumés de paludisme	✓	
Testés par TDR	✓	✓
Testés par microscopie	✓	✓
Cas confirmés de paludisme	✓	✓
Cas confirmés de paludisme par espèce	✓	✓
Positifs par TDR	✓	✓
Positifs par microscopie	✓	✓
Patients hospitalisés, toutes causes confondues (y compris le paludisme)	✓	✓
Patients hospitalisés atteints de paludisme ^a	✓	✓
Décès de patients hospitalisés, toutes causes confondues	✓	✓
Décès de patients atteints de paludisme hospitalisés	✓	✓
Tous les décès dus au paludisme	✓	✓
Cas confirmés de paludisme ayant reçu des médicaments antipaludiques (CTA)	✓	✓
Cas confirmés de paludisme ayant reçu des médicaments antipaludiques (traitement de 1 ^{re} intention + CTA)	✓	✓
Cas de <i>P. falciparum</i> ayant reçu un traitement de 1 ^{re} intention	✓	✓
Cas de <i>P. falciparum</i> ayant reçu une faible dose unique de primaquine	✓	✓
Cas de <i>P. vivax</i> ayant reçu de la chloroquine (CQ) ^b	✓	✓

Variables de base	Réduction de la charge	Élimination
Cas de <i>P. vivax</i> cas ayant reçu de la primaquine (PQ) pour la guérison radicale ^b	✓	✓
Cas de <i>P. vivax</i> ayant reçu une CTA ^b		✓
Identifiant unique/ID patient		✓
Âge		✓
Sexe		✓
Nationalité		✓
Lieu de résidence du patient		✓
Date de survenue des symptômes		✓
Date du diagnostic		✓
Espèces de parasites		✓
Date d'instauration du traitement		✓
Traitement prescrit		✓
Date de notification du cas		✓
Date d'investigation du cas		✓
Date d'investigation du foyer		✓
Date d'intervention (foyer) (le cas échéant)		✓
Période supposée d'infection identifiée		✓
Historique des déplacements détaillé disponible (le cas échéant)		✓
Emplacement du patient pendant la période supposée d'infection identifiée et géolocalisée		✓
Classification du cas		✓
Méthode de détection des cas (passive, réactive ou proactive)		✓

Variables de base	Réduction de la charge	Élimination
Cas confirmés de paludisme notifiés		✓
Cas confirmés de paludisme ayant fait l'objet d'une investigation		✓
Cas de paludisme dont la période supposée d'infection et l'emplacement ont été identifiés		✓
Cas confirmés de paludisme classés		✓
Cas confirmés de paludisme classés comme locaux		✓
Cas confirmés de paludisme classés comme autochtones		✓
Cas confirmés de paludisme classés comme introduits		✓
Cas confirmés de paludisme classés comme importés		✓
Foyers identifiés		✓
Foyers ayant fait l'objet d'une investigation (dans le délai prescrit par les lignes directrices nationales)		✓
Foyers classés		✓
Foyers classés comme actifs		✓
Foyers classés comme résiduels non actifs		✓
Foyers classés comme éliminés		✓
Foyers classés comme éliminés + nombre classé comme résiduels non actifs		✓

CTA : combinaison thérapeutique à base d'artémisinine

^a Dans les contextes d'élimination, certains pays exigent que TOUTS les patients atteints de paludisme soient hospitalisés pendant au moins les 3 premiers jours de leur traitement pour garantir l'observance thérapeutique. S'il s'agit de la politique en vigueur, cette variable ne sera pas collectée.

^b Ne s'applique que dans les pays présentant des cas de *P. vivax*.

Indicateurs de base pour les contextes de réduction de la charge et d'élimination

Les cellules en gris sont des indicateurs de base pour les contextes de réduction de la charge uniquement.

Thème	Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Patients ambulatoires	Proportion des cas suspects testés	Nombre de cas suspects de paludisme ayant subi un test parasitologique (examen microscopique ou TDR)	Nombre de cas suspects de paludisme
Patients ambulatoires	Nombre de patients testés pour le paludisme	Nombre de cas suspects de paludisme ayant reçu un TDR ou fait l'objet d'un examen microscopique	
Patients ambulatoires	Nombre de cas confirmés de paludisme	Nombre de cas de paludisme positifs par microscopie ou TDR, ou Nombre de cas positifs par microscopie + nombre de cas positifs par TDR	
Patients ambulatoires	Nombre de cas présumés de paludisme	Nombre de cas présumés, ou Nombre total de cas de paludisme (confirmés + présumés) – (N cas de paludisme positifs par microscopie et/ou N cas de paludisme positifs par TDR)	
Patients ambulatoires	Nombre total de cas de paludisme (confirmés + présumés)	Nombre de cas présumés + nombre de cas confirmés	
Patients ambulatoires	Taux de positivité des tests	Nombre de cas de paludisme positifs par microscopie et/ou TDR	Nombre de patients testés par microscopie et/ou TDR
Patients ambulatoires	Proportion de cas de <i>P. falciparum</i>	Nombre de cas de paludisme dus à <i>P. falciparum</i>	Nombre total de cas confirmés de paludisme dus à une espèce connue
Patients ambulatoires	Proportion de cas de <i>P. vivax</i>	Nombre de cas de paludisme dus à <i>P. vivax</i>	Nombre total de cas confirmés de paludisme dus à une espèce connue
Patients ambulatoires	Taux brut d'incidence des cas	Nombre de cas positifs par microscopie + nombre de cas positifs par TDR	(Nombre de personnes à risque d'infection palustre au cours de l'année de notification) pendant 1 an × 1000

Thème	Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Patients ambulatoires	Proportion de patients ambulatoires atteints de paludisme	Nombre de cas de paludisme (confirmés + présumés)	Nombre total de patients ambulatoires, toutes causes confondues
Patients hospitalisés	Nombre de patients hospitalisés atteints de paludisme	Nombre d'hospitalisations ou de sorties de patients atteints de paludisme	Nombre total d'hospitalisations ou de sorties de patients
Patients hospitalisés	Proportion de patients hospitalisés atteints de paludisme	Nombre d'hospitalisations ou de sorties de patients atteints de paludisme	Nombre total d'hospitalisations ou de sorties de patients
Patients hospitalisés	Taux d'hospitalisation de patients ambulatoires atteints de paludisme	Nombre d'hospitalisations ou de sorties de patients atteints de paludisme	Nombre total de cas de paludisme
Patients hospitalisés	Taux d'incidence des cas de patients hospitalisés atteints de paludisme	Nombre de cas de patients hospitalisés atteints de paludisme	Nombre semestriel de personnes à risque d'infection palustre au cours de l'année de notification × 10 000
Décès	Nombre de décès de patients hospitalisés atteints de paludisme	Nombre de décès dus au paludisme chez les patients hospitalisés	
Décès	Proportion de décès chez les patients hospitalisés atteints de paludisme	Nombre de décès dus au paludisme chez les patients hospitalisés	Nombre total de décès chez les patients hospitalisés
Décès	Taux de mortalité palustre chez les patients hospitalisés	Nombre de décès dus au paludisme chez les patients hospitalisés	Nombre semestriel de personnes à risque d'infection palustre au cours de l'année de notification × 10 000
Traitement	Proportion de cas de paludisme ayant reçu un traitement de 1 ^{er} intention (y compris les CTA)	Nombre de cas confirmés de paludisme ayant reçu un traitement antipaludique de 1 ^{er} intention conformément à la politique nationale	Nombre total de cas de paludisme, détectés par surveillance passive et active
Traitement	Proportion de cas de paludisme ayant reçu un traitement par CTA	Nombre de cas de paludisme ayant reçu un traitement par CTA	Nombre total de cas de paludisme, détectés par surveillance passive et active
Traitement	Proportion de cas de <i>P. falciparum</i> ayant reçu de la primaquine	Nombre de cas de <i>P. falciparum</i> ayant reçu de la primaquine	Nombre de cas de <i>P. falciparum</i>
Traitement	Proportion de cas de <i>P. vivax</i> ayant reçu de la primaquine	Nombre de cas de <i>P. vivax</i> ayant reçu de la primaquine	Nombre de cas de <i>P. vivax</i>

Thème	Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Qualité des données	Exhaustivité de la notification	Nombre de rapports d'établissements de santé reçus au cours d'une période donnée	Nombre de rapports d'établissements de santé escomptés au cours de la même période donnée
Qualité des données	Ponctualité de la notification	Nombre de rapports d'établissements de santé reçus à la date d'échéance au cours d'une période donnée	Nombre de rapports d'établissements de santé escomptés au cours de la même période donnée
Qualité des données	Exhaustivité de la notification des variables de base	Nombre de rapports reçus au cours d'une période donnée pour lesquels toutes les variables de base ont été renseignées	Nombre de rapports reçus au cours d'une période donnée

CTA : combinaison thérapeutique à base d'artémisinine

Indicateurs de base pour les contextes d'élimination

Thème	Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Notification des cas	Proportion de cas graves de paludisme	Nombre de cas graves de paludisme	Nombre total de cas confirmés de paludisme
Notification des cas	Nombre total de décès dus au paludisme	Nombre de décès dus au paludisme	
Notification des cas	Proportion de cas notifiés dans un délai de N1 jours	Nombre de cas notifiés dans un délai de N1 jours	Nombre total de cas confirmés de paludisme
Investigation des cas	Proportion de cas ayant fait l'objet d'une investigation dans un délai de N2 jours après le diagnostic	Nombre de cas confirmés de paludisme ayant fait l'objet d'une investigation dans un délai de N2 jours, le nombre de jours après confirmation défini dans la ligne directrice nationale	Nombre total de cas confirmés de paludisme identifiés par détection passive des cas
Investigation des cas	Proportion de cas confirmés ayant fait l'objet d'une investigation	Nombre de cas confirmés ayant fait l'objet d'une investigation	Nombre total de cas confirmés de paludisme identifiés par détection passive des cas

Thème	Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Investigation des cas	Proportion de cas confirmés classés	Nombre de cas confirmés classés	Nombre total de cas confirmés de paludisme
Investigation des cas	Proportion de cas locaux	Nombre de cas autochtones + nombre de cas introduits	Nombre total de cas confirmés de paludisme
Investigation des cas	Proportion de cas autochtones	Nombre de cas autochtones	Nombre total de cas confirmés de paludisme
Investigation des cas	Proportion de cas importés	Nombre de cas importés	Nombre total de cas confirmés de paludisme
Investigation des cas	Nombre de décès chez les cas autochtones	Nombre de décès chez les cas autochtones	
Investigation des foyers	Nombre de foyers identifiés	Nombre de foyers identifiés	
Investigation des foyers	Proportion de foyers ayant fait l'objet d'une investigation	Nombre de foyers ayant fait l'objet d'une investigation	Nombre total de foyers dans le registre au cours d'une année
Investigation des foyers	Proportion de foyers ayant fait l'objet d'une investigation dans un délai de N3 jours après le diagnostic	Nombre de foyers ayant fait l'objet d'une investigation dans un délai de N3 jours après le diagnostic	Nombre total de foyers détectés comme nouveaux
Investigation des foyers	Proportion de foyers avec une intervention dans un délai de N7 jours après le diagnostic	Nombre de foyers avec une intervention dans un délai de N7 jours après le diagnostic	Nombre total de foyers détectés comme nouveaux (admissibles à l'intervention)
Investigation des foyers	Proportion de foyers classés	Nombre de foyers classés	Nombre total de foyers dans le registre au cours d'une période de 1 an

Thème	Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Investigation des foyers	Proportion de foyers classés comme actifs	Nombre de foyers classés comme actifs	Nombre total de foyers dans le registre au cours d'une période de 1 an
Investigation des foyers	Proportion de foyers classés comme résiduels non actifs	Nombre de foyers classés comme résiduels non actifs	Nombre total de foyers dans le registre au cours d'une période de 1 an
Investigation des foyers	Proportion de foyers classés comme éliminés	Nombre de foyers classés comme éliminés	Nombre total de foyers dans le registre au cours d'une période de 1 an
Investigation des foyers	Pourcentage de la population vivant dans des foyers actifs	Nombre de personnes vivant dans des foyers actifs	Population totale du district
Investigation des foyers	Proportion de foyers avec zéro cas local	Nombre de foyers classés comme éliminés + nombre de foyers classés comme résiduels non actifs	Nombre de foyers de paludisme identifiés
Investigation des foyers	Nombre de foyers de paludisme ayant reçu une forme d'intervention	Nombre de foyers de paludisme ayant reçu une forme d'intervention	
Épidémies	Nombre d'épidémies pour une population particulière dans une zone et à un moment spécifiques	Nombre d'épidémies définies sur la base d'un seuil calculé à partir de données antérieures (A. nombre constant de cas, B. moyenne + 2 écarts-types, C. médiane + 3e quartile supérieur, D. somme cumulée)	
Épidémies	Proportion d'épidémies ayant fait l'objet d'une riposte pour une population particulière dans une zone et à un moment spécifiques	Nombre d'interventions relatives aux épidémies pour une population particulière dans une zone et à un moment spécifiques	Nombre d'épidémies définies sur la base d'un seuil calculé à partir des données antérieures
Intensité de la transmission	Nombre de districts dans les niveaux de transmission très faible, faible, modérée et élevée	Nombre de districts dans les niveaux de transmission très faible, faible, modérée et élevée	
Intensité de la transmission	Nombre d'établissements de santé notifiant des données < 3 cas par semaine	Nombre d'établissements de santé notifiant < 3 cas par semaine	

Thème	Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Qualité des données	Ponctualité des rapports de notification des cas : proportion de rapports de notification des cas reçus N1 heures après la détection ou conformément aux lignes directrices (généralement dans les 24 heures)	Nombre de rapports de notification des cas reçus N1 jours après la détection	Nombre de rapports de notification des cas
Qualité des données	Ponctualité des rapports d'investigation des cas : proportion de rapports d'investigation des cas reçus N2 heures/jours après la détection ou conformément aux lignes directrices (généralement dans les 3 jours)	Nombre de rapports de notification des cas reçus N 2 jours après la détection	Nombre de rapports d'investigation des cas
Qualité des données	Ponctualité des rapports d'investigation des foyers : proportion de rapports d'investigation des foyers reçus N1 heures/jours après la détection ou conformément aux lignes directrices (généralement dans les 7 jours)	Nombre de rapports d'investigation des foyers reçus N3 jours après la détection	Nombre de rapports d'investigation des foyers

Annexe 4. Variables de base pour le CQD

Contextes de réduction de la charge

Il s'agit d'un sous-ensemble de variables de base, qui peuvent être sélectionnées, complétées ou adaptées afin d'évaluer les indicateurs de qualité des données.

Il convient de noter que le nombre total de cas de paludisme et les cas confirmés ne sont pas nécessairement recueillis directement, mais peuvent être la somme d'autres variables de données, auquel cas les variables recueillies directement (p. ex., positif par TDR et positif par microscopie) doivent être utilisées dans le CQD. Si les variables sont ventilées davantage (p. ex. par âge et par sexe), il est également important de les inclure dans le CQD.

Variable	Définition	Sources potentielles					Indicateurs de qualité des données applicables			
		Patient ambulatoire	Patient hospitalisé	Laboratoire	Soins prénatals	Agent de santé communautaire	Exhaustivité	Cohérence entre les variables	Cohérence dans le temps	Concordance
Priorité										
1	Nombre total de cas de paludisme (confirmés + présumés)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
2	Cas confirmés de paludisme ^a	✓	✓	✓			✓	✓		✓

Variable	Définition	Sources potentielles					Indicateurs de qualité des données applicables			
		Patient ambulatoire	Patient hospitalisé	Laboratoire	Soins prénatals	Agent de santé communautaire	Exhaustivité	Cohérence entre les variables	Cohérence dans le temps	Concordance
3	Testés par microscopie Nombre de cas suspects de paludisme ayant fait l'objet d'un examen microscopique	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
4	Testés par TDR Nombre de cas suspects de paludisme ayant reçu un TDR	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
5	Positifs par microscopie Cas de paludisme où le parasite a été détecté par un examen microscopique	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
6	Positifs par TDR Cas de paludisme où le parasite a été détecté par un TDR	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
7	Patients ambulatoires, toutes causes confondues Patients fréquentant des patients ambulatoires, toutes causes confondues, y compris le paludisme	✓					✓	✓	✓	
8	Patients hospitalisés, toutes causes confondues Patients admis à l'hôpital, toutes causes confondues, y compris le paludisme		✓				✓	✓	✓	
9	Décès, toutes causes confondues Patients admis à l'hôpital décédés, toutes causes confondues, y compris le paludisme		✓				✓	✓	✓	✓

Variable	Définition	Sources potentielles					Indicateurs de qualité des données applicables			
		Patient ambulatoire	Patient hospitalisé	Laboratoire	Soins prénatals	Agent de santé communautaire	Exhaustivité	Cohérence entre les variables	Cohérence dans le temps	Concordance
10 Patients hospitalisés atteints de paludisme	Patients admis à l'hôpital pour le paludisme		✓				✓	✓	✓	
11 Décès de patients atteints de paludisme hospitalisés	Patients admis à l'hôpital décédés du paludisme		✓				✓	✓	✓	✓
Facultatif										
12 Cas suspects de paludisme	Maladie dont un agent de santé suspecte qu'elle est due au paludisme, généralement en s'appuyant sur la présence de fièvre, accompagnée ou non d'autres symptômes. Il ne faut pas confondre ces cas avec les cas présumés (voir ci-dessous).	✓				✓	✓	✓	✓	
13 Cas présumés de paludisme	Cas suspects de paludisme non confirmés par un test de diagnostic	✓				✓	✓			
14 TPIg 1-4	Nombre de femmes enceintes ayant reçu de 1 à 4 doses de TPIg				✓		✓	✓		✓

Variable	Définition	Sources potentielles					Indicateurs de qualité des données applicables			
		Patient ambulatoire	Patient hospitalisé	Laboratoire	Soins prénatals	Agent de santé communautaire	Exhaustivité	Cohérence entre les variables	Cohérence dans le temps	Concordance
15 Soins prénatals 1-4	Nombre de femmes enceintes qui se sont rendues au centre de soins prénatals 1 à 4 fois				✓		✓	✓		✓
16 Cas confirmés de paludisme ayant reçu un traitement antipaludique de 1 ^{er} intention (y compris une CTA)	Nombre de cas confirmés de paludisme ayant reçu un traitement antipaludique de 1 ^{er} intention conformément à la politique nationale	✓	✓				✓	✓		

CTA : combinaison thérapeutique à base d'artémisinine

^a Indicateur de base recommandé par l'OMS pour l'EQD transversal réalisé par le SGIS (15). Si le nombre de cas confirmés n'est pas consigné, le nombre total de cas de paludisme peut être substitué. Si possible, les cas confirmés doivent être ventilés par TDR et microscopie. Les tests moléculaires peuvent également être inclus dans une catégorie distincte, le cas échéant.

Contextes d'élimination

Il s'agit d'un sous-ensemble de variables de base pouvant être extraites du système national de surveillance du paludisme, et qui peuvent être sélectionnées, complétées ou adaptées afin d'évaluer les indicateurs de qualité des données.

Thème	Variable	Informations complémentaires	Variables de base (exhaustivité)	Vérifications de la cohérence	Concordance
Détails du patient	Méthode de détection des cas	Cas identifiés par détection passive, détection réactive ou détection proactive des cas.	✓		
	ID patient/ID système	Dans l'idéal, il doit s'agir d'un identifiant patient unique, comme le numéro de sécurité sociale ou, si celui-ci n'est pas disponible, un identifiant provenant d'autres systèmes ou sources de données primaires (p. ex., les registres de patients). Si un tel identifiant n'est pas disponible, utiliser le nom de famille, le prénom et la date de naissance comme variables de base.	✓		
	Nom de famille	Identifiant du patient			
Détails du patient	Prénom	Identifiant du patient			
	Date de naissance	Identifiant du patient. Si indisponible, l'âge peut être utilisé.			
	Âge	Identifiant du patient. L'âge du patient est basé sur la date de naissance fournie. Si l'âge n'est pas connu, une autre valeur peut être utilisée. L'âge de tous les enfants âgés de 0 à 11 mois doit être indiqué comme étant zéro.	✓		✓
	Sexe	Identifiant du patient	✓		✓
	Nationalité	Identifiant du patient. Identité nationale légale du patient.	✓		✓
	Lieu de résidence du patient	Identifiant du patient (adresse/village). Adresse où vit actuellement le patient au moment où il se présente à l'établissement de santé.			
	Adresse du domicile permanent (si différente de celle ci-dessus)	Adresse résidentielle où le résident réside en permanence. Cela permet de trouver plus facilement le patient. Uniquement pour l'extraction de données de CQD au niveau de la prestation de services.	✓		

Thème	Variable	Informations complémentaires	Variables de base (exhaustivité)	Vérifications de la cohérence	Concordance
Emplacement de l'établissement de traitement	Établissement de santé	Établissement de santé ou unité de surveillance notifiant les données (y compris les postes publics, privés, mobiles et les groupes d'enquête de district)			
	District	District notifiant des données			
	Province	Province notifiant des données			
Diagnostic et traitement	Date de survenue des symptômes (jj/mm/aa)	Date à laquelle le patient a commencé à éprouver des symptômes	✓	✓	✓
	Date du diagnostic (jj/mm/aa)	Date à laquelle le paludisme a été confirmé par un test diagnostique (TDR, microscopie, PCR, autre)	✓	✓	✓
	Méthode de confirmation du diagnostic	TDR, microscopie, PCR, autre	✓		
	Espèces identifiées	<i>P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P. vivax, P. knowlesi,</i>	✓		✓
	Date d'instauration du traitement (jj/mm/aa)	Date à laquelle la première dose de traitement antipaludique a été administrée. Dans certains pays, il peut s'agir de la même date que la date du diagnostic.	✓	✓	✓
	Traitement prescrit	Type de traitement antipaludique administré	✓		
Notification et enquête du cas	Issue de la maladie	Patient admis à l'hôpital, autorisé à sortir, décédé, perdu de vue	✓		✓
	Date de notification du cas (jj/mm/aa)	Date à laquelle le cas a été notifié	✓	✓	✓
	Déplacement récent à l'intérieur du pays (O/N, réponse rouge si O)	Au cours des 30 derniers jours	✓		

Thème	Variable	Informations complémentaires	Variables de base (exhaustivité)	Vérifications de la cohérence	Concordance
Notification et enquête du cas	Nom de la région/du district, nom de la ville/du village de destination	Lieu où le patient s'est rendu	✓		
	Dernière nuit (passée dans le pays) (jj/mm/aa)	Date de la dernière nuit passée dans la région où le patient s'est rendu dans le pays	✓		
	Première nuit (passée dans le pays) (jj/mm/aa)	Date de la première nuit passée dans la région où le patient s'est rendu dans le pays	✓		
	Déplacement récent à l'extérieur du pays (O/N, réponse rouge si O)	Au cours des 30 derniers jours	✓		
Notification et enquête du cas	Nom du pays de destination	Pays dans lequel le patient s'est rendu	✓		
	Dernière nuit (passée à l'extérieur du pays) (jj/mm/aa)	Date de la dernière nuit passée dans la région où le patient s'est rendu à l'extérieur du pays	✓		
	Première nuit (passée à l'extérieur du pays) (jj/mm/aa)	Date de la première nuit passée dans la région où le patient s'est rendu à l'extérieur du pays	✓		
	Classification finale du cas	Autochtone, introduit, importé, de recrudescence, induit, non encore classé	✓		✓

Thème	Variable	Informations complémentaires	Variables de base (exhaustivité)	Vérifications de la cohérence	Concordance
Investigation de routine des foyers	Cas ayant fait l'objet d'une investigation (O/N)	Le cas index a fait l'objet d'une investigation (examen et compilation des informations/entretiens, dépistage des membres du ménage, enquêtes auprès des ménages voisins, investigation de routine du foyer, mécanismes d'intervention pour le dépistage et la lutte antivectorielle)	✓		
	Date d'investigation du cas (jj/mm/aa)	Jour de suivi du cas index au niveau du ménage	✓	✓	✓
	Lieu de l'investigation (coordonnées GPS)	Emplacement de la source probable d'infection	✓		
	Date d'investigation du foyer (jj/mm/aa)	Date d'investigation de routine du foyer	✓	✓	✓

Annexe 5. Vérifications de la cohérence entre les variables de base pour le CQD

Contextes de réduction de la charge

Variables prioritaires			
1	Testés par TDR	≥	Positifs par TDR
2	Testés par microscopie	≥	Positifs par microscopie
3	Patients ambulatoires, toutes causes confondues	>	Nombre total de cas de paludisme
4	Patients hospitalisés, toutes causes confondues	>	Patients hospitalisés atteints de paludisme
5	Décès, toutes causes confondues	>	Décès de patients atteints de paludisme hospitalisés
6	Cas confirmés de paludisme ^a	≥	Cas confirmés de paludisme ayant reçu un traitement de 1 ^{re} intention (y compris une CTA)

Variables facultatives

7	Cas suspects	≥	Testés par microscopie + testés par TDR
8	Cas de paludisme, tous âges confondus	>	Cas de paludisme, < 5 ans
9	TPIg _{x+1}	>	TPIg _x (où x = dose 1 à 3)
10	Soins prénatals _x (où x = visite)	≥	TPIg _x (où x = dose 1 à 4)
11	Somme des espèces de plasmodies	≤	Cas confirmés de paludisme

CTA : combinaison thérapeutique à base d'artémisinine

^a Vérification de la cohérence entre les indicateurs connexes à inclure dans un EQD, recommandée par l'OMS, pour plusieurs maladies ; réalisée par le SGIS (15). Noter que cela ne peut être effectué que si des cas confirmés de paludisme ayant reçu des traitements de 1^{re} intention (y compris une CTA) sont consignés.

Contextes d'élimination

Variable			
1	Date de survenue des symptômes (jj/mm/aa)	≤	Date du diagnostic (jj/mm/aa)
2	Date du diagnostic (jj/mm/aa)	≤	Date d'instauration du traitement (jj/mm/aa)
3	Date du diagnostic (jj/mm/aa)	≤	Date de notification du cas (jj/mm/aa)
4	Date de notification du cas (jj/mm/aa)	≤	Date d'investigation du cas (jj/mm/aa)
5	Date d'investigation du cas (jj/mm/aa)	≤	Date d'investigation du foyer (jj/mm/aa)

Annexe 6. Vérifications de la cohérence des indicateurs de base au fil du temps pour le CQD

III

Ces indicateurs ne sont généralement pas consignés directement dans une base de données de surveillance (p. ex. DHIS2) mais sont des calculs basés sur les variables de base collectées. La cohérence au fil du temps doit être mesurée pendant au moins 3 ans.

Contextes de réduction de la charge

Indicateur	Définition	Numérateur	Dénominateur
1 Proportion de patients ambulatoires atteints de paludisme	Proportion de tous les patients fréquentant un établissement de soins ambulatoires qui sont des cas présumés ou confirmés de paludisme (nombre de cas de paludisme)	Nombre de cas de paludisme (confirmés + présumés)	Nombre total de patients ambulatoires, toutes causes confondues
2 Proportion de patients hospitalisés atteints de paludisme	Proportion de patients admis à l'hôpital atteints de paludisme	Nombre d'hospitalisations ou de sorties de patients atteints de paludisme	Nombre total d'hospitalisations ou de sorties de patients
3 Proportion de décès chez les patients hospitalisés atteints de paludisme	Proportion de tous les décès dus au paludisme chez les patients hospitalisés	Nombre de décès dus au paludisme chez les patients hospitalisés	Nombre total de décès chez les patients hospitalisés
4 Taux de positivité des tests	Proportion de résultats positifs parmi tous les tests effectués par microscopie et/ou TDR	Nombre de cas de paludisme positifs par microscopie et/ou TDR	Nombre de patients testés par microscopie et/ou TDR
5 Taux de positivité des lames	Proportion de résultats positifs parmi tous les tests microscopiques effectués	Nombre de cas de paludisme positifs par microscopie	Nombre de patients testés par microscopie
6 Taux de positivité des TDR	Proportion de résultats positifs parmi tous les TDR effectués	Nombre de cas de paludisme positifs par TDR	Nombre de patients testés par TDR

Indicateur	Définition	Numérateur	Dénominateur
7 Proportion des cas suspects testés	Proportion de cas suspects de paludisme ayant subi un test parasitologique (examen microscopique ou TDR)	Nombre de cas suspects de paludisme ayant subi un test parasitologique (examen microscopique ou TDR)	Nombre de cas suspects de paludisme (ou suspects = testés + cas présumés si les cas suspects de paludisme ne sont pas consignés directement à partir des registres des départements de soins ambulatoires)

Contextes d'élimination

Consistency over time for core indicators

1	Nombre de cas confirmés de paludisme notifiés
2	Nombre de cas confirmés de paludisme ayant fait l'objet d'une investigation
3	Nombre de cas confirmés de paludisme classés
4	Nombre de cas confirmés de paludisme classés comme locaux (autochtones + introduits)
5	Nombre de cas confirmés de paludisme classés comme autochtones
6	Nombre de cas confirmés de paludisme classés comme introduits
7	Nombre de cas confirmés de paludisme classés comme importés
8	Nombre de cas de paludisme dus à <i>P. falciparum</i>
9	Nombre de cas de paludisme dus à <i>P. vivax</i>
10	Nombre de cas de paludisme dus à <i>P. malariae</i>
11	Nombre de cas de paludisme dus à <i>P. ovale</i>
12	Nombre de cas de paludisme dus à <i>P. vivax</i>

**Pour plus d'informations, veuillez
contacter:**

Organisation mondiale de la Santé
20 Avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse
Email: GMPinfo@who.int